

terapia familiar

ESTRUCTURA, PATOLOGIA Y TERAPEUTICA
DEL GRUPO FAMILIAR

13/14

MARIA INES DATES

La provocación terapéutica

CARLOS SREBROW

Familia y empresa. Conflicto y cambio en organizaciones familiares. Del grupo a la institución.

NIDIA MADANES

Los mitos terapéuticos

CARLOS DIAZ USANDIVARAS

Abordaje familiar en el tratamiento de la drogadicción juvenil

ESTRELLA JOSELEVICH - MARIA ESTER PANIZO

Informe preliminar de una investigación: desarrollo de intervenciones terapéuticas alternativas

CARLO RICCI - MARA SELVINI-PALAZZOLI

Complejidad interaccional y comunicación

M. HERNANDEZ - F. PRIALE - A. FISZBEJN

Estructura y proceso en la Terapia Familiar

JULES C. ABRAMS - FLORENCE W. KASLOW

Los trastornos del aprendizaje y la dinámica familiar. Una interacción mutua.

ARTURO ROIZBLATT S.

La Terapia Familiar: una aproximación distinta al alcoholismo.

RODOLFO DE BERNART

La función del grupo en la formación del terapeuta familiar

Diálogo entre el Dr. Gianfranco Cecchin y el Dr. Alfredo Canevaro

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica del grupo familiar

Año VII - N° 13/14 - Junio de 1985

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Asistente de Dirección

Lic. Inés Dates

Coordinadora General

Lic. Fanny Levinton de Baranchuk

Consejo de Redacción

Maurizio Andolfi (Roma)

Isidoro Berenstein (Buenos Aires)

Rodolfo de Bernart (Florencia)

Donald Bloch (New York)

Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)

Ives Colas (Lyon)

Alberto Eiguer (Buenos Aires -
París)

Craig A. Everett (Florida)

Jorge García Badaracco (Buenos
Aires)

J. Howells (Ipswich - Inglaterra)

Florence Kaslow (West Palm Beach
- Florida)

Raymundo Macías (México)

Juan C. Nocetti (Buenos Aires)

Reynaldo Perrone (Rosario, Argen-
tina - St. Etienne, Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)

Jacques Rudrauf † (París)

Alberto Serrano (Buenos Aires -
San Antonio - Texas)

Mara Selvini-Palazzoli (Milán)

Robin Skynner (Londres)

Carlos Sluzki (Buenos Aires - Berk-
shire - Massachusetts)

Helm Stierlin (Heidelberg)

Guillermo Vidal (Buenos Aires)

Gerald Zuk (Nueva Orleans)

Israel Zwerling (Filadelfia)

Comité de Redacción

Lic. Fanny L. de Baranchuk

Lic. Inés Dates

Dr. Carlos Díaz Usandivaras

Dr. Fernández Moya (Mendoza)

Dr. Lino Guevara (Neuquén)

Lic. Sara B. Jutoran

Dres. Fidel y Elena Lebensohn
(Rosario)

Dr. Rafael Skiadaressis

Directores de Sección

Relaciones Interprovinciales

Dr. Fernández Moya

*Relaciones Internacionales y Publi-
caciones Extranjeras*

Lic. Sara B. Jutoran

*Ateneos Clínicos y Mesas Redon-
das*

Dr. Rafael Skiadaressis

Proyectos de Investigación

Lic. Inés Dates

*Derecho de Familia y Terapia Fa-
miliar*

Dr. Carlos Díaz Usandivaras

Epistemología

Lic. Elena Lebensohn

Dr. Fidel Lebensohn

Prevención y Salud Familiar

Lic. Fanny L. de Baranchuk

Director Administrativo

Alberto Cattán

Asesor Editorial

Alfredo Carlino

Asesor Gráfico

Patricia Luppi

TERAPIA FAMILIAR es una publicación semestral de Edi-
ciones Terapia Familiar, Casilla de Correo 94, Suc. 28,
Buenos Aires, Argentina. Acogida a la protección de las
Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos
de autor. Nombre de la Revista registrado como marca.
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nro. 273.972.
Coordinación gráfica: Patricia Luppi, Tel. 33-3041, int. 505
Registro Internacional de Publicaciones Científicas ISSN
0325-5905.

INDICE

EDITORIAL	5
MARIA INES DATES	
La provocación terapéutica	11
CARLOS E. SREBROW	
Familia y empresa: conflicto y cambio en organizacio- nes familiares	33
NIDIA MADANES	
Los mitos terapéuticos	47
CARLOS MARIA DIAZ USANDIVARAS	
Abordaje familiar en el tratamiento de la drogadicción juvenil	67
ESTRELLA JOSELEVICH - MARIA ESTER PANIZO	
Informe preliminar de una investigación: desarrollo de intervenciones terapéuticas alternativas	89
CARLO RICCI - MARA SELVINI-PALAZZOLI	
Complejidad interaccional y comunicación	109
MAX HERNANDEZ - FERNANDO PRIALE - ALBERTO S. FISZBEJN	
Estructura y proceso en la terapia familiar	127
JULES C. ABRAMS, - FLORENCE W. KASLOW	
Los trastornos del aprendizaje y la dinámica familiar. Una interacción mutua.	143
ARTURO ROIZBLATT S.	
La terapia familiar: una aproximación distinta al alcoho- lismo	163

INDICE

RODOLFO DE BERNART

La función del grupo en la formación del terapeuta familiar	175
--	-----

DIALOGOS

Diálogo entre el Dr. Gianfranco Cecchin y el Dr. Alfre- do Canevaro	193
--	-----

INFORMACIONES	203
---------------------	-----

OBITUARIO

Ruth Bellotini (2-7-1937 - 16-8-1984)	205
---	-----

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES	207
--------------------------------------	-----

Este volumen doble, aparecido con varios meses de retraso, contiene a la vez otra dualidad: marca el fin de una etapa y el comienzo de otra.

Si bien la revista nació el 7 de julio de 1977, su primer número apareció en marzo de 1978 significando la concreción de algo muy querido, objeto a la vez de tantas luchas y esfuerzos, tantas satisfacciones y logros.

Ya es hora de hacer un balance y si bien sólo el tiempo marcará sus defectos y virtudes, ya tenemos hechos significativos.

Primero y ante todo, contribuyó de gran manera a delinear el espacio de la terapia familiar, en otras épocas la Cenicienta de la psicoterapia. Dar a conocer alrededor de un centenar de trabajos de autores argentinos, reunir información y bibliografía, y abrir estas páginas para las producciones ya clásicas, ya novedosas de los autores extranjeros, fueron tarea de cada número. Esto nos dio orgullo, pero quizás lo más significativo fue el espíritu de estudiantina que campeó por estas páginas.

Esta revitalización es algo que la terapia familiar representa dentro del campo de la salud mental y que da sentido a nuestra tarea de terapeutas. Por otra parte, esta vocación representa un homenaje a nuestras propias familias, ahí donde aprendimos a sufrir y a querer, y a buscar un camino que a la vez que era una salida, nos hacía entrar en otra larga etapa de concreción social de aquel aprendizaje. Estas raíces emocionales, si bien se prestan para un cierto misticismo, son a la vez la fuerza avasallante de la que se nutre este paradigma científico, motor de otros nuevos que le sucedan en el devenir epistemológico.

De más está hablar sobre las dificultades que encontramos en todos estos años. Este número tiene el mérito paradójico de significarlo, pues sólo puede salir gracias a un subsidio que nos otorgó la revista *Family Process*.

Desde estas páginas queremos agradecer públicamente al Dr. Carlos Sluzki, brillante terapeuta argentino quien desde las más altas posiciones de la especialidad en Estados Unidos y en el mundo, tuvo esta iniciativa, mostrando la nobleza de aquellos que no olvidan años difíciles. Igualmente al Dr. Lyman Wynne, científico pionero de la Terapia Familiar, que en su función de presidente del Board of Directors, supo reconocer los méritos de nuestra publicación.

Y así llegamos entonces a este momento en que comienzan a cumplirse algunas de nuestras predicciones (Cf. Editorial N° 3). Están a punto de aparecer otras publicaciones que confirman la presencia de la escuela argentina de terapia familiar. Tenemos, como nuestro país, todo para conseguir un futuro brillante, si aceptamos este desafío con coraje y con inteligencia.

* * *

Se imponen los cambios como un salto cualitativo de nuestra revista, y en ello está todo involucrado, menos nuestras convicciones, que siguen siendo las mismas, renovadas.

Siempre tuvimos colaboradores directos e indirectos que

contribuyeron con esta publicación —a quienes nuevamente agradecemos su generosidad—. Creemos que la ayuda inestimable de nuevos colegas, nos brindará un aporte orgánico y funcional para esta etapa que se inicia.

La revista continuará apareciendo periódicamente, dedicando cada número a temas específicos, y manteniendo su perfil original que la ha caracterizado entre otras en el mundo. Es decir, la mezcla armónica de autores nacionales y extranjeros, los ateneos clínicos y mesas redondas, y los Diálogos.

No sólo se diferenciará por aplicarse a temas de indudable importancia para el lector, sino que contará cada número con Editores invitados que aportarán su solvencia en el tema, configurando un real trabajo en equipo en el nivel nacional.

A fines de 1985 aparecerán los dos números del volumen VIII, dedicados, uno a Divorcio y nuevas organizaciones familiares, dirigido por el Dr. Carlos Díaz Usandivaras, y el otro a Epistemología sistémica y terapia familiar, dirigido por el Dr. Fidel Lebensohn y la Lic. Elena de Lebensohn. Está preparándose para 1986 el volumen IX, cuyo primer número se dedicará a Terapia familiar y proceso terapéutico, dirigido por el Dr. Alberto Loketek y la Lic. Estrella Joselevich; mientras el segundo lo hará sobre Familia y drogadicción, dirigido por la Lic. María Rosa Glasserman.

Así seguirán apareciendo números que contarán con la experiencia y dedicación de investigadores argentinos que enriquecen nuestra profesión.

* * *

La aparición de nuevas secciones va dando forma a necesidades de los lectores y de la revista. Una de ellas, la de Relaciones Internacionales y Publicaciones extranjeras, dirigida por la Lic. Sara B. Jutorán, tendrá la función de sistematizar el contacto con otras publicaciones similares en el mundo y organizará una Revista de revistas; que sobre cada tema específico agrupará los artículos aparecidos.

La de Epistemología, dirigida por el Dr. Fidel Lebensohn y

la Lic. Elena de Lebensohn, concentrará tanto las inquietudes de los lectores como los artículos originales sobre el tema. La sección de Relaciones Interprovinciales, dirigida por el Dr. Jorge Fernández Moya, tendrá la función de coordinar los aportes de autores del interior, que para una mayor funcionalidad deberán contactarse con: región del Litoral y Noreste, Dres. Lebensohn; región Central y Noroeste, Dr. J. Fernández Moya y región Sur, Dr. Lino Guevara.

Otras secciones son: la de Prevención y Salud Familiar, dirigida por la Lic. Fanny L. de Baranchuk, que estará destinada a coordinar todos los aportes sobre el tema y difundirá información bibliográfica al respecto. La de Ateneos Clínicos y Mesas Redondas, dirigida por el Dr. Rafael Skiadaressis, colaborador inestimable de la primera hora, quien continuará coordinando estas tareas sobre los temas específicos de cada número. La de Proyectos de investigación dirigida por la Lic. Inés Dates, se encargará de reunir todas esas ideas, esos proyectos, esas intervenciones que no llegan a conformar un artículo pero que constituyen la reflexión sobre un quehacer siempre en movimiento.

Y finalmente, la sección de Derecho de Familia y Terapia Familiar, dirigida por el Dr. Carlos Díaz Usandivaras, tratará sobre la interrelación entre la organización familiar y sus aspectos jurídicos.

Asimismo, la creación de dos funciones vitales para la revista en el área ejecutiva permitirá, con el aporte de las licenciadas Fanny Levinton de Baranchuk e Inés Dates, dotar a la Dirección de un mayor respaldo para una tarea que, paradójicamente, al diluirse se hace más pertinente.

Solo nos resta esperar el apoyo de todos nuestros lectores, y que los vientos australes nos traigan vigor y nuevos suscriptores.

Muchas gracias.

El Director

EDITORIAL

Direcciones de los miembros del Comité de Redacción:

- Lic. Fanny Levinton de Baranchuk
Arenales 3724, 8o., A
1425 Buenos Aires
Tel. 72-4796
- Lic. Inés Dates
Montes Grandes 1032
1640 ACASSUSO
Tel. 792-6888
- Dr. Carlos María Díaz Usandivaras
Acassuso 907
1642 SAN ISIDRO
Tel. 743-8645
- Dr. Jorge Fernández Moya
Babilonia 10, 1o.
5.500 MENDOZA
Tel. 061-246215
- Lic. Sara B. Jutorán
Zabala 1881, p. 19
1426 Buenos Aires
Tel. 782-3059
- Dres. Fidel y Elena Lebensohn
Tucumán 1060, P.B.
2000 ROSARIO
Tel. 041-67038
y 041-48438
- Dr. Rafael Skiadaressis
Blanco Encalada 2222, 2o., B
1428 Buenos Aires
Tel. 781-0880
- Dr. Lino Guevara
Juan B. Justo 574
8300 NEUQUEN

La provocación terapéutica

Lic. MARIA INES DATES

Montes Grandes 1032, (1640) Acassuso, Prov. de Buenos Aires,
Tel. 792-6888

(Una primera versión de este artículo fue presentada en las Jornadas que sobre Provocación se hicieron en el CefyP, el 7 de agosto de 1983).

A fines de la década del 70 Italia aparece en el horizonte de la terapia familiar. Primero Milán y después Roma nos sorprenden con sus originales propuestas para el tratamiento de los trastornos mentales más graves.

Lo que sigue es un análisis de la intervención terapéutica característica del equipo del Istituto di Terapia Familiare de Roma, que dirige Maurizio Andolfi, a la que han denominado PROVOCACION.

El modelo terapéutico desarrollado en el Istituto di Terapia Familiare es un modelo que puede caracterizarse como estratégico-estructural.

Estratégico, según la palabra introducida por J. Haley, designa a un tipo de terapia, en la que el terapeuta es concebido como activo agente de cambio, en el sentido de promoverlo y de tomar responsabilidad por lo que ocurre durante la terapia. El terapeuta de esta corriente diseña una estrategia particular para cada problema que se le presenta. Y aunque en este sentido, los terapeutas estructurales serían

MARIA INES DATES

también "estratégicos", el término ha terminado por aplicarse fundamentalmente a los modelos más centrados en la implementación de intervenciones indirectas o paradójales, para lograr los cambios buscados (aunque no sean las únicas que se utilizan).

El modelo estructural, por su lado, centra sus intervenciones en la modificación de la estructura familiar (límites y jerarquías), pues entiende que la conducta sintomática está asociada a relaciones no funcionales entre los subsistemas que conforman el sistema familiar.

Andolfi y sus colegas caracterizan su modelo de trabajo como una combinación, o más bien alternancia, de principios estructurales y estratégicos, dependiendo del nivel de rigidez homeostático de la familia con la que se enfrentan.

En familias con pacientes graves y, por lo tanto, de gran rigidez, comienzan la terapia con un enfoque estratégico y, al disminuir esa rigidez, la continúan de forma más estructural.

La intervención que voy a analizar corresponde al primer momento, "estratégico", de su modelo terapéutico.

Y dado que esto es así, me parece lícito recordar los orígenes de la terapia "estratégica".

Y pensar en los orígenes nos lleva a pensar en la década del 50, y nos lleva a recordar lo que aquí quiero caracterizar como la raíz *científico-estética* y la raíz *pragmática* de este modelo.

Me refiero al proyecto Bateson, y a la enorme y continua influencia de este pensador en la plasmación de las bases teóricas sobre las que se está edificando el edificio de la terapia familiar y también me refiero a Milton Erickson, el creador de técnicas terapéuticas tan innovadoras y exitosas, que llamaron la atención de J. Haley y John Weakland, participantes del proyecto Bateson, y que a través de ellos (principalmente del primero) han influido decisivamente en el modelo estratégico de Terapia Familiar. Estas técnicas, surgidas de la enorme experiencia de Erickson en hipnosis, dieron a este modelo su "estilo" indirecto invertido y/o paradójal.

Y es en el concepto de paradoja aplicado a la pragmática de las relaciones humanas, donde se encuentran estos dos gigantes:

Bateson, a través del estudio de la comunicación esquizofrénica y el concepto de doble vínculo;

Erickson, con la implementación de técnicas indirectas, muchas veces paradójales, en su novedoso estilo de terapia.

Bateson, proporcionando la base científica y epistemológica, que apoyó y dio "legalidad" a las "no convencionales" técnicas de Erickson. Y estas técnicas proveyendo el arsenal de intervenciones, que convirtieron el pensamiento batesoniano y a la teoría del doble vínculo en un modelo terapéutico poderoso.

Entremos entonces ahora a examinar la intervención terapéutica llamada *provocación* por el grupo de Roma.

Antes que nada, recordemos que la provocación es propuesta como intervención privilegiada para operar con las familias que denominan "rígidas" por su marcadísima dificultad para efectuar los cambios necesarios para responder a las cambiantes necesidades de sus miembros; dicho esto mismo con otro recorte, así llamadas por el predominio de la tendencia a la estabilidad por sobre la tendencia a la transformación (ambas inherentes a todo sistema viviente).

Y recordemos también que este momento estratégico es abandonado en favor de técnicas estructurales, cuando la provocación ha cumplido su objetivo y la familia inicia el proceso de cambio necesario para su evolución.

Las familias rígidas, entonces, son aquellas que tienen "escasa capacidad de cambiar en el curso del tiempo el equilibrio entre las *funciones* desarrolladas por sus miembros, dentro del sistema familiar (estado de cohesión), y el *crecimiento* y necesaria individuación de cada uno de ellos (estado de diferenciación)" (2).

Esta acumulación de funciones o la incapacidad de variarlas en el transcurso del tiempo (y hablar de tiempo es hablar de ciclo vital), pesan sobre la individuación —diferenciación de sus miembros—, llevando a alguno de ellos a una situación insostenible, al someterlo a demandas simultáneas de carácter contradictorio (Ej.: "ser el bebé de mamá y tener una sexualidad adulta").

Y la "enfermedad" es la respuesta a esta situación.

Como vemos, en el centro del modelo de comprensión con que el Grupo de Roma enfoca su quehacer, tenemos a la *familia como un sistema relacional* por un lado y, por el otro, al *individuo y su proceso de diferenciación*, sin que ninguno prevalezca sobre el otro.

Dentro de estas familias "rígidas", "el predominio de las relaciones a nivel "función" sobre las individuales, o más bien, personales (es decir, diferenciadas), conduce a una intrusión constante en el espacio personal del otro, a través de la pérdida del propio espacio personal, viviendo sus miembros en una especie de función recíproca uno por el otro". (2).

Esta necesidad de vivir en función del otro (lectura a nivel "miembros") es lo que rigidifica al sistema familiar (lectura "meta"). O como queramos puntuar este fenómeno unitario con fines descriptivos.

La *PROVOCAION* sería el estilo comunicativo imperante en estas familias, ya que por sus características permite a los miembros de un sistema con esta cualidad de rigidez, el asegurarse que el otro (que me es imprescindible, pues existo en función de él) no va a constituir su autonomía antes que yo esté preparado a constituir la mía.

Y entonces, ¿qué es una provocación?

... "Una comunicación cuya finalidad no es explícita, capaz de influenciar a una persona al punto de hacerle realizar actos fuera de su voluntad", dice Piperno. "Por medio de la provocación se pone a prueba el estado de autonomía del otro, si éste acepta mi provocación, si cede a mi trampa, quiere decir que todavía está lejos de poseer una identidad propia como "persona" y, por lo tanto, me puedo reasegurar que no podrá separarse de mí antes que me aleje yo de él". (11).

Vale decir, que la provocación es consecuencia y causa de la necesidad de control estricto que los miembros de una familia rígida necesitan ejercer unos sobre otros, para asegurarse de que nadie cambie, para evitar la temidísima crisis, visualizada como consecuencia necesaria de cualquier cambio.

De esta necesidad de control estricto deriva la parte ho-

meostática (H) del mensaje con que la familia se acerca a la terapia: "Ayúdeme a cambiar sin cambiar las reglas". Tendencia homeostática acrecentada al percibir al terapeuta como agente de cambio.

El dilema del terapeuta consiste en su necesidad de enviar un mensaje que sostenga a la tendencia a la transformación (T), sin que (H) se sienta obstaculizada.

La solución consiste en responder a este mensaje contradictorio con una intervención que enfoque justamente el aspecto provocador del mensaje de la familia al terapeuta: la contraprovocación o provocación terapéutica.

En términos sistémicos, como sabemos, la solución consiste en amplificar (H), utilizándolo ya no en oposición a (T), sino en su sostén.

Y como también sabemos, esta es una forma de caracterizar a una intervención *paradojal*.

La provocación terapéutica, entonces, es una *intervención paradojal*, y en ese sentido fiel al espíritu de la tradición ericksoniana del modelo estratégico en terapia familiar.

De la infinitud de comentarios que se podrían hacer sobre las intervenciones paradojales, me interesa acá recordar algunas explicaciones de su poder terapéutico.

Para ello me remito a J. Bogdan (3), quien da varias explicaciones de su eficacia, considerando que no todas actúan en cada caso particular.

Veamos sólo cuáles son esgrimidas por Andolfi et al., para dar cuenta de su trabajo:

- a) Función de "*joining*" o de unión con la familia, vehiculizada por la connotación positiva de su conducta. Esta, a nivel "sistema" apunta a un desbalanceo en el necesario interjuego T-H, pero a nivel "universo simbólico de cada individuo o de la familia como grupo que comparte una construcción determinada de la realidad", la connotación positiva es una maniobra de unión (*joining*).
- b) *Redefinición*: la familia llega a la terapia con una definición tanto de sí misma como del problema que la perturba y de

lo que lo causa. Si el terapeuta acepta estas definiciones, su operar estará necesariamente guiado por ellas, y por ello también necesariamente quedará preso de las reglas interaccionales que dirigen el juego familiar, reglas de las que estas definiciones son expresión simbólica.

Si combate frontalmente estas definiciones, también acepta este recorte de la familia, aunque sea desde el rechazo.

La intervención paradojal, al aceptar en una misma formulación las contradictorias fuerzas que ha originado la enfermedad por la que consulta la familia, evita caer en la trampa de dicotomías que "destrozan la ecología del espíritu", como diría Bateson, y que se transforma en líneas de trincheras de estériles batallas sin fin.

El terapeuta, por lo tanto, redefine la concepción con que llega la familia, de forma tal, que modifica los constructos simbólicos sobre los que se apoya la trama relacional cotidiana de ésta.

Más específicamente, el terapeuta *redefine el problema* por el que consultan, llevándolo de individual y desvalorizador a relacional y funcional al mantenimiento de la interacción familiar; y *redefine también el contexto*, y en ese nuevo contexto creado por el terapeuta, la conducta "loca" o "involuntaria" del paciente designado, se transforma en voluntaria y normal; en adecuada y hasta necesaria para ese nuevo contexto. (Ej.: síntoma como ayuda).

Esta redefinición está acentuada por el estilo mimético del terapeuta, que "dice" - "hace" en los mismos términos que el paciente, normalizándolos tácitamente. (Con el extraordinario valor pragmático de lo tácito).

- c) Lo anteriormente analizado, además, actúa *retirando refuerzos*, en la medida en que, al normalizar y definir como voluntaria la conducta sintomática del paciente, priva a éste del poder que le otorga su conducta bizarra.
- d) A veces vemos explicaciones que parecen buscar el efecto de *eliminar la ansiedad causada por el intento de controlar el problema*. Como ejemplo, valga la frase: "Una vez que

los miedos son traídos a la luz, pierden su poder destructivo...".

- e) Pero de todos los mecanismos actuantes en las intervenciones paradójales, el principal ingrediente subrayado por los autores de la provocación terapéutica, es lo que Bogdan llama "*provocar desafío*", y que explica dentro de una óptica a nivel "miembros", con la teoría de la disonancia cognitiva:

Esta afirma que, dada la redefinición que hace el terapeuta de su conducta, los miembros de la familia se encontrarían frente a una imagen de sí mismos inaceptable, por lo que se verían forzados a cambiar las conductas que, según el terapeuta, están asociadas a esa imagen de sí mismos "tóxica".

Contamos para ello con la fuerza de la necesidad de que el "otro" coincida con nuestra definición de nosotros mismos. Recordemos los trabajos de Laing sobre la búsqueda de confirmación de la propia identidad en el otro, y la función básica que Watzlawick le atribuye a esta búsqueda de confirmación en la misma génesis del desarrollo de la comunicación humana. (9) - (13).

De hecho, todas las explicaciones que preceden están amalgamadas en cada intervención particular, pero valga esto como momento de reflexión.

Además, quisiera recordar con Lynn Hoffman que, por encima de todas estas explicaciones particulares, "agregar una interpretación positiva a la habitualmente negativa en las conductas sintomáticas no es sólo una estrategia para el cambio, sino fundamentalmente una forma de agregar una capa más de complejidad, que nos guarda del pensamiento lineal"...

Esto no es decir que una connotación positiva es menos lineal que una negativa, pero en este caso, dos "lineales" pueden hacer una "circular", igual que Yin más Yan pueden hacer un círculo" (6).

Es decir, que juntas pueden constituir esa "visión binocular" de que habla Bateson en "Espíritu y Naturaleza" (7).

(Y recordemos que para Bateson la epistemología es un asunto moral, además de científico, cuando nos sentimos "manipuladores").

Pero más que analizar los elementos comunes de la provocación con las intervenciones paradójales, me parece oportuno señalar algunos caracteres que le son distintivos:

- I. Acento en lo emocional.
- II. Inmediatez.
- III. Mimética con la familia.
- IV. Imprevisibilidad.
- V. Alta involucración personal del terapeuta.
- VI. Individual-sistémica.
- VII. Construcción retórica particular.
- VIII. Centralidad del terapeuta.

Antes de analizar estos puntos, quiero presentar un ejemplo, a esta altura ya clásico, de lo que Andolfi et al. llaman provocación terapéutica:

"Marco tiene 16 años. Desde hace unos meses dice ser un indio e imita sus actitudes. Por teléfono, la madre dice sentirse muy preocupada por esto, pero lo vívido y minucioso de la descripción de las actitudes "apache" del hijo, contrastando con la monotonía con que habla de su vida familiar, hacen que el terapeuta se encuentre atrapado en el siguiente pedido: "Ayúdeme a hacer cambiar de conducta a Marco, siendo esa conducta el único motivo de interés en mi vida".

Veamos la primera sesión:

Madre (mientras el terapeuta entra): "Buenas tardes".

Terapeuta (apretándole la mano): "Encantado de conocerla. ¿Hablé con usted por teléfono?"

Madre: "Sí, conmigo".

Terapeuta (indicando a Marco que está de pie con un brazo levantado y un aire teatral): "Oh, eres tú Toro Sentado? No sé

cómo se hace el saludo indio, tal vez así "Huammm" (con un aullido a lo indio).

Marco: "¿Pero, a quién quiere tomarle el pelo? "

Terapeuta: "Ah... ¿no hacen así? "

Marco (en tono gutural): "Vamos, ¡no bromeé! "

Terapeuta (con insolencia): "Nooo, si esta es una voz de cowboy y no de indio" (padre y madre ríen).

Marco: "Pues sí lo es. ¡Esa es una voz de indio! "

Terapeuta: "Según mi opinión no eres muy competente en ese campo. Mira, yo fui a ver películas de indios durante 12 años y te aseguro que esa es la voz del viejo del Oeste, y mal hecha además".

Marco: "Pero yo...".

Terapeuta (interrumpiéndolo): "¿Cuál es tu nombre, no el artístico, el otro? "

Marco (en tono enfático): "El nombre es aquel del Santo Evangelio: San Marco".

Terapeuta: "¿Cuál es tu característica más importante... San Marco? "

Marco: "Ninguna característica".

Terapeuta: "Oye, el mío es de un santo mártir y virgen, ¿tú qué eres? "

Madre (dirigiéndose a Marco): "¡Qué bien que actúas hoy! "

Terapeuta: "No señora, yo siento que no lo hace para nada bien. Es ridículo. (Se dirige a Marco). Sabes, aquí viene un montón de gente interesante, pero tú no eres siquiera interesante, eres sólo aburrido. Había entendido que eras creativo en materia de Apaches, tu mamá me nombró a los indios, tú, al contrario, te vas a los santos, te vas a los temas clásicos. Un aburrimiento mortal".

"Un aburrimiento mortal". El tema del aburrimiento, jamás admitido en esta familia, es introducido por el terapeuta por medio del paciente designado.

Con este ejemplo ante nuestra mirada, pasemos a analizar los elementos distintivos de la provocación:

I. Acento en lo emocional, con el consecuente clima de alta tensión *durante* las sesiones.

Porque dentro del efecto total del mensaje paradójico de la familia, los autores recortan su impacto en la emoción del terapeuta y no sus aspectos paralizadores del pensamiento. Y esto desde la elección del nombre de la intervención, que apunta a lo que despierta en el interlocutor: "que excita, incita o induce a uno a que ejecute algo".

Por el contrario, cuando hablamos de intervenciones paradójales el término "paradoja", con su contenido lógico, apunta al proceso de pensamiento.

"La tensión y la agresividad que estas situaciones normalmente generan en el terapeuta nos impulsaron a detenernos... en los elementos altamente provocativos de estos mensajes". (2).

Y es en estos elementos emotivos en los que basan su intervención, pues consideran que despertar la ira contra las debilidades propias es a menudo un estímulo constructivo para no sentirse más como víctimas y poder efectuar las elecciones imprescindibles para cualquier cambio, que son necesariamente personales.

Frente a un sistema paralizado en su evolución por el temor a una crisis visualizada como consecuencia necesaria de la renegociación de las relaciones entre sus miembros; en el que "se efectúa un estrecho control de la emotividad individual, a la que se sacrifica en nombre de una emotividad familiar no diferenciada" ... "no se puede hacer mucho si no se logra *crear un stress* tan fuerte como para obligar a alguien a romper la "lealtad familiar".

Es decir, que alguien debe sentir que es "más fácil reaccionar en forma diferenciada y personal a la provocación del terapeuta, que permanecer en el rol de intérprete fiel de una recitación reiterativa".

El terapeuta los empuja al límite de las consecuencias que acarrea el cumplimiento de su función dentro del sistema. De allí la elección de cambio que, lo mismo que la de no cambio,

“es de naturaleza emocional, una especie de reacción instintiva”.

Y es esta intensidad emotiva de las intervenciones provocadoras lo que evita que intentemos “derrumbar paredes” a golpes de “escarbadiente”: lo que les confiere su potencia terapéutica.

Pero además de intensamente emotiva, la provocación es:

II. **Inmediata**, pues es en función de ella como se leen los mensajes de la familia y como se responde a ellos desde el comienzo del vínculo terapéutico, aún antes de la primera sesión.

Y esta inmediatez en la intervención provocatoria apunta por un lado a promover un cambio en la familia por lo imprevisto de la intervención muy temprana, que hace más difíciles eventuales tentativas de compensación homeostática. Pero, por otro lado, y con el mismo peso, apunta a rescatar al terapeuta de su posible succión por un rol predeterminado por la familia, creado en función del rol cultural de “terapeuta” (que viene del modelo médico de diagnóstico con “terapéutica” a posteriori).

Esta inmediatez en la provocación podría aumentar el riesgo de interrupción precoz de la terapia, ya que, podría pensarse, sólo una relación de confianza ya establecida con el terapeuta permitiría a la familia tolerar el stress de la intervención provocativa.

La opinión de los autores en este sentido es que lo que hace que la familia se sienta sostenida (en el sentido de “holding”) es el impacto terapéutico. “Es justamente en base a la capacidad y a la rapidez que demuestra el terapeuta en apropiarse del control de la relación terapéutica y en romper los acostumbrados esquemas interactivos de la familia, que ésta se siente contenida y sostenida...”. “Esta seguridad del terapeuta en no dejarse envolver le permitirá aceptar los riesgos de un cambio guiado” (2).

La inmediatez en la intervención, entonces, debería ser hija de la seguridad, y no de las defensas “como si” del apresura-

miento o el pánico: deberían no ser una respuesta “indiferenciada” del terapeuta.

III. **Mimética** con la familia.

“Observando la intensidad y la calidad de las comunicaciones que nos envía la familia, hemos aprendido a responderle con una modalidad casi mimética, o sea, imitando ciertos mensajes y acentuando su intensidad en forma proporcional a aquella con que nos llegan” (2).

La razón de esta “mimesis” es, una vez más, el deseo de abandonar las intervenciones “escarbadiente” en pro de un mayor poder terapéutico: “No vemos ningún motivo —dice— para renunciar a aquellos instrumentos de control de la relación que confieren tanto poder a la familia. No sólo no renunciamos a ellos, sino que buscamos apoderarnos de ellos para incrementar la versatilidad de nuestros instrumentos... Si su gesticular, lenguaje, silencio, humorismo, dramaticidad, etcétera, pueden ser instrumentos de manipulación en las manos de la familia, ¿por qué presentarnos desarmados?”

Y esta es una buena pregunta.

IV. **Imprevisible**.

Esta cualidad de imprevisión aparece desde un primer momento en el hecho de que el terapeuta se alfe explícitamente al “no cambio”, cuando se lo está consultando como agente de cambio. El efecto desestabilizador de esta maniobra, para la que la familia no está preparada, es conocido por todos.

Ahora me interesa centrarme más bien en lo imprevisible del terapeuta durante el resto de la terapia.

El sistema familia/terapeuta establece, al cabo de unos pocos encuentros, las reglas que lo regirán. Estas reglas tácitas cobran rápidamente la fuerza de un mandato, al que es difícil desobedecer. Todos hemos sentido en mayor o menor medida esa fuerza de “inercia”, o el poder de atracción de “la imagen que yo creo que el otro tiene de mí” (como lo diría Laing) (10) y que nos mantiene atrapados en relaciones altamente estables.

Este es el momento en que advertimos que ya no pensamos en la familia como en un comienzo; el momento en el que el

equipo detrás del espejo se desinteresa del proceso en curso; ... y en el que multitud de señales más nos advierten del peligro: hemos conformado un sistema terapéutico rígido.

"Cualquier cosa predecible es terapéuticamente ineficiente", dice Selvini (11), y nada más predecible que un terapeuta sentado en su silla, repitiendo variaciones de su intervención básica, con un ritmo que le marca el sistema... y ¿nada más ineficiente?

La respuesta de Selvini es tajante, pero quiero hacer la salvedad que hablar de imprevisible es hablar a nivel del universo simbólico de los miembros de la familia, y no a nivel del sistema en sí. En este segundo nivel no se puede hablar de "imprevisible", ya que el sistema no "prevé", no tiene premisas, sólo redundancias en su devenir autorreflexivo.

Y Dell nos advierte de no confundir ambos niveles: al hablar del input que modificará el sistema familiar (o sea, que es terapéuticamente eficiente o útil) se refiere a él calificándolo como "nuevo" (y no como "imprevisible"). Y nuevo por definición: porque todo sistema cambiará si se le introduce un estímulo nuevo, ya que su coherencia deberá modificarse para adecuarse a él. Y, por ende, si el sistema cambió, el estímulo era nuevo.

O sea que aquí, en este nivel del sistema, es éste el que define si una intervención es o no nueva, y lo define operativamente, al cambiar o no. Y aquí también es equivocarse confundir lo que el terapeuta o los miembros de la familia consideran novedoso, con lo que el sistema, al reaccionar, define como tal.

Esto, unido a la noción de que la coherencia sistémica sólo se desarrolla en el tiempo, por lo que nunca es accesible en un momento determinado, nos permite diferenciar las intervenciones "útiles" y, por definición "nuevas" para el sistema global, en algunas que son menos radicales, y que "consisten en esos enfoques, a menudo sensatos, que pueden haber sido probados anteriormente con el paciente o la familia, pero que no fueron aplicados con suficiente margen de tiempo, con la suficiente consistencia o con suficiente poder, y que impactan al sistema-

que-existe-sólo-en-el-tiempo mediante una intervención firme y consistente, de suficiente duración, que primero lenta y luego repentinamente rompe y transforma la coherencia preexistente".

Y otras intervenciones, que son perturbaciones "nuevas" para el sistema, y que consisten en "aquellas directivas y reestructuraciones terapéuticas que, aplicadas de una vez, parecen atacar como un rayo y aturden al sistema haciéndolo cambiar: las intervenciones paradójicas" (5).

La elección del grupo de Roma es clara, y confirma la de Selvini: el terapeuta, para rescatarse del poder de succión del sistema familiar y mantenerse así terapéuticamente eficiente, debe mantenerse imprevisible para la familia. Debe, por decirlo así, crearse para sí mismo desde un comienzo una "regla de imprevisibilidad" que sea más fuerte que cualquier otra regla de las nacidas del encuentro con la familia.

Y no sólo los cambios en nuestra hipótesis introducen esa diversidad necesaria; todo lo analógico puede utilizarse con ese fin. Así el espacio, el tiempo, los ritmos, tonos de voz, gestos, objetos, otras personas del equipo o de la familia... y todo lo que nuestra inventiva nos señale, pueden ser instrumentos importantes en este hacernos "imprevisibles" y, por lo tanto, eficientes como agentes de cambio.

Pero esto requiere una

V. Alta involucración personal del terapeuta.

Porque en la medida en que éste es también un ser humano, participa de esta necesidad de buscar la seguridad en lo repetitivo, que nos hace reencontrarnos una y otra vez a nosotros mismos en el espejo de una interacción pautada rígidamente.

Dice Andolfi (2): "... estamos cada vez más convencidos que la facilidad con que muchos terapeutas caen en el juego de las partes asignadas no se debe sólo a la inexperiencia del terapeuta, sino que responde frecuentemente a *exigencias del terapeuta similares a las de la familia*, en el programar una relación altamente estable que no amenace su seguridad".

Porque si su objetivo es permitir a los miembros de la familia abandonar funciones reaseguradoras y buscar nuevos equilibrios entre el nivel funcional y el nivel de diferenciación de sí mismo, esto "significa que el terapeuta debe medirse con el grado de diferenciación de sí mismo, con su propio miedo de la locura y con los riesgos del cambio". Es decir, debe enfrentarse y poner a prueba su propia capacidad de unión y de individuación, o más bien, de individuación en la unión.

Como dice Katia Giacometti: "Más allá de rígidas teorizaciones, la terapia parece ser un adiestramiento de ambos componentes del sistema terapéutico (familia y terapeuta) para tolerar el caos y la angustia que inevitablemente acompañan un proceso de asociación y separación, en el cual se verifica el grado de rigidez y flexibilidad de la relación función-persona" (6).

Pero el estilo provocatorio requiere algo más del terapeuta: requiere una profunda confianza en su propia capacidad "reparatoria" (en el sentido kleiniano), que le permita prescindir de la inmediata confirmación del paciente en ese sentido, así como de lo sancionado como "correcto" por las reglas culturales de la profesión.

VI. Individual-Sistémica

La provocación se dirige a un individuo (en un comienzo especialmente al paciente identificado), pero esa intervención "individual" está inserta en una "sintaxis" relacional.

Y esto por varias razones:

- a) Como joining con la familia, de quien acepta tanto la definición del problema por el que consultan: "es él" (el paciente identificado) como también sus canales de comunicación habituales, que tienen a éste como pivote. "La intervención provocadora debe llevarnos a la comunicación con todos los miembros de la familia, utilizando el mismo camino que ellos emplean habitualmente para comunicarse entre ellos: El Paciente" (2).

- b) ... y desde esa aceptación se trabaja redefiniendo la conducta sintomática como *voluntaria y relacional*, siendo, por ende, necesario que continúe. "Nuestra respuesta contraprovocadora utilizará al mismo paciente identificado como punto de ataque al sistema... En lugar de contrarrestar su centralidad se la utiliza... si lo habían elegido como mediador de cada interacción, nosotros hacemos lo mismo con él, clavándolo así a su función".
- c) Y esta amplificación del nivel "función" tiende a provocar una diferenciación del/los individuos, por las razones que analizamos más arriba.
- d) Otra de las razones que avalan este modo de intervenir es que la inescrutabilidad de la conducta del paciente designado permite señalar arbitrariamente a éste como "causa" de muchos acontecimientos, aunque el terapeuta sabe que la "causa" sólo puede atribuirse a las reglas que rigen la interacción familiar.
- e) ... y si nos atacaran pruritos de no ser "sistémicos" en esta manera de intervenir, recordemos a Paul Dell cuando, citando a Maturana, dice que "pese a que se puede intervenir en un sistema de muchas maneras, *jamás se puede intervenir en el nivel del sistema en sí*, pues la coherencia sistémica es un fenómeno de orden superior... que necesita tiempo pues es autorecursiva. Sólo se puede intervenir a nivel de los componentes del sistema... El terapeuta está limitado a intervenir en el nivel que le es accesible —el nivel de los individuos...". (5).

VII. Construcción retórica particular.

Además de sus elementos emotivos, teatrales (exageración mimética) amplificados e impredecibles, la provocación como intervención terapéutica tiene una construcción retórico-pragmática particular, en la que se da por supuesto el acuerdo sobre el punto realmente importante, como si fuera evidente, y el terapeuta formula su intervención apuntando a un derivado de ese punto. Ej.: "Pero tú te haces más el indio cuando piensas

que mamá no aguanta más a papá o cuando se pone la máscara de la resignación? ”.

Esta es una construcción similar a una de las técnicas hipnóticas de Milton Erickson, en la que pregunta al sujeto resistente si quiere entrar en trance ahora o más tarde, con lo que se evita el tema de si quiere o no entrar en trance (7).

Entraría dentro de las estrategias de bloqueo del hemisferio izquierdo de que habla Watzlawick (14).

En este mismo sentido apunta el gran uso de lo no verbal en este modelo. “Las intervenciones más eficaces se sitúan a nivel implícito”, dicen, “utilizando en su mayor parte comunicaciones no verbales, que resultan menos manipulables y menos expuestas a respuestas defensivas”. (2).

Interesantemente, el último elemento que quería comentar con ustedes también tiene similitudes muy grandes con otra técnica hipnótica (o de bloqueo del hemisferio izquierdo).

Me refiero a lo que llamo:

VIII. Centralidad del terapeuta

Pues en esta técnica no se intenta de ninguna manera hacer comunicar a los miembros de la familia entre sí. Por el contrario, el terapeuta participa mediando siempre en esta comunicación, a la que dirige haciéndola pasar por sus preguntas redefinidoras.

“No pensamos que sea necesario un diálogo o una confrontación (entre los miembros) en la sesión, sino para permitir que el terapeuta recoja datos para su intervención o para conferirle mayor fuerza utilizando lo que se ha evidenciado en el curso de la sesión. Los intercambios más útiles pueden realizarse espontáneamente fuera de la sesión, en el curso de las elaboraciones sucesivas de las “definiciones” que ha dado el terapeuta de lo que ha sucedido. El cambio consiste en realidad en el trabajo continuo que cada uno cumple para *definirse respecto de las definiciones dadas por el terapeuta*, lo que llevará a un cambio en los modelos de relación y valores en juego” (2).

Esta modalidad del terapeuta tiene el efecto de fomentar e impedir al mismo tiempo la interacción entre los miembros de la familia, pues en la medida en que afirma y pregunta en función de las relaciones concretas entre ellos pero, por el tipo de comunicación radial que establece, impide que hablen entre sí, generaría por ese mismo hecho una gran necesidad de comunicarse.

Haley se refiere a esta técnica de bloqueo del hemisferio izquierdo como “fomentar una respuesta al frustrarla” (7).

“En una relación aparentemente diádica... de la que todos parecen excluidos, cada uno de ellos es provocado sobre argumentos que lo colocan en estrecha relación con los demás. Se trata, empero de una interacción silenciosa que *resulta tanto más intensa cuanto más estuvo, al mismo tiempo, solicitada e impedida*” (2).

Pero esta centralidad del terapeuta no es sólo una técnica de bloqueo del hemisferio izquierdo; es la consecuencia necesaria del modelo de cambio que intento describir con todo lo dicho hasta ahora; modelo de cambio que, apoyándose en la concepción del equilibrio necesario entre tendencias homeostáticas y a la transformación, a nivel “sistema”, tal como aparece en los trabajos de 1978 del grupo, evolucionó en “La Familia Rígida”, de 1982, a una posición que pone en el foco de la reflexión sobre el proceso terapéutico al individuo y a su proceso de crecimiento y diferenciación en el seno del sistema familiar.

Y en este nivel “individuo” volvemos a encontrar las mismas dos tendencias en necesaria antítesis: la tendencia a la cohesión y la tendencia a la diferenciación e individuación.

Y encontramos al terapeuta como persona, también enfrentado a sus propias necesidades o capacidad de cohesión-diferenciación.

De esta óptica surge naturalmente el énfasis en la emoción de los participantes del encuentro terapéutico (pues hablar de necesidades es hablar de emociones), y también naturalmente surgen las técnicas para despertar y capitalizar esas emociones para la terapia; de allí lo imprevisible, lo mimético con la

LA PROVOCACION TERAPEUTICA

familia, lo inmediato, lo paradójal, el intento de bloquear el control racional, y la alta involucración personal del terapeuta en esta intervención, concebida para cambiar el disfuncional equilibrio función-persona, en los miembros de las "familias rígidas".

Resumen

En este trabajo se analiza la intervención terapéutica llamada *provocación*, característica del grupo del Istituto di Terapia Familiare, que dirige Maurizio Andolfi.

Se la caracteriza como una intervención diseñada para las familias a las que llaman rígidas, generadoras de grave patología, por su dificultad para adaptarse a las variables necesidades de sus miembros. Una intervención de modalidad *paradójal*, con *acento en lo emocional* y el consecuente clima de alta tensión durante las sesiones; aplicada de manera *inmediata* y *mimética con la familia*, lo que le confiere su carácter de *imprevisibilidad* y su alto poder terapéutico.

Por lo que también demanda una *alta involucración personal del terapeuta*, al que enfrenta con su propia ecuación cohesión-individuación, que puede llevarlo a necesitar conformar un sistema terapéutico rígido.

La provocación es *individual-sistémica*, pues se dirige a un individuo, pero en una sintaxis relacional; tiene una *construcción retórica particular*, que la hace apta para bloquear el control racional y es una técnica que se apoya en una *total centralidad del terapeuta*.

Summary

This work studies the therapeutic intervention called *provocation*, which characterizes the way the group of the Istituto di Terapia Familiare, whose director is Dr. Maurizio Andolfi, works.

It is described as an intervention designed for so called rigid families which, because of their difficulty to adapt themselves to the changing

MARIA INES DATES

needs of their members, produce serious pathology. It is a *paradoxical intervention*, it *emphasizes emotion*, and this produces an atmosphere of tension during the interviews; because of this, and because it is applied *immediately* and *mimetically* on the family, this intervention is *impredictable* for them, and so of a great therapeutic power.

But this also *demand*s from the therapist a *high personal involvement*, because he is confronted with his own equation cohesion/individuation and this may lead him to produce a rigid therapeutic system.

The provocation is *individual-systemic*, as it is meant for one member but within a relational syntax. It has a *particular rhetorical construction*, suitable to block the rational control and it is a method sustained on *the therapist's total centrality*.

Bibliografía

1. ANDOLFI, M. et al. "Interacción en sistemas rígidos. Un modelo de intervención en familias con un miembro esquizofrénico", *Terapia Familiare* (1978), Nro. 3, Roma. *Revista de Terapia Familiar II*, Nro. 4, 1980. Buenos Aires.
2. ANDOLFI, M.; ANGELO, C.; MENGHI, P.; NICOLÒ, A. M.: *La Famiglia Rigida. Un modello di psicoterapia relazionale*, Feltrinelli Editore. Milano. 1982.
3. BATESON, Gregory: *Espíritu y Naturaleza*, Ed. Amorrortu. Buenos Aires. 1982.
4. BOGDAN, Jeffrey: "Paradoxical Communication as Interpersonal Influence", *Family Process*, 21, 1982. P. 443-452.
5. DELL, PAUL: "Réplica", *Family Process*, Vol. 20, 1982.
6. GIACOMETTI, KATIA, "Terapia Familiar: un modelo de desarrollo y una propuesta de clasificación", *Revista de Terapia Familiar*, Buenos Aires. 1981, IV, 7/8.
7. HALEY, Jay, *La terapia no convencional de Milton Erickson*, Amorrortu Editores. Buenos Aires.
8. HOFFMAN, LYNN, *Foundations of Family Therapy*, Basic Books, New York, 1981.
9. LAING, RONALD, *El Yo y los Otros*, Fondo de Cultura Económica, México. 1974. (Ed. orig. 1961).
10. LAING, RONALD; PHILLIPSON, H.; RUSSELL LEE, A., *Percepción Interpersonal*, Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1973 (Ed. orig. 1966).
11. PIPERNO, RUGGERO. "La funzione della provocazione nel manteni-

LA PROVOCACION TERAPEUTICA

- miento omeostático dei sistemi rigidi", *Terapia Familiare*, Nro. 5. 1979. Roma.
12. SELVINI PALAZZOLI, M.: "Comentarios acerca del trabajo del Dr. Paul Dell: Algunos pensamientos irreverentes acerca de la paradoja". *Family Process*, Vol. 20, 1982.
13. WATZLAWICK, PAUL, et al.: *Teoría de la Comunicación Humana*, Ed. Herder. Barcelona.
14. WATZLAWICK, PAUL. *El lenguaje del cambio*, Ed. Herder, Barcelona. 1980. (Ed. Orig. 1977).

Bibliografía consultada

- ANDOLFI, M.: "La prescripción de las reglas disfuncionales de la familia como estrategia terapéutica". *Rev. Terapia Familiar*, Buenos Aires.
- ANDOLFI, M.; MENGHI, P.: "Supervisione provocatoria", *Terapia Familiare*, 9, Junio 1981, Roma.

CENTRO

de

D ocencia
I nvestigación y
A sistencia
P sicológica

Directores:

Dr. Roberto P. Montanelli
Dr. Carlos N. Díaz Usandivaras

TERAPIA FAMILIAR Y DIVORCIO

Workshop con

FLORENCE KASLOW

(Directora del Florida Couples and Family Institute; editora del American Journal of Family Therapy); Terapeuta familiar especializada en temas relacionados con separación y divorcio)

* Terapia del divorcio -- * Mediación para el divorcio -- * Familias reconstituidas -- * Problemas de hijos sintomáticos de familias divorciadas -- * Asuntos legales en la práctica de la Terapia Familiar.

31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 1985

Uno de los 3 días será dedicado al trabajo interdisciplinario con abogados y asistentes sociales.

Informes e inscripción: DIAP, Acassuso 907, 1642-San Isidro
Tel. 743-8645 República Argentina

salud mental

ATENCION INTEGRAL DE LOS TRASTORNOS PSIQUICOS

- Psicoterapia Grupal - Individual - Familiar
- Clínica de Día
- Comunidad Terapéutica
- Internación

DIRECTOR PROFESOR
DR. JORGE GARCIA BADARACCO
SUB-DIRECTOR
DR. NORBERTO PROVERBIO

CLÍNICA PSIQUIATRICA

d i t e m

O'HIGGINS 2328 - BS. AS.
TEL. 781-1306/7825/0557

1. Introducción

El presente trabajo se propone mostrar una práctica profesional de asistencia a pequeñas y medianas organizaciones familiares. En el mismo se intentará describir los fenómenos organizacionales, sus condiciones de ocurrencia; así como también las fracturas que posibilitaron la instalación de la intervención y el desarrollo de la misma.

Desde lo metodológico nos interesa: a) Delimitar el objeto de análisis y los niveles del mismo, b) Describir un modelo de abordaje del conflicto y del cambio organizacional.

En nuestro medio es muy frecuente observar organizaciones familiares, tanto en empresas productivas como en instituciones educativas y recreativas. En la práctica diaria, la asistencia psicosocial a las mismas se origina a partir de una demanda de asistencia para enfrentar un momento crítico de su evolución. Dicho momento aparece acompañado generalmente de conflictos a distintos niveles de la organización, cuyo origen es difuso,

pero que indudablemente se reproducen en cascada desde el vértice hacia la base de la estructura. Esta demanda parte de alguno de los integrantes, o del grupo alrededor del cual gira la conflictiva, buscando alivio a situaciones reiteradas, tormentosas, tortuosas y estereotipadas que atacan la eficiencia y la calidad de vida de las organizaciones.

El abordaje de estos casos requiere una adecuada estrategia de intervención, ya que la misma transitará por un medio muy cerrado y fuertemente expulsivo de cuerpos extraños. El reconocimiento y la posibilidad de recibir ayuda externa, a partir de aceptar la existencia de alguna dificultad, debe abrirse paso lentamente a través de una cultura no acostumbrada al rol del asesor, salvo el contable, muy voluntarista y plagada de actitudes propias de pioneros onnipotentes.

El asesor deberá flexibilizar su accionar, conocer el tiempo de la organización y tener la suficiente perseverancia para tolerar las marchas y contramarchas sin perder el objetivo de su intervención.

Comprender ciertos fenómenos organizacionales en este tipo de organizaciones permitirá instrumentar adecuadamente su abordaje no sólo en la faz diagnóstica, analítica y comprensiva, sino también en el momento más crítico: el de la implementación de los cambios requeridos desde su rol de animador y acompañante de los mismos.

2. Identificación del problema

La descripción del objeto de análisis nos obliga a recurrir a un enfoque desde distintas vertientes.

"Estas organizaciones difícilmente puedan explicarse a través del tipo de estudios que se aplican a empresas que, por su tamaño, e incluso por origen distinto del capital, presentan una apariencia de mayor "racionalidad", de mayor "sistematicidad".

Para su comprensión debe incluirse la instrumentación de variables de carácter psicológico que puedan explicar los procesos de identificación entre el propietario y la empresa, la confusión o superposición entre el sistema social de la familia y el sistema de organización" (1).

El campo generado por el encuentro de ambos sistemas es provocador de una totalidad compleja que puede ser analizada desde tres niveles distintos:

—La familia fundando y desarrollando una empresa que a su vez, es transformada en “escenario” apto para el juego de su dramática interna y en plataforma para el abordaje del mundo externo no familiar.

—La familia desarrollando una estructura sociotécnica y desde ahí generando su división vertical y horizontal.

—La familia conformando una totalidad organizacional a partir de la cual aparecen los manejos de dominación, la búsqueda de su racionalidad y eficiencia.

En el primer nivel nos enfrentamos con una “ilusión familiar” que no quedó satisfecha con el cumplimiento del mandato biológico de reproducción y crianza, sino que avanzó sobre el área laboral incorporando la producción. Por extensión dicha ilusión da origen a conductas organizacionales de reproducción y crianza en un marco formal de producción laboral.

Este avance conlleva implícitamente el proyecto de transformación de todo el sistema familiar en una “institución total” (2), capacitada económica y afectivamente para satisfacer a sus integrantes en todas las alternativas por las que atravesarán sus respectivos procesos evolutivos.

En el segundo nivel nos enfrentamos con fenómenos propios de la diferenciación vertical y horizontal (jerárquica y técnica respectivamente), fruto de la interrelación entre la estructura social y la tecnológica. Esta interdependencia no sólo se ve sometida a influjos del contexto, sino teñida fuertemente por los actores familiares y sus colaboradores directos.

El desarrollo de la estructura social y el de la tecnológica es fruto de fuertes presiones emocionales con gastos de energía basada en una actividad a prueba y error. La racionalidad interna del sistema escapa muchas veces a los condicionantes contextuales aún a riesgo de sobrevivencia. Otras tantas veces esta misma racionalidad consigue una gran capacidad de persistir bajo condiciones donde otras más impersonales desaparecerían.

En el tercer nivel de análisis, el organizacional como totalidad donde se sucede un proceso de familiarización que abarca tanto el medio interno como externo de proveedores y clientes, podemos visualizar dos subsistemas:

—El formal, de normas y sanciones, que se presenta difuso en su accionar tanto interno como externo.

—El ideológico, mediante el cual se sustentan las pautas de dominación, de racionalidad y de eficiencia y es el resultado del encuentro entre la ideología familiar y la organizacional mutuamente infiltradas.

El abordaje del conflicto y del cambio en este tipo de empresas demandará la cobertura de los siguientes aspectos:

—Construir un vínculo entre asesor y grupo lo suficientemente fuerte para “reproducir” una racionalidad no familiar dentro de la organización. Este vínculo debe basarse en la depositación de una confianza ética profesional con suficiente garantía de imparcialidad y de objetividad.

—Una acción de aprendizaje de disociación, entre lo emocional y lo operacional, basado en la incorporación de lo organizacional sistemático (racional burocrático) y la posibilidad de toma de distancias y enfrentamiento con los elementos no manifiestos puestos en juego que intentan distorcionarlo.

Este proceso puede ser considerado como una resocialización; como un proceso de “crianza” grupal en su habilidad para transitar plásticamente por las distintas instancias, de grupo primario a grupo secundario, en un camino de ida y vuelta, permanente.

—La búsqueda de una mayor eficiencia organizacional para la “producción” de mayores beneficios, tanto económicos como sociales.

El conflicto es consumidor de grandes dosis de energía social provocador de errores que se pueden medir en términos económicos.

Estos tres aspectos básicos del abordaje:

La creación de un vínculo para la reproducción de una racionalidad no familiar, la crianza de un grupo hacia su secundarización y la producción de beneficios medibles en

términos socio-económicos, nos hace pensar que el asesor deberá transitar empáticamente los niveles familiares de reproducción, crianza y producción.

3. Marco conceptual

El término *intervención* aparece usado en el libro "La intervención institucional" de Félix Guattari y otros (3).

En él leemos... "Intervenir (del latín *interventio*) es venir entre, interponerse. Por esta razón en el lenguaje corriente, esta palabra es sinónimo de mediación, de intercesión, de buenos oficios, de ayuda, de apoyo, de cooperación; pero también en otros contextos es sinónimo de intromisión, de injerencia, de intrusión..."

"... el concepto Lewiniano de investigación-acción, parece aportar un fundamento teórico y una garantía a la práctica de la intervención..."

"... Pero la intervención del consultor en una organización difiere también del rol del formador en cierto número de aspectos, conservando sin embargo, con éste, lazos de parentesco que será necesario precisar brevemente..."

El uso de la palabra *intervención* refleja con más fidelidad la acción del tercero frente al par familia-organización, a las contradicciones, al deslizamiento de lo personal afectivo sobre lo organizacional, a los comportamientos circulares y a la tensión generada por el interjuego del grupo primario con el grupo secundario. Es el tercero el que posibilita el clivaje operativo abriendo áreas discriminadas para la racionalidad familiar y para la ejecutiva jerárquica de la organización.

"La ilusión familiar como fenómeno transicional"

D. W. Winnicott (4), al referirse a los objetos y fenómenos transicionales, nos brinda conceptos que podemos rescatar como visión psicosocial del fenómeno organizacional y grupal.

Para el autor las tres vidas que vive la gente sana son:

"La vida del mundo con las relaciones interpersonales y que permite también la utilización del medio circundante no huma-

no. La vida de la realidad psíquica personal (denominada a veces "interior"), y el área de la experiencia cultural...

La experiencia cultural comienza con el juego y conduce a todo aquello que compone la herencia del hombre: las artes, los mitos históricos, la lenta progresión del pensamiento filosófico, y los misterios de las matemáticas, de las instituciones sociales y de la religión".

"Yo afirmo que si hay necesidad de un doble planteo, también la hay de un planteo triple; hay la tercera parte de la vida del ser humano, una parte que no podemos ignorar, una zona intermedia de experimentación a la cual contribuye tanto la realidad interior como la exterior".

Pensamos que para la familia la empresa adquiere las características de tercer área, un lugar de transición, donde se pueden dar al mismo tiempo su seno y la realidad exterior. En esta tercer área se fundaría la "ilusión familiar".

"Estoy estudiando, dice Winnicott, la sustancia de la ilusión... y si deseamos podemos compartir y formar grupos sobre la base de la semejanza de nuestras experiencias ilusorias. Esta es una de las raíces naturales del agrupamiento entre los seres humanos".

En relación a los grupos Didier Anzieu (5) recoge los conceptos de D. W. Winnicott expresando que en la ilusión grupal los participantes se dan un objeto transicional común, que es para cada uno realidad externa y simulacro del seno. Pecando de extensión diría que la familia en la empresa se da un lugar para la "ilusión familiar" a perpetuidad, y ésta puede ser creativa, atrapante o autodestructiva.

4. Descripción

El tipo de organización familiar a la que me refiero presenta algunas características particulares:

—Es de tamaño pequeño o mediano; máximo 150 a 200 personas.

—Tiene una historia de fundación, con relatos de pioneros y peripecias cuyos personajes están todavía presente o su ausencia

es lo suficientemente próxima como para continuar influyendo mitológicamente.

—En los momentos de dificultad aparece indefectiblemente el recuerdo de épocas pasadas que, aunque esforzadas, son vividas como simples y muy añoradas.

—Mantienen un grupo de colaboradores familiares, o extra-familiares, desde el inicio aunque hayan perdido la habilidad requerida. Se aprecia más la fidelidad que la capacidad con riesgo de abandono.

—Presentan dificultad a la entrada de ajenos expertos. La dificultad de aceptarlos es tanto del personal como de los propietarios.

—La herencia y continuidad es generadora de grandes desvelos por parte de los “viejos”, que presentan ambivalencia entre entregar y dar entrada y al mismo tiempo imponer condiciones de continuidad.

—Tienden a familiarizar todas las relaciones, tanto con proveedores como con clientes.

—Presentan las tres características de grupo primario: a) *Comunicación cara a cara*, donde es más difícil diferenciar el rol de la persona y mantener distancia jerárquica por el alto grado de afectivización que provoca.

b) *Mutua representación*, facilita la generación de expectativas de comportamiento y, las respuestas debidas a una idea previamente instalada del otro, condicionan la interacción y los juegos de poder.

c) *Estabilidad y dependencia*. Ambas características son generadoras de vínculos y lealtades muy intensas y enmarcan toda discusión en la certeza de arribar a una concertación. La ruptura no es fácilmente aceptada. Estas características enfrentadas con el SISTEMA ORGANIZACIONAL facilitan una vía emocional a las crisis y a su desorganización, creando situaciones de hondo dramatismo.

Este ENCUENTRO entre SISTEMA FAMILIAR y SISTEMA ORGANIZACIONAL, quisiera plantearlo no tanto como la interferencia o el deslizamiento de uno sobre el otro, sino

como justamente la generación de un espacio del que se apropia la familia para jugar sus conflictos.

En este espacio intermedio los objetos adquieren para los usuarios una carga tal que va más allá de los resultados en términos de beneficio económico. El conflicto y la resistencia al cambio están asentados en este espacio intermedio, en esos objetos que lo pueblan y en la dificultad de transferir o incluir otros.

Esta visión de la organización como fruto de una particular forma familiar de enfrentar al mundo externo y debatir su mundo primario, descentra la mira psicosocial de las relaciones interpersonales hacia la particular relación de cada integrante con los objetos, los objetivos y con la organización como objeto total.

De esta forma queda planteado al mismo tiempo el grado en que cada uno y el grupo puede acompañar el crecimiento, abandonando relaciones objetales envejecidas, obsoletas, y transfiriendo a las nuevas sin por eso convertirlas en objetos alienados.

Esta premisa daría la posibilidad de preguntarse por qué determinadas personas o grupos suelen enfrentarse con límites de crecimiento frente a los cuales aparecen grandes dificultades para superarlos, con la consecuencia, en algunos casos observados, de intentos de destrucción y desarme para retornar a situaciones calificadas como posibles de ser manejadas.

5. El diseño de la organización requerida

En una situación parcialmente cerrada, como es la Empresa Familiar, la estructura organizacional presenta una correspondencia biunívoca con el sistema social que le dio origen. Esta mutua determinación, fruto del intercambio circular y de la realimentación, confunden causa y efecto en un juego difícil de desentrañar.

El camino que nos llevó a comprender la ilusión familiar y, a través de la misma, nos dio la posibilidad de convertirnos en una herramienta transicional, nos conduce a un cruce donde la

institución burocrática deberá encontrar encuadre diferenciado como única vía para su desarrollo. Es en este punto donde la familia llega a su máximo nivel de exigencia, ya que para continuar creciendo como organización deberá encontrar un estilo de gestión tal que le permita discriminar la institución familiar de la institución empresarial, para que ambas puedan continuar su normal desarrollo sin interferirse mutuamente.

Toda la resistencia se pone al servicio del detenimiento y del refuerzo del conflicto básico: la dificultad para enfrentar la contradicción del crecimiento empresarial y familiar sin afectar el status quo, enfrentando las fantasías de muerte y destrucción que la variación del mismo detona.

Es aquí donde considero necesario abordar el problema desde el nivel del diseño, de la reestructuración, del aprendizaje, de la prueba y puesta en práctica de soluciones alternativas; la búsqueda de la "Institución social requerida" (6); de un orden distinto que libere a la familia de la trampa en la que está cautiva.

Enfrentado con la necesidad de encontrar los caminos que permitirán circular discriminadamente, la institución familiar y la empresaria, pero conformado en un todo superior que las abarque y las satisfaga, es que deseo plantear esta búsqueda a partir de los conceptos de E. Jacques acerca de las organizaciones requeridas.

En su libro: "A. General Theory of Bureaucracy" dice: "... "el diseño de instituciones implica por supuesto el diseño de un objeto social específico, y ese objeto ser en última instancia cargado de valor y político". Estas políticas pueden estar al servicio de reducir o de ampliar el conflicto. Una familia incluye un conflicto que elabora a lo largo de su existencia hacia su permanencia o resolución.

E. Jacques plantea una naturaleza humana sana, una conducta normal y una estructura que puede satisfacer o no; facilitarla o dificultarla. El rasgo general de la conducta normal es aquel que refuerza la interacción colaboradora entre gente". Igualmente, una naturaleza humana sana requiere una interacción social que tome en cuenta: una conciencia de sí mismo y de

los otros, la habilidad para comunicar, la capacidad para cooperar, y la capacidad para el intercambio social y económico.

Continúa planteando E. Jacques que la paz social será fruto de la posibilidad de satisfacer: la plena utilización, la participación, la apelación y una retribución equitativa. Estos valores psicosociales tienen su contrapartida en las estructuras sociales.

Existen estructuras que favorecen dichas características; a las que E. Jacques denomina "Requeridas", y otras que las dificultan y por lo tanto las denomina "Antirequeridas". Me atrevo a trasladar estos conceptos no solamente al ámbito institucional burocrático, sino también el ámbito de la institución familiar que la contiene y le dió origen. El diseño de una institución abarcativa de ambos debería contemplar las diferentes características, conflictos específicos y el encuadre requerido para los mismos. Cuando los respectivos conflictos invaden ámbitos ajenos, en extensión y confusión, se produce un efecto de resonancia amplificadora sobre la estructura piramidal de la organización ejecutiva. Este efecto en algunos casos consigue fatigar la resistencia estructural hasta derrumbarla. Si mediante el diseño logramos dirimir el conflicto familiar en un espacio adecuado, y dar respuesta también a la necesidad de las características ejecutiva-jerárquica, habremos encontrado una nueva organización; la "requerida".

Con este planteo deseo explicitar la necesidad de trabajar, una organización compleja como ésta, desde distintos accesos en forma simultánea y convergente con los niveles interaccionales y fantasmáticos, de forma tal que la reestructuración de los mismos se apropie de un anclaje concreto en el campo de la realidad y de la formalidad: *la estructura organizativa formal requerida*.

6. La estrategia de la intervención

Son dos los frentes, en los cuales trabajo simultáneamente. Uno es el de *restitución del diálogo* y otro es el de la apertura de *espacios organizacionales* que permitan otras alternativas de

relación. Entiendo por *diálogo* no solamente aquel que se instala, entre dos o más miembros o entre dos o más grupos, diálogo significa también una conexión con toda la organización, con su cultura, con el modo particular de hacer o de no hacer las cosas.

Entiendo por *espacios organizacionales*, algo más amplio que la visión física, real, concreta y estructural; es un espacio que se forma dinámicamente por cada persona o grupo como sumatoria de su capacidad, de su poder de decisión, de su edad, de su experiencia, de su capital; es en realidad un espacio político.

En ambos frentes nos encontramos con un fenómeno propio de las organizaciones burocráticas. El desfase que se origina entre la estructura formal, la existente, la presunta y la requerida conduce frecuentemente a problemas y perturbaciones en las relaciones interpersonales (7).

El repaso de estos cuatro niveles se transforma en la materia prima básica de la intervención para desarmar los malos entendidos, los prejuicios y las falsas expectativas.

El tránsito por las distintas instancias significa revisar con los actores, en forma individual y grupal, la estructura de la organización abordándola desde sus respectivos niveles:

El nivel formal: el expresado u ocupado convencionalmente.

El nivel presunto: el que los actores suponen que ejercen y ocupan.

El nivel existente: el que aparece en el análisis.

El nivel requerido: el necesario de acuerdo con las nuevas condiciones a enfrentar.

El recorrido de estos cuatro niveles permite descubrir nuevos espacios racionales desde donde reconstruir y flexibilizar las relaciones, las posiciones; posibilitando la salida de situaciones reiterativas y desgastantes.

La intervención presenta dos momentos que se desarrollan secuencial o simultáneamente. La etapa del *manipuleo* de la estructura social y la etapa de contención e implementación de la nueva estructuración. Adelantándome a lo que la palabra

manipulación puede provocar deseo transcribir un párrafo de Watzlawick (8): "...es absurda la pregunta de cómo poder evitar el influjo y la manipulación. Lo único que queda es la decisión —de lo que nunca se nos dispensa— de cómo usar responsablemente y de la manera más humanitaria, ética y eficaz, esta ley fundamental de la comunicación humana".

Tanto la restitución del diálogo como la de los espacios organizacionales, como su palabra lo indica, son soldaduras de fracturas que de alguna manera permiten la adaptación al cambio requerido por las nuevas condiciones; dando lugar a la reconstrucción o a la extinción de relaciones envejecidas y estereotipadas. Probablemente todo ocurra merced a la instalación de una nueva ilusión, la de la reparación, de la que la intervención no escapa sino que es parte protagónica. Es a partir de esta ilusión que logramos instalar algunos mecanismos que actúan como alarmas para evitar las fracturas y acortar los desencuentros; algunas alarmas protectoras de los espacios racionales alcanzados.

Resumen

En nuestro medio es frecuente observar organizaciones familiares tanto en empresas productivas como en instituciones educativas y recreativas.

La asistencia a este tipo de empresas, en sus situaciones críticas a lo largo de su evolución, requiere de la conformación de un esquema conceptual que haga referencia tanto a lo psicosocial como a lo tecnológico-administrativo.

El campo generado por el encuentro del sistema social familiar y el sistema empresarial da lugar a una totalidad compleja que puede ser analizada desde varios niveles: a) la familia fundando y desarrollando una empresa a la que a su vez transforma en escenario; b) la familia generando una estructura socio-técnica; c) la familia como totalidad organizacional.

El presente trabajo se propone repasar las características más salientes, los fenómenos organizacionales, la estrategia de cambio y la búsqueda de una institución adecuada que permita la articulación y el desarrollo de los dos sistemas que contiene.

Summary

In our society family organizations are a frequent occurrence, both in industrial concerns and in educational and creational institutions. The assistance to this type of organizations, in critical situations as well as throughout their evolution, requires a conceptual framework which takes into account the psychosocial as well as the technological and administrative factors.

The field generated by the encounter of the familiar social system and the business system gives rise to a complex whole that may be analyzed at several levels: (a) the family that founds and develops a business organization which turns into a stage; (b) the family that generates a sociotechnical structure; (c) the family as an organizational whole.

This paper intends to make a review of the most salient features, the organizational phenomena, the strategy towards change and the search for an adequate institution that allows the articulation and development of the two systems it contains.

Bibliografía

1. KARPf LUIS y MARTA NOVICK: "Pautas diagnósticas para la pequeña empresa familiar". *Ensayos sobre Psicología Institucional*. EVA A. G. DE MUCHINIK y OTROS. Pág. 63. Editorial de Belgrano.
2. GOFFMAN ERVING: *Internados*, Amorrortu Editores.
3. GUATTARI, FELIX y OTROS: *La intervención institucional*, pág. 13. Folios Ediciones.
4. WINNICOTT, DONALD W.: "El concepto de individuo sano", *Donald W. Winnicott*, Colección Lo Inconsciente, Editorial Trieb, pág. 39.
5. ANZIEU DIDIER: *El grupo y el inconsciente*, pág. 195. Biblioteca Nueva.
6. JACQUES, ELLIOTT: "El concepto de institución social requerida", *A General Theory of Bureaucracy*, Londres y Exeter, New Hampshire, Heinemann. Educational Books Ltd. (1976).
7. SCHLEMENSON ALDO: "Igualdad y Jerarquía. Análisis de dos modelos de organización".
8. WATZLAWICK, PAUL: *El lenguaje del cambio*, pág. 15, Editorial Herder.



Institución Psicoterapéutica

1. RESIDENCIA TERAPEUTICA INTERMEDIA. Lugar abierto al trabajo terapéutico familiar e individual.
2. CLINICA PSIQUIATRICA: internación de pacientes agudos y descompensados sintomáticamente.
3. COMUNIDAD DEL TIEMPO: Hospital de Día Comunitario.
4. TALLERES TERAPEUTICOS
5. CLUB DE FIN DE SEMANA.
6. JARDIN DE OTOÑO (Tercera Edad).
7. CENTRO INSTITUCIONAL:
 - 7.1. DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION PSICOTERAPEUTICA.
 - 7.2. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CLINICA Y DOCENCIA.
 - 7.3. CONSULTORIOS EXTERNOS: Individual, grupal, familiar y de clínica psiquiátrica.
 - 7.4. INTERNACIONES DOMICILIARIAS Y URGENCIAS PSIQUIATRICAS.
 - 7.5. ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS.

Directores:

Dr. Felipe Díaz Usandivaras

Dra. Mirta Irene Méndez Puig

Soler 5961 - 1425 Capital Federal - Tel.: 771-8114/8108

Los mitos terapéuticos

Lic. NIDIA MADANES

Quesada 2568, Capital Federal

Este artículo desarrolla la idea de que en la terapia se utilizan mitos como instrumentos terapéuticos. Los mitos son construcciones especiales de la realidad. Los terapeutas siempre están construyendo mitos, ya sea que lo reconozcan o no. A veces se valen de mitos tradicionales que pueden encontrarse en la literatura clásica. Recurriendo a estos mitos el terapeuta interrumpe y concluye la interacción de la familia que mantiene la patología. El mito crea un nuevo contexto a través de una nueva definición de la realidad.

Verdad versus mito

En "Los mitos de Platón", J. A. Stewart dice: "Un mito es un cuento fantástico, algunas veces tradicional, algunas veces reinventado, con el que un interlocutor interrumpe o concluye la conversación argumental en la cual consiste principalmente el movimiento del drama (platónico)". Inventando un relato fantástico el terapeuta actúa como el interlocutor de Stewart, interrumpiendo y modificando el drama de la familia.

Las creencias míticas son irrefutables. Ellas están construi-

NIDIA MADANES

das o sostenidas en forma tal que ninguna evidencia empírica podrá jamás afectarlas. Siempre puede haber una explicación ad-hoc que resuelve el problema de los hechos externos adversos al mito. La ventaja de utilizar creencias míticas con propósitos terapéuticos estuvo oscurecida por la idea de que el cambio es posible sólo por medio de explicaciones verdaderas de la realidad psicológica. El reconocimiento de que la verdad es difícil o imposible de establecer no desalentó el desarrollo de diferentes teorías derivadas de este punto de vista; entre muchas otras, la idea de hacer conscientes los conflictos ocultos, interpretando la verdadera naturaleza de las relaciones a los miembros de la familia.

Otros enfoques terapéuticos, en cambio, desarrollaron la idea de que construyendo nuevas definiciones de la realidad, inventándolas con propósitos terapéuticos, se produciría el cambio. Si las creencias están asociadas con cierto comportamiento, cambiando las creencias cambiaría el comportamiento. No es fácil establecer si los individuos actúan como lo hacen y después tratan de explicar su comportamiento, o si son sus creencias las que generan ciertos comportamientos. De cualquier modo, un comportamiento dado y un cierto conocimiento de él se producen conjuntamente (Russell, 1958). La hipótesis de que las creencias son habitualmente desarrolladas por los individuos como una adaptación a cierta clase de contextos introduce la idea de que cambiando las creencias, los contextos también pueden cambiar.

Aunque en el contexto terapéutico se construyen algunas imágenes de la realidad que pueden ser refutadas, los mitos son irrefutables. Milton Erickson fue uno de los primeros terapeutas que advirtió esto y lo utilizó con propósitos terapéuticos. Al transmitirle a un marido autoritario la idea de que los "hombres de verdad" suelen permitir a sus esposas alguna libertad menor, actúa con la certeza de que el esposo autoritario va a comportarse como un "hombre de verdad". El mito que él elige para inducir un cambio no es refutable. ¿Qué podría hacer posible la diferenciación entre los hombres "de verdad" de los que no lo son?

Mitos familiares versus mitos terapéuticos

La identidad de la familia es una expresión de los mitos que sus miembros han asimilado. Estos mitos constituyen la historia de la familia. En tiempos de crisis la familia desarrolla toda clase de mitos para fortalecerse intentando destruir lo que la atemoriza. Es especialmente en épocas de crisis que la familia misma tiene que reafirmarse acerca de las reglas que la mantendrán unida.

Un mito familiar es un conjunto de creencias acerca de relaciones familiares que es compartido por todos los miembros de la familia y que explica el comportamiento de los individuos dentro del grupo familiar (Ferreira, 1963). Es útil en el desarrollo del sentimiento de seguridad en áreas donde de otro modo existirán dudas e incertidumbres. Ayuda a desarrollar la autoestima y a evitar la ansiedad. Tiene además una función muy importante: preserva la adaptación de los individuos a la vida familiar, y de la vida familiar a la sociedad, al hacer posible la transmisión de un conjunto de reglas que gobiernan las relaciones familiares (Palazzoli y otros, 1978). Los mitos que los miembros de la familia comparten acerca de sí mismos desarrollan fuertes lazos que mantendrán unidas a las personas entre sí.

El terapeuta familiar no sólo debe comprender y descifrar el mito presentado por la familia, sino además, elaborar mitos alternativos. Al presentar a la familia un tipo diferente de conocimiento sobre sí misma, el terapeuta podrá estimular el desarrollo de un comportamiento nuevo. Si la familia desarrolla sus mitos, creyendo en las explicaciones de su propia conducta y haciéndolas creer, el trabajo del terapeuta consistirá en reemplazar ciertos mitos familiares que racionalizan el comportamiento sintomático por otros mitos terapéuticos que motivan el desarrollo de un nuevo comportamiento no sintomático. El nuevo mito presentado a la familia contendrá un conjunto diferente de reglas ligadas a él que acarrearán un propósito implícito de cambio. Actuando así, el terapeuta tiene en mente

uno de dos propósitos: lograr la aceptación familiar del mito, o lograr su rechazo; uno u otro provocarán el cambio.

El mito opera como una herramienta terapéutica, porque la familia, tratando de deshacerse del mito, debe deshacerse del síntoma asociado a él, o bien para sostener el mito terapéutico introducido por el terapeuta, debe igualmente liberarse del síntoma.

Al usar Milton Erickson el mito del "hombre de verdad" con un marido autoritario, lo que hace es provocarlo a que confirme el mito de ser "un hombre de verdad" cambiando su comportamiento. Para lograrlo elige la clase de mito que es significativo y apropiado para ese tipo de persona. Procediendo así utiliza ciertas ideas que funcionan como "verdades" para ese hombre. Aun cuando los mitos terapéuticos son historias que crean la ilusión de la verdad, es necesario que tomen en cuenta aquello que es de particular relevancia para cada persona o familia. Diferentes personas reaccionarán de manera diferente a la misma historia acerca de sí mismas. Es la habilidad del terapeuta lo que lo conduce a comprender aquello que es particularmente relevante para alguien.

Papp (1980) presenta un interesante caso que ilustra claramente este punto de vista. La madre había hecho un intento de suicidio y el padre había sufrido varios ataques al corazón. Ambos estaban embarcados en una lucha por el poder acerca de cada acontecimiento de sus vidas. Los hijos reproducían la contienda entre los padres. El chico, Gary, tenía once años y su hermana nueve. Ella había ganado el primer papel en la representación teatral de la escuela pero, aunque lo había deseado, en lugar de expresar su placer se quejaba de que otros chicos estaban celosos de ella. El terapeuta dijo: "Sally es sagaz al quejarse y llorar en el momento de su mayor triunfo, que es obtener el primer papel en la representación escolar. Al no mostrarse alegre, está siguiendo el ejemplo de su madre, que no se permite a sí misma sentir placer. Esto sucede por el miedo de hacer sentir menos afortunados a otros miembros de la familia. Creemos, por lo tanto, que es adecuado que el padre y Gary alienten a Sally y a la madre a ser desdichadas. De este

modo demostrarán su aprecio por lo que Sally y la madre están haciendo por la unión de la familia”.

Papp explica el éxito terapéutico que siguió a este mensaje por el hecho de “desactivar la lucha oculta por el poder por medio de su desenmascaramiento. La negación y el subterfugio que la rodean son reemplazados con intenciones conscientes que hacen difícil continuar de la misma manera virulenta”. Su idea es que el cambio ocurre porque la verdad ha sido revelada, sin embargo, podemos comprender el éxito terapéutico aproximándonos a esa sesión desde un punto de vista alternativo. El instrumento terapéutico básico empleado por Papp fue un mito terapéutico usado con la intención de provocar rechazo: “es difícil para cada uno de ustedes tolerar la felicidad del otro”.

Si la familia rechaza este mito (y así lo hizo ésta) es porque el mensaje implícito es: “es fácil para ustedes envidiarse unos a otros”. Este mensaje está sutilmente implicado en la declaración de que la madre y la hija no se permiten sentir placer por temor de hacer que otros miembros de la familia se sientan menos dichosos. Si la familia desea demostrar que esto no es verdad, tendrá que cambiar.

Una diversidad de enfoques en terapia familiar explican sus procedimientos de diversos modos, pero de hecho pueden ser entendidos en términos del mito y la directiva implícita dentro del mito que ellos seleccionan como relevante. Aquí voy a tratar de mostrar que esos diferentes enfoques pueden ser analizados en términos de esta perspectiva, comparándolos con instrumentos terapéuticos de culturas primitivas en las cuales los mitos se usaron con propósitos terapéuticos. Tomaré en consideración tres enfoques: el estructural desarrollado por Minuchin, el estratégico propuesto por Haley y Madanes, y el sistémico según es descrito por Palazzoli y otros; ellos dan cuenta de la mayoría de las orientaciones en terapia familiar. Luego estableceré la comparación con un procedimiento utilizado por los terapeutas en las culturas primitivas, *el Chaman*.

El enfoque estructural

En el enfoque estructural la meta principal es cambiar la

estructura de las interrelaciones familiares. Las familias son consideradas patológicas cuando están muy *aglutinadas* (cuando hay poca diferenciación en el subsistema) o demasiado *desunidas* (las unidades son demasiado independientes unas de otras). La terapia está dirigida a diferenciar los subsistemas, a unirlos entre sí, según sea necesario. Para hacer esto las pautas estructurales serán destruidas, construidas, y organizadas. Cambiando la visión de la realidad de los miembros de la familia mediante el desafío de sus puntos de vista, cambiarán las pautas de las transacciones familiares.

Para cambiar los métodos habituales de interacción relacionados con el síndrome de la anorexia nerviosa, Minuchin, Rosman y Baker (1978) desarrollaron la estrategia de “colocar al paciente en oposición a sus padres, de una manera especial”. El mito terapéutico sobre el que actuaban consistía en la consideración del síntoma como un acto voluntario, un acto de desobediencia orientado a frustrar a sus padres. De ese modo inducían a los padres a relacionarse con su vástago como un adolescente rebelde, en lugar de hacerlo con una persona inválida. Esto conduciría a que los padres se sintieran incapaces e incompetentes. También los haría sentirse sometidos a un individuo dominante, tiránico, su propio hijo o hija. Para modificar las consecuencias de este mito, una visión desagradable de sí mismos, tendrían que lograr que la hija comiera. Al compartir los mismos sentimientos, ambos padres se unirían. Esto los haría más fuertes. Esa fuerza podría posiblemente poner fin al comportamiento patológico de su hijo.

Para lograr sus objetivos, Minuchin apela a otros mitos (“construcciones” en sus propios términos). Con pacientes anoréxicos declara repetidamente que “ella comerá cuando alcance su propia edad”. El mito en este caso es que los síntomas expresan la inmadurez individual. De este modo incita a comer al paciente que habitualmente quiere ser tratado como una persona mayor.

Algunas veces los terapeutas hacen uso de mitos sabiendo que son historias inventadas por ellos, otras veces creen que al hacerlo están tratando con la verdad.

Cuando Minuchin dice: "es esencial que el terapeuta insista en comunicar el mensaje de diferenciación continua y consistentemente", él cree que el problema básico en estas familias es "la indiferenciación" y que él está definiendo la verdad real básica. Se puede sostener que para Minuchin "indiferenciación" o "diferenciación" son mitos que él usa para operar exitosamente. Las familias son provocadas por esa definición sobre sí mismas. Para probar que ellas pueden tolerar la diferenciación, cambian su actitud hacia el comportamiento sintomático de un vástago, ahora asociado a una definición de sí mismas que rechazan. Los mitos de que la "diferenciación es saludable" y de que "los síntomas expresan la incapacidad de diferenciar de la familia" son ciertamente útiles en este enfoque.

El enfoque estratégico

El enfoque estratégico está basado en la idea de planificar una estrategia para resolver los problemas del paciente. La estrategia enfocará el contexto social del paciente pues "un problema se define como un tipo de comportamiento que es parte de una secuencia de actos entre diversas personas" (Haley, 1973). Las metas de la terapia consisten en prevenir la repetición de las secuencias, y las estrategias son planeadas en etapas. Las secuencias que son repetidas a veces implican una disfunción jerárquica que debe ser corregida. En este enfoque las directivas se utilizan para modificar el modo en que la gente se relaciona mutuamente. Las directivas serán directas o paradójales.

En sus directivas Haley usa diferentes mitos terapéuticos. Algunas veces su objetivo es crear límites más fuertes, a menudo con el propósito de diferenciar a los padres de los hijos, siempre para resolver problemas. Un mito frecuentemente usado por él juntamente con Minuchin es que la desavenencia entre los padres está relacionada con el síntoma del chico. Nadie ha realmente establecido cuánto acuerdo o desacuerdo hay entre los padres de familias normales por comparación con las familias patológicas. Haley emplea la importancia del acuer-

do entre los padres como un mito, una norma que no puede ser cuestionada.

Cuando los padres alcanzan el acuerdo deseado están probando su capacidad de dejar muchas cosas de lado con el fin de ayudar a su hijo. Querer al hijo está asociado con el fortalecimiento de su propia relación. Si previamente ellos enfatizaban sus diferencias con el fin de ayudar a su hijo, el nuevo acuerdo pondrá fin a tal comportamiento. Se espera ahora de ellos que concuerden en todo lo que esperan que su hijo haga, no dejando abierta otra opción.

El tener un hijo perturbado estimula las diferencias entre los padres. Es fácil, cuando las cosas van mal, culparse unos a otros por los errores que cada uno siente que han causado el problema. Estos desacuerdos van a su turno a facilitar la conducta problemática del vástago, pues no pueden enunciarse expectativas claras de lo que debe hacerse. Si el paciente identificado tiene la posibilidad de probar que uno u otro padre "tiene razón" o "está equivocado", enfrentando a uno contra el otro, separándolos o uniéndolos, él ha conseguido un trabajo permanente. Haciendo que los padres se pongan de acuerdo, obviamente se cambiará este modelo.

Si los padres se unen, el hijo probablemente los dejará solos, entrando en contacto con su propia vida. Enfrentado con una exclusión normal de la vida de sus padres, desarrollará nuevos intereses para sí, apartándose de ellos.

Paradójicamente, evitar que las familias mejoren haciendo que los miembros piensen en todas las consecuencias negativas de la mejoría, es una técnica común en el enfoque de Haley para resolver problemas. La familia está enfrentada con el mito terapéutico de que las cosas son como son porque ella probablemente no toleraría que sean de otro modo. Sus miembros tendrán que probar entonces que pueden tolerar otro estado de cosas. Intentarán demostrarle al terapeuta que no son tan tontos o dependientes como él implica que son. Tratarán especialmente de probar que no son títeres accionados por otros, como el terapeuta da a entender.

Si bien Haley insiste en que el cambio de una organización

conduce al cambio en los pensamientos y la comunicación, estos mitos terapéuticos muestran que cambiando los pensamientos de una persona se logra un cambio en la comunicación y en la organización familiar.

En el caso de un chico encopréptico de cinco años, el terapeuta les impide mejorar diciéndole a la madre que "algunas mujeres no pueden tolerar el éxito". La madre responde diciendo que sí puede tolerarlo. Declarando que algunas de las consecuencias de tener un hijo encopréptico consisten en no ser capaces de comportarse como cualquier pareja normal, y expresando dudas acerca de si ellos podrán resistir comportarse como gente normal, el terapeuta incita a la pareja a demostrar que él está equivocado. En consecuencia los padres comienzan a transmitirle al hijo con absoluta firmeza lo que esperan de él y el muchacho comienza a controlar.

En uno de sus casos más conocidos, Haley debe resolver el problema de masturbación compulsiva de un chico de nueve años. La directiva usada en este caso fue la de que el chico se masturbara sólo los domingos para evitar que lo hiciera cuando no disfrutaba tanto de ello. En la medida en que el chico aceptase la idea de que las cosas deben hacerse sólo cuando uno más las disfruta, tendría que cumplir su promesa de masturbarse sólo el domingo. La masturbación quedaría entonces asociada a su obediencia al terapeuta y por ende a algo displacentero hecho con esfuerzo. Así es como el síntoma quedará eliminado.

En otro caso de un chico de diez años que se orinaba en la cama, Haley tuvo que lidiar con el problema de una abuela demasiado involucrada que protegía a su nieto cada vez que su madre intentaba disciplinarlo. El terapeuta pidió a la abuela hacerse cargo del chico durante las dos primeras semanas sin ninguna intromisión de la madre. Más tarde fue la madre la que tuvo que asumir la responsabilidad de ocuparse de su hijo. Mientras formulaba su prescripción, el terapeuta dijo: "la madre tiene que hacerse totalmente cargo del chico, la abuela solamente puede disfrutarlo". El mito terapéutico de que el verdadero goce deriva de no hacerse responsable del nieto

seguramente afectará la relación entre abuela y madre, puesto que la abuela comenzará a pensar que ser dejada de lado en la crianza de su nieto es una ventaja.

A veces los terapeutas utilizan con frecuencia cierta clase de mitos por reconocer en ellos una ventaja. Milton Erickson, por ejemplo, solía recurrir a prescripciones capaces de evocar sentimiento de vergüenza como un recurso terapéutico importante para curar cierto tipo de fobias. La vergüenza resulta en general intolerable porque destruye la "honorabilidad" que toda persona necesita tener. Asociando el temor a la vergüenza, Erickson condenaba al paciente sintomático a algo peor que el miedo. El miedo puede ser conveniente en ciertos casos, la vergüenza no puede serlo. Al prescribir experiencias que evocaban vergüenza, Erickson esperaba que el paciente, teniendo que concentrarse en eliminar la situación vergonzosa, dejase de sentir miedo. Erickson utilizaba la prescripción paradójica "condenando" al paciente a permanecer sintomático, o condenándolo a experimentar algo peor que aquello por lo que consultaba.

Erickson lograba que el paciente se viese condenado a tener que pagar por su síntoma un precio demasiado alto como para no renunciar a él. La condena a la que lo sometía involucraba en general la realización de tareas difíciles o vergonzosas, casi sin esperanzas. Más tarde, lo absolvía. Al proceder así, con tal de lograr absolución de "la cura" el paciente se deshacía rápidamente del síntoma. De este modo Erickson utilizaba el mito de "condenar" y "absolver" para lograr sus propósitos.

En el caso del hombre con dolores de cabeza (Haley, 1973) dijo: "Cuénteme qué clase de mezquindad infligió usted a su mujer, qué clase de arpa hizo usted de ella y a cuántos de sus seis hijos usted ha perjudicado". A la esposa del hombre le dijo: "En cuanto a usted, madre, piense solamente en cómo ha cambiado, desde que era una delicada y linda jovencita, hasta convertirse en una regañona y peleadora arpa".

Para redimir, Erickson involucraba al paciente en trabajos duros y penosos. Una niña pequeña tenía que practicar en su bicicleta para poder vencer a Erickson. Una horrible mujer gorda tenía que hacer investigaciones sobre los salvajes primitivos.

vos y cómo ellos se desfiguran tatuándose y mutilándose a sí mismos. Un chico enurético de doce años tenía que despertarse a las cuatro de la mañana y si la cama estaba mojada debía practicar caligrafía.

Erickson utilizaba mitos diferentes que convenían a personalidades diferentes.

En el caso de una mujer con serios problemas sexuales, cuya madre —ya fallecida— le había inculcado principios represivos, dijo: “Insisto en que esas enseñanzas le fueron proporcionadas a usted en su niñez, y que su madre esperaba enseñarle otras cosas cuando usted creciera”. Sugiere que ella bien podría emprender por sí misma la tarea de continuar el curso de educación sexual iniciado por su madre, y que ésta no pudo terminar a causa de su muerte (Haley, 1973).

A través del mito de que “las madres cambian las enseñanzas que imparten a sus hijas cuando crecen”, transformó el mito de la paciente de que “el sexo es malo” en otra cosa.

Erickson poseía una rara habilidad para proseguir con el mito del paciente a la vez que lo definía de un modo tal que otro mito, el suyo, el terapéutico, comenzaba a crecer. En el caso de Harold, por ejemplo, Erickson aceptó la definición de éste de sí mismo como un estúpido retardado, pero le dijo que “tendría que aceptar toda la felicidad que era legítimamente suya, no importando cuán pequeña o grande era la porción” (Haley, 1973).

El trabajo de Cloe Madanes está centrado en la idea de que la función de los síntomas en un niño es la de proteger a sus padres. A medida que transmite esta idea a la familia la convierte en un mito familiar. Si los padres quieren librarse de este mito (¡y cómo no habrían de hacerlo!), tendrán que obrar contra el síntoma que representa el mito.

En todos estos casos el terapeuta debe desarrollar una “creencia” que producirá el cambio. Algunos terapeutas prefieren infiltrar esta nueva creencia indirectamente, con el fin de no provocar resistencia. Ellos podrán también, como Erickson lo hace, aceptar enteramente las “creencias” del paciente, pero al hacerlo derivarán las consecuencias presentadas como “lógica-

cas”, para conducir al paciente a la nueva creencia terapéutica. Otros terapeutas pondrán hábilmente de lado, sin ninguna consideración, los mitos de la familia y los substituirán por nuevas creencias, poniendo a la familia en una inferioridad tal que ninguna acción defensiva parezca posible. Algunas veces Minuchin trabaja así. Las técnicas difieren, pero lo que permanece similar es el uso de diferentes mitos para ofrecer nuevas vías alternativas en el tratamiento de los problemas.

El enfoque sistémico

En el enfoque sistémico la familia es considerada como “un sistema autorregulado que se controla de acuerdo a reglas formadas durante un período de tiempo a través de un proceso de ensayo y error” (Palazzoli y otros, 1978). El grupo natural se convierte en un sistema unido a través de reglas peculiares a él. Puesto que el comportamiento sistémico es parte de la pauta transaccional peculiar al sistema en el cual tiene lugar, la manera de eliminar los síntomas consiste en cambiar las reglas. Las técnicas que este enfoque utiliza son paradójales. Las conductas relativas a la disfunción son “connotadas positivamente” a todos los miembros y de este modo se hace un intento de producir el cambio para todos. Al prescribirlo, Palazzoli y sus colegas connotan positivamente la tendencia homeostática del sistema. Los comportamientos sintomáticos son considerados como “positivos” o “buenos” porque están motivados por la tendencia homeostática del sistema.

El mito terapéutico desarrollado y expuesto por ellos a la familia, contempla al síntoma como un sacrificio espontáneo desempeñado por alguien que voluntariamente decide hacerlo así. Este sacrificio espontáneo será alabado por el terapeuta, que lo considerará como algo valioso y deseable.

Lo que los terapeutas sistémicos esperan es que la resistencia al cambio del sistema disminuya, al prescribir ellos mismos la necesidad homeostática como algo valioso y deseable. Pienzan también que la connotación positiva sirve para anular la tensión simétrica latente que existe en estas familias (psicóti-

cas), definiendo las relaciones de los miembros de la familia como complementaria del sistema. Explican que el cambio se produce al verse la familia enfrentada a una paradoja: "¿Por qué una cosa tan buena como la cohesión del grupo requiere la presencia de un paciente? "

No obstante, cuando Palazzoli describe sus prescripciones en *Paradoja y contraparadoja*, emerge otra idea acerca de lo que produce el cambio: "Teníamos que encontrar una versión que paradójicamente trastornara toda la epistemología familiar, que pusiera a todos los miembros de la familia en una posición insostenible, forzándolos de este modo a cambiar".

Un modo alternativo de entender lo que hace la terapia sistémica es comprender el cambio epistemológico de la familia a través de la utilización de un mito terapéutico, que transforma al síntoma en algo inconveniente para todos. Si el síntoma fue beneficioso de alguna manera (y es posible pensar que si no lo fuera hubiera sido destruido), el mito terapéutico lo transforma en el enemigo de la familia. Si anteriormente ayudó de algún modo a sostener y dar apoyo a la familia, ahora destruirá su imagen.

"Sofía está sinceramente convencida de que la familia necesita esa clase de padre y ha tomado sobre sí el asumir el rol. Por eso está sacrificando generosamente su juventud y su femineidad".

Este mito no intenta expresar verdades. Que eso sea así o no, carece de importancia. Lo realmente importante es que tiene que provocar un fuerte rechazo, especialmente en el paciente sintomático, quien es indirectamente descrito como meramente "tonto". El cambio aparece como la única manera de rechazar el mito.

Al síntoma se le asigna un significado tan diferente e indeseable como para provocar un gran rechazo en todos. Se los asocia a un mito terapéutico destinado a ser destruido. Tiene que ser rechazado por el paciente sintomático del que se dice se sacrifica por otros y por la familia, la cual indirectamente es descrita como siendo tan débil e ineficaz que necesita esta clase de sacrificios. Para destruir al mito la familia tiene

que destruir el síntoma. Como éste se halla conectado a ciertos modos de relación, al liberarse de él, se desarrollan nuevas reglas de relación.

Algunas veces el mito terapéutico es propuesto con el propósito de que sea aceptado. En el caso de Agnés, la niña anoréxica, los terapeutas declararon su impotencia después de veinte sesiones. Procediendo así sugieren que "hemos perdido la batalla". Si previamente para ganar su batalla Agnés tenía que morir de hambre, ahora comenzará a comer para probar a los terapeutas que ella es la única ganadora. Asociando "comer" con "ganar", los terapeutas provocarán el cambio de Agnés.

En el caso de la familia Villa, el terapeuta dijo: "solamente cuando la señora Villa tenga alguna idea de cómo recobrar la estima de sus parientes, podremos hablar de hacer una cita para la próxima sesión". Palazzoli y sus colegas dicen: "si la madre abandona la idea de recuperar la estima de sus parientes está cooperando con la cura de su hijo". ¿Pero por qué abandonaría ella esa idea? ¿Por qué abandonaría una idea que ha mantenido por muchos años? Se ve forzada a abandonarla porque el síntoma de su hijo (autismo) está ahora asociado con un mito terapéutico que es inaceptable para ella. El mito terapéutico es que ser querida, cuidada, y apreciada por su suegra, es más importante para ella que amar y cuidar a su hijo. Ser una hija es más importante que ser una madre.

Al rechazar el mito terapéutico ella desarrollará una nueva definición de sí misma como "madre" estableciendo de ese modo una relación diferente con su hijo. El mito en este caso es la relación entre la necesidad de la madre de recuperar la estima de su suegra y el síntoma del chico. Cambiará si se desprende de su necesidad de recuperar la estima de su suegra. Se la hace responsable, en forma clara, de la cura de su hijo. Este es un mandato en el que la elección es lógicamente posible. Aquí el mito terapéutico es transmitido de un modo claro y directo. La cura no es paradójica y el instrumento terapéutico es el mito.

En otro caso de un muchacho anoréxico, Palazzoli toma en consideración el hecho de que siempre se ha esperado de este

chico que siguiera las pautas de comportamiento de su madre antes que las de su padre. (La madre era más culta que el padre.) En este caso el terapeuta simplemente asoció el síntoma del chico a una "enfermedad femenina". Si la familia rechaza la idea de tener un hijo afeminado, tendrá que cambiar su interacción y se le permitirá al chico seguir los pasos de su padre.

El éxito de Palazzoli y Prata en el tratamiento de familias psicóticas con la prescripción del secreto y la desaparición muestra la interesante invención de otros mitos que van a lograr el propósito de ayudar a la familia a organizarse de una manera nueva y "normal".

A los padres del paciente sintomático se les pide mantener en secreto cualquier cosa que se hable en la sesión, cuando son entrevistados a solas. Se les dice que esta es la única manera en que el terapeuta puede actuar, de modo que si pueden lograrlo, su hijo curará. También se les pide desaparecer por una noche, un fin de semana, una semana, y aun un mes.

Los padres son conducidos a creer que hay algo que producirá el cambio. ¿Cómo podrían rehusarse sin negar sus buenas intenciones de ayudar a su hijo? Si se establecen límites claros entre padres e hijos, si los padres se comportan como parejas normales, dejando el hogar y saliendo para pasarlo bien juntos, si se relacionan con sus hijos tratándolos como iguales y delegando en ellos la misma responsabilidad, entonces la organización entera de la familia cambiará. Ellos se volverán también más fuertes como pareja. ¿Acaso las parejas no están enlazadas por secretos que comparten y por actividades que realizan juntos?

El chaman

En su obra sobre la efectividad simbólica, Lévi-Strauss analiza los mecanismos que hacen posible la cura chamánica en culturas americanas. Las mujeres embarazadas que tienen dificultades con su trabajo de parto, pues el bebé no ha nacido dentro del tiempo estipulado, llamarán al chaman para hacer

posible el parto. La explicación cultural de las dificultades de la mujer consiste en que Muu, que representa los espíritus malignos, ha capturado el alma de la mujer embarazada. Para curarla el chaman tiene que recuperar su alma, arrancándola a esos espíritus para devolvérsela a ella. Lo hará por medio de un viaje sobrenatural; el parto entonces ocurrirá.

Las operaciones llevadas a cabo por el chaman pueden tener características materiales, como la succión, la extracción de objetos extraños del cuerpo que él hará aparecer oportunamente, luchas contra los espíritus malignos, etcétera. En el caso analizado por Lévi-Strauss estas maniobras físicas no están presentes. El chaman opera allí sólo en el nivel psicológico por medio de su canción. De este modo Lévi-Strauss muestra la característica puramente simbólica de la acción terapéutica del chaman que ha manipulado el órgano enfermo psicológicamente. Su efectividad se revela en el parto que entonces tendrá lugar. Esa efectividad puede ser mejor entendida en relación con el mito con el cual él está operando. Los monstruos y animales fantásticos que han capturado el útero de la mujer son responsables de su dolor.

El mito terapéutico del chaman consiste en la importancia de nombrar esos animales o criaturas a través de su canto, de modo que la mujer embarazada sea capaz de aprehenderlos y destruir su poder.

Lévi-Strauss resume su pensamiento de la siguiente manera: "La cura consistiría en hacer pensable una situación definida inicialmente en términos afectivos y en hacer aceptable el dolor al espíritu de la mujer embarazada. Que la mitología del chaman no corresponde a una realidad externa es irrelevante, la mujer embarazada cree en él... La relación entre mito y enfermedad establecida por el chaman está dentro del espíritu del paciente: es una relación entre símbolo y cosa simbolizada, entre significante y significación. El chaman provee al paciente de un *lenguaje* por medio del cual los sentimientos pueden ser expresados y formulados. Es el pasaje a esta expresión verbal la que se supone reorganiza la secuencia que ha provocado el sufrimiento. La efectividad simbólica garantizará la armonía del

paralelismo entre mito y operación. El mito y la operación forman una idea donde podremos encontrar siempre la dualidad entre paciente y doctor. En la cura psicoanalítica el doctor opera y el paciente provee el mito; en la cura chamanística el doctor provee el mito y el paciente opera”.

En los términos de esta discusión, la terapia familiar actúa de acuerdo al modelo del chaman de Lévi-Strauss. El terapeuta provee el mito, o al menos lo legitima para la familia que lo ha producido, y la familia opera para hacer desaparecer el síntoma. En terapia familiar, entonces, el terapeuta inventa un mito que algunas veces es tomado de la familia. Entonces traza una analogía entre el mito y el síntoma del paciente o el problema familiar. Delega la responsabilidad de la “operación” en la familia, esto es, la disolución del mito o su aceptación que hará desaparecer al síntoma.

Resumen

En esta nota sugiero que las diferentes terapias familiares pueden entenderse mejor en términos del mito. La efectividad simbólica del mito como instrumento terapéutico es tratada aquí en analogía con la efectividad terapéutica del chaman en el análisis de Lévi-Strauss. Esta aproximación se basa en la idea de que el comportamiento está casualmente relacionado con creencias de tal manera que actuando sobre ellas, la conducta puede ser cambiada. Aunque diferentes terapeutas familiares explican su modo de operar por medio de diferentes teorías, trato de mostrar que todos esos enfoques proceden esencialmente del mismo modo. En realidad, creo que muchas ideas terapéuticas —y no sólo en terapia familiar— también se sirven de mitos para lograr sus propósitos curativos. En diferentes situaciones los seres humanos estructuran campos de creencias que no están destinados a ser sometidas a prueba y refutación, y de las cuales son extraídas las directivas para la acción. El propósito de esas creencias míticas consiste en la confirmación y la fuerza que transmiten a sus portadores. Reconociendo que esta característica es común a diferentes situaciones y a diferentes técnicas terapéuticas se clarifica uno de los problemas básicos de la terapia: por qué las técnicas terapéuticas curan.

Summary

In this paper I suggest that different family therapy approaches can best be understood in terms of myth. The symbolic effectiveness of myth as a therapeutic tool is related here in analogy with the therapeutic effectiveness of the Shaman in Lévi-Strauss' analysis. This approach is based on the idea that behavior is causally related to beliefs in such a way that by acting upon them behavior can be changed. Although different family therapists explain their way of operating through different theories, I try to show here that all those approaches proceed essentially in the same way. In fact, I believe that many therapeutic ideas, not only in family therapy, also use therapeutic myths to achieve their therapeutic purposes. In different situations human beings structure fields of beliefs that are not meant to be submitted to test and refutation and from which directives for action are extracted. The purpose of these mythical beliefs is the confirmation and strength they give their carriers. Acknowledging that this characteristic is common to different situations and to different therapeutic techniques clarifies one of the basic problems of therapy: why therapeutic techniques cure.

Bibliografía

- BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas, *The Social Construction of Reality*, New York, Doubleday, 1966.
- BATESON, Gregory, “Conventions of Communication: Where Validity Depends Upon Belief”, en RUESCH, JUNGEN y BATESON, Gregory, *Communication: the Social Matrix of Psychiatry*, New York, Norton, 1951.
- BATESON, Gregory, *Steps to an Ecology of Mind*, San Francisco, Chandler, 1972.
- FERREIRA, Anthony, “Family Myth and Homeostasis”, *Archives of General Psychiatry*, V. 9, 1963.
- HALEY, Jay, *Uncommon Therapy: the Psychiatric Techniques of Milton Erickson M.D.*, New York, Norton, 1973.
- HALEY, Jay, *Problem Solving Therapy*, New York, Jossey-Bass, 1976.
- HALEY, Jay, *Leaving Home*, New York, McGraw Hill, 1980.
- LEVI-STRAUSS, Claude, *Anthropologie Structurale*, París, Plon, 1958.

LOS MITOS TERAPEUTICOS

- MADANES, Cloë, *Strategic Family Therapy*, New York, Jossey-Bass, 1981.
- MINUCHIN, Salvador, ROSMAN, Bernice y BAKER, Louis, *Psychosomatic Families*, Cambridge, Harvard University Press, 1978.
- MINUCHIN, Salvador, y FISHMAN, Charles (eds.), *Family Therapy Techniques*, Cambridge, Harvard University Press, 1981.
- PAPP, Peggy, "Paradoxes", en MINUCHIN, Salvador, y FISHMAN, Charles (eds.), *Family Therapy Techniques*, Cambridge, Harvard University Press, 1981.
- SELVINI PALAZZOLI, Mara, y BOSCOLO, Luigi, y CECCHIN, Gianfranco, y PRATA, Giuliana, *Paradox and Counterparadox*, New York, Jason Aronson, 1978.
- RUSSELL, Bertrand, *Analysis of the Mind*, London, London University Press, 1950.
- STEWART, John, "Myths of Plato's", en *The Compact Edition of the Oxford English Dictionary*, Oxford, Oxford University Press, 1971.
- WATZLAWICK, Paul, BEAVIN, Janet y JACKSON, Don, *Pragmatics of Human Communication*, New York, Norton, 1967.

CEFYP

CENTRO DE FAMILIAS Y PAREJAS

Director General: Dr. Adolfo Loketek
 Directora de Asistencia: Lic. María Rosa Glasserman
 Directora de Docencia: Lic. Rosalía Bikel

CURSO BREVE DE TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA

Coordinadora: Lic. Silvia Galay. Invitados: Dr. Adolfo Loketek, Lic. M. Rosa Glasserman, Lic. Lía Bikel, Dr. Eduardo Press, Lic. Marta Zeitune.

Temario: — El Modelo Familiar. El Terapeuta Familiar. — Terapia del Encierro en Psicosis. — Terapia de Pareja. — Familias con Miembros Psicosomáticos u Orgánicos. — Genograma. — Ubicación Teórica. Teoría Sistémica. Teoría de la Comunicación. Teoría de las Relaciones Interpersonales.

Cupo: 20 profesionales. Fecha: 8 de Agosto al 21 de Noviembre. Horario: jueves de 19 a 22 horas.

SEMINARIO DE TERAPIA FAMILIAR

Dr. Carmine Saccu, Co-Director del Instituto de Terapia Familiar de Roma.

Metodología: Entrevistas en Vivo. Supervisión en Vivo. Trabajo con el Terapeuta Familiar. Fecha: 4 y 5 de Septiembre de 1985. Horario: de 9 a 12 y de 14,30 a 17,30 horas.

SERRANO 1141 - CAPITAL

T.E. 771-6078



terapia familiare

Organo della Società Italiana di Terapia Familiare

SEMESTRALE DI INFORMAZIONE RELAZIONALE
 EDITO DALL'ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE

Indice generale

- Notiziario italiano ed estero
- Articoli di attualità e cultura, originali e tradotti
- Informazioni dei vari Centri di Terapia Familiare
- Dibattiti e interviste
- Rubrica clinica e didattica
- Rubrica degli audiovisivi
- Lettere della Direzione
- Recensioni di novità editoriali
- Bibliografia ragionata su temi
- Recensioni di Convegni, Congressi, Seminari

A «Terapia Familiare Notizie» collaborano in Italia:

- 1) Il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (Roma)
- 2) Il Centro Studi e Terapia per la psicoterapia della coppia e della famiglia (Roma)
- 3) Il Centro Studi e Ricerche sulla famiglia (Milano)

«Terapia Familiare Notizie» esce in collaborazione con:

- 1) International Network of Family Therapy
- 2) American Family Therapy Association Newsletter
- 3) American Ortho Psychiatric Association Newsletter

Direttore responsabile: Anna M. Nicolò
 Redazione: V. Reno, 30 - 00198 Roma - Tel. (06) 864261

Abbonamento annuo: L. 6.000

Enti e istituzioni: L. 7.500 - numero singolo: L. 3.500

Edizioni Kappa: Piazza Borghese, 6 Roma - Tel. (06) 6790356

Distribuzione: V. Reno, 30 - 00198 Roma - Tel. (06) 864261

Abordaje familiar en el tratamiento de la drogadicción juvenil

Dr. CARLOS MARIA DIAZ USANDIVARAS

Acassuso 907 - San Isidro - Centro de Docencia, Investigación y Asistencia Psicológica.

Intentaré ocuparme en este trabajo de la manera efectiva y concreta en que puede ayudarse a un adolescente o joven que ha iniciado el camino del consumo de drogas.

Nuestra tarea* apunta a aquellas personas jóvenes que viven con sus familias de origen, consumen, todavía, drogas de las llamadas "livianas" —marihuana, cocaína, psicofármacos, etc.—, que no tienden a provocar fuerte dependencia física. Personas que se caracterizan por una forma de vida muy particular: sin límites ni normas sociales, sin ocupación estable definida y con un evidente riesgo de entrar en la delincuencia. En realidad no son verdaderos "Adictos a las Drogas", sino a ese estilo particular de vida del que resulta difícil salir sin ayuda, y que lleva progresivamente a la drogadicción grave, al delito, la cárcel o la muerte. No obstante por razones prácticas utilizaré el término Drogadicto para referirme a ellos.

* Me refiero al equipo Clínico de Terapia Familiar del Centro de Docencia, Investigación y Asistencia Psicológica de San Isidro.

CARLOS MARIA DIAZ USANDIVARAS

La observación proviene de diferentes grupos sociales en los que predomina la familia burguesa de características tradicionales, buen nivel económico o a veces con incongruencias entre un buen nivel de vida y limitados medios para satisfacerlo. Sistemas de creencias muy arraigados, a veces no siempre tan vividos como declarados, y usualmente una cantidad de hijos algo mayor que el promedio. Geográficamente se refiere a la zona Norte del Gran Buenos Aires, que puede considerarse endémica en el uso de drogas. Esta disfuncionalidad es alarmantemente frecuente entre los motivos de consulta de las familias que asistimos.

Nuestra hipótesis de trabajo

Existen factores intrapsíquicos, asentados históricamente en la Personalidad del drogadicto que han sido muy estudiados. Aquí nos proponemos demostrar que, a ellos, se suman otros factores, actuales, relacionados con el contexto en que estos jóvenes viven; en especial la Familia, y su evolución. Que ésta resulta decisiva en la determinación y mantenimiento del problema y es, por lo tanto, la vía de acceso más adecuada para su resolución. Partimos del supuesto de que la conducta normal o desviada está determinada, no sólo desde lo histórico, sino también, por lo actual, en función de la interacción entre los miembros del contexto en que se vive, en especial la Familia. Interesa entonces no tanto lo que pasa "dentro" de la gente sino más bien lo que pasa "entre" la gente.

La Familia es un Sistema Homeostático en Evolución gobernado por Reglas, establecidas por la conjunción de lo Histórico con lo Actual.

Entender a la Familia como un Sistema significa pensar en términos de una totalidad, que es más que la suma de sus individuos componentes. La Familia, como todo sistema, posee una estructura y por lo tanto una organización y una jerarquía. Esta organización no es estática sino que evoluciona, como todo sistema vivo, según lo que llamamos el Ciclo Vital de la Familia. Entonces, el trastorno del paciente identificado no

puede ser comprendido aislado de su contexto y debemos suponer que él no es más que una parte de una totalidad más amplia: su familia.

Antecedentes:

La Psicología Individual se ocupó extensamente del tema aunque con resultados poco alentadores como lo señalamos en un trabajo anterior (C. Díaz Usandivaras y D. Durán - 1984).

Sobre los antecedentes en Terapia Familiar podemos recordar que ya en sus primeros trabajos Ackerman (N. Ackerman, 1958) señala que la impotencia terapéutica para encarar al adolescente psicopático se resuelve si se toma como Unidad de la Terapia a la Familia Completa.

Aunque no se refieran específicamente al problema, debemos mencionar los trabajos de S. Minuchin y B. Montalvo (Minuchin, S., 1965) y (Minuchin, S. y Montalvo, B., 1967) sobre su experiencia en la Wiltwyck School, con familias desorganizadas con hijos delincuentes y nivel socioeconómico bajo. Ellas se refieren a la importancia de la reestructuración activa, mediante la dramatización en sesión y la resolución directa de conflictos, así como la realización de tareas que abran nuevas alternativas a la familia.

J. Haley, centró su investigación en las relaciones de Poder, dentro de la organización jerárquica del sistema Familiar. Expuso la importancia de la metacomunicación, para la definición de la relación o manejo del poder entre dos personas (J. Haley, 1966). Posteriormente al pensar en términos triádicos en vez de diádicos, incluyó el concepto de estructura y con ésta la organización y la jerarquía. J. Haley dice que "la aparición de síntomas es índice de que en la organización hay un ordenamiento jerárquico confuso" y también que "la jerarquía más elemental involucra el límite generacional" (J. Haley - 1980 - 2). Son conocidos sus exitosos tratamientos de drogadicción graves con Terapia Estratégica Familiar (J. Haley - 1980 - 1), (J. Haley - 1980 - 3), (J. Haley, 1984). Haley plantea la hipótesis de que el hijo sintomático, está protegiendo a sus padres con su

patología o al menos tratando de mantenerlos unidos (J. Haley - 1980 - 1).

Más recientemente C. Madanes destaca la importancia de la Incongruencia Jerárquica en la Estructura Familiar de diversos trastornos graves y en especial de Drogadictos. El joven domina a sus padres a través de la impotencia de éstos ante su conducta. Madanes sostiene que si la conducta tuvo en algún momento la benévola intención de ayudar a sus padres, aunque sea de una manera equivocada, ya ha dejado de tenerla, sólo sirviendo a los fines de la explotación de sus ventajas, y se estabiliza en un sistema disfuncional, independiente de las causas que lo generaron. "La incongruencia jerárquica es, en sí misma, una situación de doble vínculo y en consecuencia patógena, porque se define a la vez al progenitor como una persona a cargo de una familia y simultáneamente como una persona tiranizada y explotada por su propio hijo". "La cuestión es que para resolver el problema, debe modificarse la jerarquía, reinstaurando una, en la que el joven no domine a sus progenitores con su desvalimiento y sus abusos" (Madianes C., 1982).

D. Stanton, psicólogo formado en Psicología Familiar e influenciado profundamente por las ideas de Haley, que había sido designado en 1969 para desarrollar el primer programa sistemático de tratamiento de problemas de drogas en Vietnam, se dedicó al tema en Filadelfia, donde se asoció con T. Todd en 1972. Con el apoyo de Salvador Minuchin y una subvención del Instituto Nacional de Abuso de Drogas (N.I.D.A.), se desarrolló (en la Filadelfia Child Guidance Clinic) el que podríamos considerar actualmente uno de los programas más ambiciosos y completos de investigación sobre el tratamiento de Drogadictos (D. Stanton y T. Todd, 1982).

Al respecto, Salvador Minuchin en su prólogo del libro de Stanton y Todd sobre "Terapia Familiar y Abuso de Drogas y Drogadicción", dice: "En un campo en el que la mayor parte de los programas focalizan en la autorresponsabilidad, proximidad, cohesión del grupo y simetría, los autores enfatizan la responsabilidad mutua de los miembros de la familia en el

funcionamiento familiar y desarrollan un método terapéutico que focaliza en la reestructuración jerárquica y la distancia". Este párrafo marca las diferencias fundamentales entre este enfoque y otros bastante usuales hasta el momento. Ellos desarrollaron una técnica de terapia Familiar que combina al Modelo Estructural de Minuchin con el Estratégico de Haley y Madanes. La tarea comienza siendo directa y artesanal, estructural, amplificando progresivamente los cambios que pueden lograrse, pero ante resistencias mayores o tendencias homeostáticas severas de un sistema rígido, se recurre a técnicas indirectas, paradójales, o a directivas específicas, propias del modelo estratégico (D. Stanton, 1981). Con ellas se busca la alianza con la resistencia para desequilibrar y provocar cambios por reacción, usando la connotación positiva de la interacción familiar, la prescripción del síntoma o de las reglas disfuncionales; y más adelante regresar a la técnica estructural, cuando se hayan logrado suficientes cambios en el sistema.

Nuestro modelo de trabajo:

Abordamos este problema con Terapia Familiar, siguiendo el Paradigma Sistémico, incluyendo algunos elementos del Psicoanálisis, como la Teoría de la Identificación, ingrediente inevitable de la vertiente histórica de las reglas familiares. Adoptamos el modelo Estructural Estratégico de Stanton y Todd al que se aproxima nuestro "Modelo Clínico-Estratégico" de Terapia Familiar, que empleamos en general.

Desde hace ya algún tiempo, desarrollamos un esquema o modelo intermedio para pensar y operar clínicamente en todos nuestros casos, basado en cinco vectores. Tomamos de Sluzki los tres primeros (C. Sluzki, 1983):

- 1) La Interacción Familiar.
- 2) La Estructura Familiar.
- 3) La Construcción de la Realidad o Epistemología de la Familia.

A los que agregamos:

4) La Evolución - Individuación en el Ciclo de la Vida Familiar.

5) La Autoestima en Relación con la Confirmación de los otros.

El primer vector: La Interacción, se refiere a las Pautas Comunicacionales de Mantenimiento que perpetúan el síntoma y a los manejos Homeostáticos de la Familia.

El segundo vector: La Estructura, se refiere a los conceptos de poder y de Fronteras entre los diferentes subsistemas.

El tercer vector: La Construcción de la Realidad se refiere a las concepciones actuales e históricas de la Familia y su grupo social, sobre los aspectos de la realidad, que llegan a veces a convertirse en Mitos Familiares.

El cuarto vector: La Evolución - Individuación tiene que ver con el proceso de discriminación evolutiva que gradualmente todo individuo va logrando como "figura", desde el "fondo" indiferenciado de su familia de origen.

El quinto vector: La Autoestima en relación con la Confirmación de los otros, tiene que ver con el grado en que la propia identidad y el mantenimiento de la autoestima depende de la relación complementaria con los otros y de la confirmación que ellos proveen (R. Laing, 1974).

Este esquema adolece de las limitaciones de todas las simplificaciones pero nos ha sido útil para ordenar nuestro pensamiento así como para la formulación de objetivos y estrategias de cambio. Aplicándolo en este tema encontramos:

1. La Interacción en la Familia del Drogadicto

Estos padres en general no pueden definir la relación con sus hijos respecto a lo que esperan de ellos. Diríamos que "esperan que sus hijos hagan, espontáneamente, lo que ellos quieren que hagan", lo cual es una paradoja que impide pensar y aprender.

Existe un ciclo muy frecuente y característico que es el siguiente: Un hijo tiene una conducta inaceptable. El padre es el que lo suele reprimir, habitualmente exasperado o muchas

veces a pedido o instigado por la madre. Cuando el padre lo reprime, la madre acusa al padre de violento e inmediatamente protege al hijo de la represión del padre, la consecuencia de esto es que el padre desiste y se aleja, o se exaspera más, con lo cual aumenta su impotencia; el hijo reincide en su conducta sintomática y se reinicia el ciclo. Esto tiene origen en un proceso que yo llamaría de "Escalada Complementaria", en el que estos padres se convierten en una caricatura de sus propias personalidades o de sus propios estilos de conducta. Donde, como la madre sabe que el padre es violento, ella trata de nivelar siendo más protectora y, como el padre sabe que la madre es protectora, él trata de ser más violento para compensar, lo cual hace que los dos extremen sus características y finalmente sea algo muy distinto a lo que realmente serían.

Otro ciclo, que se relaciona con la situación homeostática de la Familia es el siguiente: Los padres se pelean o se alejan. El hijo se hace sintomático para unirlos. Ante la situación sintomática del hijo los padres se unen para atenderlo. Ante la unión de los padres el hijo se mejora, porque los padres parecen ya no necesitarlo, y ante esta situación los padres vuelven a pelear y a separarse, con lo que se reinicia el ciclo.

Otro problema característico es el de la Depositación del Paciente identificado. En estos casos, si pensamos circularmente debemos detectar a: 1°) el Depositante, 2°) lo Depositado y 3°) el Depositario (Pichon-Rivière). El ciclo no puede concretarse si no existen los tres elementos. El Depositante es la familia, los padres o al menos uno de ellos que está desertando de su responsabilidad parental y endosándosela a alguien de afuera. Lo Depositado es el adolescente en problemas y el Depositario suele ser alguno de los niveles terapéuticos o asistenciales que se hace cargo del "paquete". La importancia terapéutica de esto es clara si asumimos que frecuentemente somos quienes debemos ayudar al cambio de conducta de la Familia los que entramos en este ciclo autoperpetuante, al aceptar iatrogénicamente la función de Depositarios. En efecto, el Depositante no puede concretar su desertión si no encuentra la complementariedad funcional del Depositario que se haga cargo del drogadic-

to. Esto es en última instancia lo que sucede frecuentemente con la institucionalización, hospitalización, internación o tratamiento, en los que alguien se embarca en un plan en el que no están comprometidos los padres como activos responsables del mismo.

2. La Estructura en la Familia del Drogadicto

En estas familias existe una seria perturbación en su estructura, caracterizada por:

1) Una mala diferenciación entre el Subsistema Parental y el Subsistema Fraternal, que no tiene suficiente Frontera divisoria.

2) Una Incongruencia Jerárquica, en cuanto a que los padres no detentan el Poder y Prestigio necesario para desempeñarse de acuerdo a su Jerarquía y ejercer su Autoridad sobre los hijos.

3) Una mala Alianza de la Pareja Parental, a veces por enfrentamientos maritales; simetría, abierta o más frecuentemente encubierta, que lleva inevitablemente a la introducción de hijos como terceros en el conflicto. Esto configura coaliciones de uno de los padres con los hijos, contra el otro cónyuge, que se caracterizan por ser: 1°) Intergeneracionales. Uno de los Padres y un hijo. 2°) Constituyen la unión de ambos para ir contra el otro padre. 3°) Son manifiestas en un nivel y negadas en otro, constituyendo así un mensaje contradictorio (J. Haley, 1967). Los padres obedecen al hijo, que es quien tiene el control de la familia, a través de sus síntomas, de los que no se hace responsable.

La organización familiar gira alrededor del problema del Drogadicto. Los padres hacen de su cuidado el fin y objeto de sus vidas; pero se declaran reiteradamente incompetentes e impotentes ante el síntoma, lo que es en realidad una forma oculta de desentenderse y abandonar al hijo sintomático a su suerte. Mientras ellos no tengan poder no pueden ayudar a su hijo.

Como la mayor cantidad de casos se da en varones, se

describen generalmente los patrones Familiares correspondientes a un Hijo, cuando se trata de una Hija los patrones se invierten. Siempre existe un miembro de la familia que es cómplice, consciente o inconsciente, del Drogadicto. Casi siempre uno de sus padres, más frecuentemente la madre. Esta tiene con él relaciones de gran proximidad siendo sobreprotectora y sobreindulgente. Es frecuente que el padre en cambio sea débil, distante e inconstante, o autoritario y violento, pero débil ante su esposa que lo neutraliza, es un "cuco de cartón". La coalición lo ha debilitado y excluido o ha estimulado su alejamiento. Esto puede verse claramente en el juego de secretos, insidias y encubrimientos o en el manejo del dinero, que el Drogadicto siempre recibe de algún adulto de su familia a sabiendas de que será gastado en drogas. Las relaciones con el mundo exterior son precarias y sólo sirven al propósito de la parodia de individuación que representa la Drogadicción, excepto en aquellos casos en que la pertenencia a una pandilla juvenil funciona como una familia sustituta que reemplaza parcialmente a la abandonada familia original. Esta es, en realidad una familia incapaz de dar amor, en tanto que por falta de poder, no puede hacerse cargo de dar cuidado ni continencia. El subsistema fraterno está dislocado y no existe alianza entre los hermanos, a veces, hay conflictos por rivalidades internas. El drogadicto suele tener groseros privilegios sobre sus hermanos.

3. *La Construcción de la Realidad en la Familia del Drogadicto*

El primer mito de la familia es que el Drogadicto es "diferente", generalmente "superior", pese a sus problemas, al resto de sus iguales. Existe algo así como una reverencia sagrada a su figura, temida por la implícita o explícita amenaza de sus represalias. La droga es algo incomprensible que escapa totalmente al manejo de los padres o la familia. Es evidentemente, cosa de expertos, lo que ofrece un buen argumento para la "depositación", exagerando su impotencia ante la importancia de la dependencia física, que escapa a su manejo. Existe en

los padres una actitud de desafío constante al problema, similar al del alcoholista que desafía a la botella, creyendo que puede ganarle y falla. Ellos siempre creen que "deben darle al Drogadicto otra oportunidad", que "ahora le tienen fe", que "esta vez él va a poder...". Es frecuente que en otros niveles los miembros de la familia violen la ley, siendo la actitud del hijo una metáfora de algo grave que sucede a uno de los padres. Se calcula que en el 80% de los casos hay uno de ellos con problemas de alcoholismo o uso de drogas.

Otro de los mitos es el "Síndrome de Abstinencia", característico de la dependencia física, muy poco común con las drogas y dosis más frecuentemente usadas, pero que sume a la familia en la impotencia ante el terror de que el paciente, "se vuelva loco" si le falta la droga. Lamentablemente esto está muy estimulado por los medios de comunicación masiva, la literatura, etc.

Otro elemento infaltable es el tema de la muerte, con la que parecen tener gran afinidad. Estas familias tienen antecedentes de muertes prematuras, en accidentes o situaciones isomórficas con la muerte, como la separación, el alejamiento, etc. Lo que uno percibe es algo así como el mensaje de que: "nosotros estamos muy familiarizados con la muerte, nos llevamos muy bien con ella y no nos asusta". Esto ocasionalmente da lugar a que tengamos que usar técnicas de escalada, o provocación donde, en vez de asustarnos de toda esta carga de muerte, debemos ponernos más "necrófilos que ellos".

Otro de los mitos es que la Drogadicción es, como todo síntoma, "Involuntario". No es que el Drogadicto quiere drogarse sino que no puede dejar de hacerlo. Es fundamental que nosotros podamos definir esta situación como voluntaria para que pueda ser modificada (C. Madanes, 1984).

La subcultura de la Droga está rodeada de mitos, uno de ellos es que la marihuana no provoca adicción. Esto tiene algo de cierto desde el punto de vista de la dependencia física, pero la marihuana es siempre la primera etapa de una carrera que va mucho más lejos, casi todos los drogadictos graves empezaron

con ella. Lo peligroso no es el efecto específico de la droga sino el hábito de consumirlas.

Se describe también la disparidad transcultural entre padres e hijos. Padres que suelen ser inmigrantes, o que tienen una cultura diferente a aquella en la que se desarrollan sus hijos.

Otro tema importante suele ser la profecía autocumplidora. Los mitos familiares que hacen que quede señalado un miembro de la familia que posteriormente desarrollará conductas de riesgo. Las profecías autocumplidoras más importantes son las que se dan en relación con el divorcio de los padres.

A veces se da una confusión entre los conflictos de la Pareja Parental y la Pareja Marital. Es común que una esposa que no se anima a encarar a su esposo como un mal marido, lo defina como un mal padre. Entonces un mal padre no puede menos que ser responsable de tener un hijo enfermo, un drogadicto por ejemplo, que debe mantenerse así, si el padre no mejora como esposo, para mantener esta epistemología descalificante del padre como tal.

Finalmente podemos señalar a los padres respetuosos de la libertad del hijo para llevar este tipo de vida. Es en realidad una pseudolibertad, un "como si", que encubre el abandono y la deserción parental, tramposamente, porque lo lleva a perder la verdadera libertad o la vida.

4. La Evolución y la Individuación en el Ciclo de la Vida Familiar del Drogadicto:

El trastorno que estudiamos se da significativamente en dos momentos críticos de la vida familiar:

1º) La irrupción de la adolescencia con sus características de individuación y discriminación "Adolescente-Familia".

2º) El momento en que los jóvenes deben dejar la casa de sus padres para iniciar su vida independiente. Siendo la primera una metáfora de la segunda.

En estas familias ambos son difíciles o imposibles, porque el rígido sistema familiar no tolera el cambio que esto significa.

La drogadicción resulta así una buena manera de no

cambiar, es decir, de que el Ciclo de la Vida Familiar se detenga y la Familia no crezca (J. Haley - 1980 - 1). Tal vez lo original de este enfoque sea que la patología es pensada como causa más que como consecuencia. Se enferma "para" no crecer y no "por" no crecer.

La detención de este desarrollo centrífugo del ciclo de la vida Familiar da lugar a que el Paciente Identificado se convierte en "Una Función" estabilizadora del Sistema Familiar perdiendo su espacio personal propio o no pudiendo desarrollarlo. Esta constricción de Funciones implica una pérdida de alternativas (Andolfi - 1983), ya que la única que le queda al paciente es seguir drogándose.

La paradoja de la "Individuación" es que el drogadicto hace grandes declaraciones de independencia pero es un ser absolutamente dependiente de su familia en la que está atrapado. Es entonces una pseudoindividuación.

5. La Autoestima en Relación con la Confirmación de los otros en la Familia del Drogadicto

El Drogadicto es alguien sólo confirmado, por su familia, en su identidad de desviado, desvalido e incompetente. Se le reconoce solamente su competencia para ser incompetente (D. Stanton y T. Todd - 1982), o implícitamente para mantener la estabilidad homeostática de su familia.

Desarrollo del Proceso:

Las características descritas en estos cinco vectores se instalan progresivamente en un proceso que podríamos esquematizar en tres etapas:

1) Etapa inicial o de descontrol: puede comenzar en la infancia y su característica es el desafío a padres incompetentes que termina en la incongruencia jerárquica, y en la que generalmente no hay consumo de drogas. Su característica más típica es el trastorno de conducta escolar a veces confundido con trastornos del aprendizaje. Chicos que tienen fracasos escolares no porque no puedan aprender sino porque no

ABORDAJE FAMILIAR EN DROGADICCION JUVENIL

quieren estudiar o que se hacen expulsar de los colegios por mala conducta. Estos casos consultan ocasionalmente en este nivel y aunque no pertenecen específicamente al tema en cuestión los incluimos porque tienen un valor preventivo muy importante. En casi todas las historias de casos de Drogadicción o uso de drogas, existe siempre el antecedente de esta etapa previa.

2) Etapa de Uso de Drogas: En ésta el descontrol es casi total o total y aceptado por los padres, aunque con algunos intentos fallidos de control. Hay uso de drogas "livianas" pero generalmente no hay "adicción".

La droga es tácitamente aceptada por los padres con el argumento de "no perder al hijo", o ignorada, como negación de una evidencia obvia. Es el caso más frecuente y son adolescentes de alto riesgo, no solamente por la posibilidad de pasar a la etapa siguiente de verdadera adicción, sino porque el consumo de Drogas involucra un conjunto de otros peligros como las sobredosis, conflictos policiales o con traficantes, accidentes estando drogados, etc.

3) Etapa de Abuso de Drogas o de Drogadicción Propiamente Dicha: Hay ya uso y abuso de las llamadas drogas "pesadas", como los narcóticos, adicción y/o ocasional dependencia física, antecedentes judiciales y/o penales, proceso estabilizado, altamente homeostático en la familia, con componentes individuales y somáticos que complican la acción terapéutica. No es tan frecuente, en mi experiencia. Este nivel puede requerir algunas terapias combinadas.

Terapéutica:

1 - Objetivos:

En orden de importancia y oportunidad deben lograrse:

A) La supresión del consumo de Drogas: que debe ser total, absoluta, inmediata y lo más rápida posible.

B) El uso productivo del Tiempo: la segunda adicción es el mal uso del tiempo, la vagancia.

CARLOS MARIA DIAZ USANDIVARAS

C) La mayor autonomía respecto a la Familia: en los casos de adolescentes mayores o jóvenes puede constituir directamente en que el hijo abandone la casa de los padres.

2 - Estrategia y Proceso:

Es imprescindible involucrar a la familia desde el primer momento y hacerla protagonista del proceso. Ellos traen al "enfermo" y lo depositan en terapia con la idea de retirarse dejándolo en manos expertas. Debemos impedir que se retiren. Para esto el paso siguiente es desmitificar la Drogadicción, sobre todo la dependencia física, y redefinir el trastorno como voluntario: "mala conducta", en vez de enfermedad o conducta involuntaria, ajena a la responsabilidad del drogadicto y de su familia. (Madanes, 1982). Esto permite que el problema no dependa del profesional experto que lo cure, sino de los padres, con autoridad, que lo corrijan. Aquí empieza el proceso de restitución de la autoridad y de la jerarquía superior de los padres que deben "Hacerse Cargo" de su hijo, esto es "Corregirlo", y de esta manera demostrarle su amor.

Así comenzamos a: resolver la Incongruencia Jerárquica, aliar a la pareja parental, romper las coaliciones intergeneracionales y delimitar fronteras entre los subsistemas. Uno de los recursos más prácticos para lograr estos cuatro objetivos es la técnica de "Poner a los Padres a Cargo" (J. Haley, 1980-1), (Kaufman, 1979). Esto significa comprometer a ambos en un acuerdo mínimo básico, para que ellos asuman la responsabilidad por lo que haga el hijo. Esto es muy importante porque en esta etapa la terapia no debe apuntar al hijo, al paciente identificado, sino a los Padres. Este recurso de "Poner a los Padres a Cargo" logra el fin homeostático que tenía la drogadicción, precisamente de hacer que el drogadicto una a los padres, invirtiendo los medios empleados. Unir a los padres no a través de que el hijo se drogue sino de que deje de drogarse. Es decir, se cumple la misma función, pero con resultados terapéuticos en vez de patógenos.

El paso siguiente es alentar a los padres a planificar medidas

concretas de vida saludable para el hijo, guiados, apoyados o presionados por el terapeuta, que debe ayudarles a perder el miedo a las extorsiones del drogadicto. Se crea una situación de conflicto y tensión, que el terapeuta debe velar porque se resuelva siempre con el triunfo de los padres, quienes así recuperarán poco a poco el poder y la jerarquía. En este momento el terapeuta puede recurrir a técnicas de provocación como "sembrar cizaña" entre los padres y el hijo o redefinirlo a éste como fuerte, inteligente y poderoso, de quien deben defenderse para que no los confunda, en vez de un pobre muchacho enfermo y débil, que en realidad los explota con este argumento. Nuestro objetivo terapéutico son los padres. Por lo menos el objetivo práctico. Habitualmente casi ignoramos al hijo, hasta que se restituye la jerarquía. Nos ocupamos de que ellos puedan realmente sentirse sostenidos, apoyados y buscamos que logren un mínimo de acuerdo, difícil, porque son Parejas Parentales que tienen muchos desacuerdos. Este es uno de los puntos más difíciles. Lo único que da poder a los padres es su alianza y acuerdo. Si la Pareja Marital está en dificultades, alentamos el refuerzo de la Pareja Parental y la postergación de los conflictos maritales para cuando el drogadicto esté mejor. Por el contrario, nada quita más poder a los padres y los sume en la Incongruencia Jerárquica, que las coaliciones de alguno de ellos con el hijo.

Debemos cuidar los secretos que se comparten con unos y excluyen a otros, y "construir realidades diferentes" como plantear que el hijo "estaba confundido y creía que su madre era su cómplice". Simultáneamente es necesario insistir en lo difícil de la tarea, aún exagerando las dificultades, desafiándolos a realizarlas o asustándolos, exagerando también la gravedad del problema y sus riesgos, para luchar contra su negación, pero dándoles ayuda y soluciones. Muchas veces la situación de fuerza lleva a la violencia que es preferible evitar, aunque esto no siempre se logre. Es mejor una Reestructuración Jerárquica violenta que una Incongruencia Jerárquica. A veces la situación lleva a la tentativa de expulsión del hijo por la familia. Esta "solución" debe ser desalentada, 1) porque cambia la lucha

afectuosa, aunque violenta, para cuidar del hijo por el rechazo hostil, 2) porque es siempre falsa y cíclica; dado que si son padres que no soportan que el hijo se aleje "sano" de la familia, mucho menos permitirían que lo haga "enfermo", puesto que es esto en última instancia lo que está al servicio de su permanencia en casa. Es fundamental alterar la complementariedad de los padres, por ejemplo logrando que controle al hijo el progenitor que lo encubría y no el que cumplía habitualmente la función de "represor".

En los casos en los que hay una situación de intoxicación es especialmente útil e importante intentar la desintoxicación en la propia casa a cargo de la familia, para evitar la depositación y que el Paciente Identificado pase a estar a cargo de una institución u otra persona ajena, en la medida en que esto es posible.

Debe aclararse que las medidas de contención y control, internación en su casa, vigilancia permanente, prohibición de salir solo, reglamentación de horarios de vida, trabajo, estudio, etc. . . . son importantes por sí mismas, por ser organizadoras de conductas saludables; pero más aún resultan decisivas en tanto son expresiones de la Jerarquía y Poder congruentes de los padres.

Es fundamental desmitificar la construcción "bizarra" de la realidad que trae la Familia y en especial el Paciente Identificado, construyendo realidades terapéuticas alternativas. De cualquier manera es importante que esto no implique cuestionar abiertamente al sistema,

El narcisismo de sus integrantes no toleraría la crítica, por lo cual es necesario connotar positivamente las acciones de la familia o al menos atribuirles "Buenas intenciones" (Stanton y Todd, 1982). Enfrentar sin temor el tema de la muerte y las identificaciones históricas que repiten conductas, a través de la Transferencia Relacional Dominante (C.E.F. y P.) para lo que resulta de gran utilidad trabajar con el Genograma Familiar.

Si el drogadicto ve una auténtica actitud de continencia, afectuosa y firme generalmente acepta la puesta de límites, siendo asombrosamente más dócil de lo esperado. En estos

momentos hay que cuidarse, más que de la rebeldía del hijo, de la provocación sutil de los padres que, en forma oculta, lo alientan a rebelarse o reincidir o, al verlo mejor, se distancian y entran en conflicto, con lo cual todo vuelve al punto de partida y se reinicia el ciclo. Esta "Crisis Homeostática", es casi una etapa ineludible del proceso. Generalmente se manifiesta como un grave conflicto matrimonial con inminencia de Divorcio, una grave Depresión de uno de los progenitores o alguna perturbación grave de otro miembro de la Familia. Es como una señal de que el Paciente Identificado no puede cambiar, que no puede dejar de drogarse porque sino todos empeorarían. Este es uno de los momentos más críticos del proceso y es muy importante que el terapeuta apoye a la Familia, que esté cerca y a su disposición y que los aliente a postergar pleitos Maritales en beneficio de la eficiencia Parental que exige la tarea.

A medida que se redefinen las jerarquías congruentes y el adolescente acepta a sus padres resulta útil encarar actitudes constructivas. Es más fácil crear nuevas conductas útiles que extinguir antiguas conductas viciadas. Una maniobra útil es alentar la alianza fraterna, promover salidas o más compañerismo entre los hermanos, buscar elementos que levanten la autoestima. Por otro lado, la Alianza Parental exitosa a veces colabora en el afianzamiento de la Alianza Marital. Ambos procesos ayudarán a reforzar las fronteras entre los subsistemas.

De cualquier manera siempre es necesario prevenir a la familia sobre la posibilidad de reincidencia, exagerándola para que no se desanimen si sucede, pues es frecuente. No es tan grave si no se acompaña de la deserción de los padres.

El objetivo sobre el uso del tiempo: debe apuntar a la exigencia de una actividad útil y rentable, no un simple pasatiempo; que presuma el tratar al Ex-Drogadicto como una persona sana corriente y no como un enfermo. Este tema se vincula con aquellos relacionados con la autoestima y la individuación que preparan para el logro final del proceso terapéutico que es la Autonomía y el alejamiento.

Lograda esta redistribución del poder se irá probando gradualmente la capacidad de autocontrol del joven que resulta,

ahora en otro contexto, más fácil. Sus padres ya no son débiles y no sólo no necesitan de su ayuda sino que no estarán dispuestos a tolerar ninguna inconducta. El paciente se siente reimplantado en una familia capaz de dar amor, desde el momento que ha luchado por ayudarlo y en ella podrá continuar creciendo y hacerse adulto y autónomo verdaderamente.

Resulta imprescindible en todo el proceso, que el terapeuta no pierda su poder, pero haga a los padres, dueños del mérito de los logros alcanzados.

No es conveniente que el terapeuta intente arriesgarse a "comprender" al drogadicto en sus motivaciones profundas, al menos en lo manifiesto, en las sesiones, pues arriesga a sobreidentificarlo como enfermo, "sujeto a expertos", a darle otra vez importancia y poder que no le ayudan, o a perderse en complicaciones que los padres no entienden y en consecuencia no pueden manejar. Por este motivo también desaconsejamos cualquier terapia individual simultánea o inmediata que alteraría los objetivos propuestos, al menos hasta el logro de la Autonomía.

3 - Dificultades:

Son muchas y llevan fácilmente al desaliento de familias y terapeutas.

Con respecto a la Familia destacamos la incapacidad de lograr una razonable y suficiente alianza parental o de lograr autoridad en progenitores que también consumen drogas o alcohol, o familias en las que un hijo parentalizado ocupa el lugar del padre. En estos casos es imprescindible la resolución mínima de estas disfuncionalidades antes de encarar el tema en cuestión.

Más importante aún es el capítulo de las dificultades originadas en el sistema terapéutico. El tratamiento de drogadictos es muy difícil, frustrante y con frecuentes fracasos. Todo terapeuta que lo intente debe estar en condiciones de soportar esta herida narcisística. La mayor dificultad y causa de

fracasos es seguramente contratransferencial. Es la incapacidad de resistirse a la altísima provocación de un sistema a veces filicida y perverso, lleno de insidias y contradicciones que sacan al terapeuta de su lugar y lo embanderan en actitudes condenatorias de los padres que sólo sirven para perder la única oportunidad terapéutica que es su colaboración.

Prevención:

De toda esta descripción surge la clara indicación de que ésta debe apuntar a los padres y no a los jóvenes. Debe apoyarse todo aquello que ayude a los padres a no perder la Estructura Jerárquica de la familia y el control de sus hijos a través de conductas con auténtica autoridad y no con autoritarismo que es sólo expresión de debilidad.

Debe combatirse todo aquello que los debilite, culpabilice o cree inseguridad en su función. A propósito me atrevo a señalar algo así como un "nuevo Malestar en la Cultura", del que somos bastante responsables. La reiterada incidencia de opiniones técnicas y científicas provenientes de la Psicología y la Psiquiatría sobre los padres y sus funciones a través de los medios de comunicación masiva les están creando dudas e inseguridad que perturban el desempeño natural y espontáneo de su función parental. Muchos padres creen ahora que no pueden serlo si no van "a la Escuela" donde les enseñen cómo criar a sus hijos.

La detección precoz de situaciones de pérdida de control parental, en especial en cuanto al desempeño escolar, es imprescindible para proceder a su inmediato tratamiento y evitar el pasaje a las siguientes etapas de mayor riesgo.

Con respecto a lo que se hace directamente sobre los adolescentes y jóvenes sobre información, propaganda, etc., se hace innecesario si la estructura familiar no es disfuncional y arriesga, por el contrario, a dar excesiva importancia y publicidad al tema ante quienes pueden mal utilizarlo.

Resumen:

Se describe la forma en que puede ayudarse a un consumidor de drogas o drogadicto a través de la Terapia Familiar, a la que consideramos la vía más adecuada. Se citan algunos antecedentes y el Modelo de Stanton y Todd. Se describe nuestro modelo de trabajo orientado por cinco vectores: la Interacción, la Estructura, la Construcción de la Realidad, la Evolución-Individuación en el Ciclo de la Vida Familiar y la Autoestima en relación con la confirmación de los Otros. Se describen las características de estas familias según estos cinco vectores y el desarrollo del proceso así como la Terapéutica con sus objetivos, estrategia y dificultades. Se explicitan algunos enfoques preventivos.

Summary:

It describes the way in which a drug abuser or an addict can be helped through Family Therapy, which we consider to be the most adequate way. Some previous works are cited as well as Stanton-Todd Model. It also describes our own working model which is oriented by five vectors: Interaction, Structure, Reality Construction, Evolution-Individuation in the Family Life Cycle and the Self-Esteem related to confirmation by others. It describes the characteristics of these families according to these five vectors and the development of the process as well as the Therapy to be used, with its objectives, strategy and difficulties. It also explains some prevention approaches.

Bibliografía

- ACKERMAN, N. , 1958, "Trastornos de la Adolescencia", "Conducta Psicopática del Adolescente", en *Diagnóstico y Tratamiento de las Relaciones Familiares*, Ed. Hormé.
- ACKERMAN, N. 1976, "Los Problemas Adolescentes. Síntoma de un Trastorno Familiar" en *Grupoterapia de la Familia*, Ed. Hormé.
- ANDOLFI, M. y colaboradores, 1983, *Behind The Family Mask*, BRUNER/MAZEL.
- DIAZ USANDIVARAS, C. y DURAN, D., 1984. "Los Padres de la Droga", Trabajo presentado en el Primer Congreso de Psicología Social Universidad de Belgrano.

ABORDAJE FAMILIAR EN DROGADICCION JUVENIL

- HALEY, J., 1966, *Estrategias en psicoterapia*, Ed. Toray.
- HALEY, J., 1967, "Towards a Theory of Pathological Systems" en *Reflections on Therapy*, Pub. by The Family Therapy.
- HALEY, J., 1980/1, *Leaving Home*, Mc Graw Hill Books Co.
- HALEY, J., 1980/2, *Terapia para resolver Problemas*, Ed. Amorrortu, Cap. 4.
- HALEY, J., 1980/3, "Heroin My Baby: A Clinical Model", Cap. 7 de *The Family Therapy of Drug Abuse and Addiction*, de D. STANTON y T. TODD y en "film" en el Primer Congreso Argentino de Psicología y Psicoterapia de Grupo, Buenos Aires, 1981.
- HALEY, J., 1984, "La Adicta". Caso presentado en el Seminario de Terapia Familiar Estratégica, Buenos Aires, 1984.
- HUBERTY, D. y HUBERTY, C., 1983, "Drug Abuse". Cap. 5 de *Helping Families with Special Problems*, Edit. M. Textor, Jason Aronson Press.
- KAUFMAN, E., 1979, "The Application of the Basic Principles of Family Therapy to the Treatment of Drug and Alcohol Abusers", Cap. 17 de *Family Therapy of Drug and Alcohol Abuse*. Edit Kaufman y Kaufman, Gardner Press.
- LAING, R., 1961, *El yo y los otros*, Fondo de Cultura Económica.
- MADANES, C., 1982, "Problemas Graves de la Adolescencia. Como lograr que los padres se hagan cargo". Cap. 6 de *Terapia Familiar Estratégica*, Ed. Amorrortu.
- MADANES, C., 1984, *Behind the One Way Mirror*, Jossey Bass Publishers.
- MINUCHIN, S., 1965, "Conflicto Resolución en Terapia Familiar" en *Tratamiento de la Familia*. Recop. J. Haley, Ed. Toray, 1974.
- MINUCHIN, S. y MONTALVO, B., 1967, "Técnicas para trabajar con familias desorganizadas de nivel socioeconómico bajo".
- SLUZKI, C., 1983, "Process, Structure and World Views: Toward an Integrated view of Systemic Models in Family Therapy", *Family Process*, Nro. 22, 1983.
- STANTON, D., 1981, Strategic Approaches to Family Therapy, Cap. 10 de *Hand-book of Family Therapy*
- STANTON, D., 1978, "La Drogadicción y la Familia", Cap. 4 de *Dimensiones de la Terapia Familiar*, Recop. de Andolfi y Zwering, Ed. Paidós.
- STANTON, D. y TODD, T., 1979. "Structural Family Therapy with Drug Addicts", Cap. 4 de *Family Therapy of Drug and Alcohol Abuse*. Edit. Kaufman y Kaufman, Gardner Press.
- STANTON, D. y TODD, T., 1982, "The Family Therapy of Drug Abuse and Adiction", Guilford Press.



The Journal of Marital and Family Therapy

Alan S. Gurman, Ph.D., Editor

The JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY THERAPY is published to advance the professional understanding of marital and family behavior and to improve the psychotherapeutic treatment of marital and family dysfunction. To accomplish this the Journal publishes articles on clinical practice, theory, and research in marital and family therapy. A publication of the American Association for Marriage and Family Therapy.

SUBSCRIPTION ORDER FORM

_____ Individual — \$20/year (4 issues)

_____ Institutional (Libraries and Multi-Reader Establishments) — \$30/year (4 issues)

(Orders outside the United States and Canada request latest prices from JMFT Business Office)

_____ Check Enclosed.

_____ Please bill me for this order plus postage and handling.

Name _____

(or Institution) _____

Address _____

City _____ State/Province _____ Zip _____

Please mail this form to: JMFT Business Office, 924 W Ninth, Upland CA 91786.

Terapia Familiar, 1985, VII, 13/14

Informe preliminar de una investigación: desarrollo de intervenciones terapéuticas alternativas

Lic. ESTRELLA JOSELEVICH - Lic. MARIA ESTER PANIZO

Centro de Familias y Parejas, Serrano 1141, Capital Federal

INTRODUCCION:

El enfoque familiar y el desarrollo de técnicas para modificar las disfunciones familiares, ha sido un paso fundamental en la concepción de la enfermedad mental. Desde la Teoría de la Comunicación y la Teoría General de los Sistemas, se ha llegado a un acuerdo ampliamente aceptado que la enfermedad mental no es algo que "le sucede" al individuo aislado de su contexto, sino que se presenta dentro del sistema familiar y es una propiedad del mismo. Una manera rápida, efectiva y económica de abordar los problemas, es incluyéndolos y modificándolos dentro de la organización familiar. La transformación de algún aspecto de las relaciones familiares, produce una transformación de la estructura, que puede llegar luego espontáneamente a otros cambios en el sistema.

Desde esta postura es que realizamos terapias de corta duración y objetivos limitados, con posteriores seguimientos para evaluar la continuidad de los cambios.

Muy lejos de pretender universalizar los beneficios y posibi-

ESTRELLA JOSELEVICH - MARIA ESTER PANIZO

lidades de la terapia familiar, creemos que este enfoque nos permite fundamentar nuestro interés y objetivos de investigación alrededor del desarrollo de posibilidades de intervenciones terapéuticas alternativas y "la cocina" de las mismas.

El objetivo de esta investigación es el estudio y comparación de nuestras intervenciones terapéuticas en diferentes procesos complejos. Calculamos trabajar de 6 a 8 años en este proyecto, que aunque es prolongado e importante en el tiempo, es humilde y acotado en cantidad de casos a tratarse. Compararemos casos, intervenciones y procesos, o más bien, compararemos "la cocina" de dichas intervenciones. Este informe es sólo el primer tramo de todo el proyecto de trabajo.

Dado que en psicoterapia, nosotros somos nuestra propia herramienta y toda intervención se realiza desde y a través de nosotros mismos, nos parece útil especificar:

- 1) Qué estrategias y/o técnicas de intervención utilizamos.
- 2) Cómo decidimos una intervención.
- 3) Qué tipo de intervención es elegida para cada conflicto-disfunción y para cada sistema.
- 4) Fundamentación de por qué se elige ésa y no otra en ese momento, dentro de las alternativas con las que contamos.
- 5) Evaluación de la reacción o respuesta a la intervención realizada, calibración de la misma de acuerdo al momento de la familia y su cotejo con la conversación de la dupla que decidió tal intervención.
- 6) Evaluación de los cambios producidos y cómo los medimos.

Hemos consultado bibliografía general de investigación en ciencias sociales y más específicamente en terapia familiar*.

De nuestra investigación, comenzada durante 1981 en CEFYP, continuada actualmente fuera de dicha institución, esto constituye solamente un informe preliminar. Tenemos en la mano, algunas conclusiones provisionales que nos sirven para:

- Corregir errores.
- Aclarar mejor las preguntas que nos formulamos y que nos formulen, y a las que deseamos encontrar respuestas.

* Agradecemos la colaboración de la Sra. Elizabeth Jelin, Doctora en Sociología, asesora en el desarrollo y metodología de la investigación.

MODELO DE TRABAJO

Dentro del modelo de trabajo que utilizamos, incluimos la Cámara de Gesell y la confrontación del equipo terapéutico en dupla, es decir, dos terapeutas, uno que trabaja en el campo, dentro de la cámara y el otro detrás del vidrio. El terapeuta de la familia sale cuando lo cree conveniente o el supervisor toca el timbre interno para que salga, se conversa acerca del camino a seguir en el abordaje terapéutico y se discuten las distintas posibilidades de intervención.

La dupla terapéutica tiene algunas ventajas que pasamos a considerar:

1) Permite una lectura más ajustada de la situación familiar, ya que se opera simultáneamente en dos niveles. El terapeuta dentro de la interacción con la familia y formando con ella un sistema terapéutico, donde al acoplarse a la familia, acompaña a éste, jugando sus propias reglas e interviniendo desde allí.

La lectura del supervisor se coloca en un nivel "supra", mirando a la familia, y al terapeuta hacer su juego interaccional y al resguardo de las trampas de la familia, más libre para pensar estratégicamente. Al observar desde un nivel superior se contempla mejor la complejidad de interacciones de los miembros de un sistema, y habría más posibilidades de predecir la dirección de los hechos. Así, pensemos en dos vehículos que chocan accidentalmente. Cada uno de los conductores, controlando las variables que tienen a su alcance perceptivo, no pueden predecir que eso va a ocurrir. En cambio, un observador instalado en un helicóptero desde donde, aumentada la distancia, la mira se ha ampliado considerablemente, puede predecir mediante una evaluación del curso y la velocidad que llevan los vehículos, que éstos van a chocar.

Esto constituye un cambio de plano, que produce un aumento cualitativo en las dimensiones. Es incluir una tercera dimensión e incluso una cuarta, el tiempo, en las secuencias de los sucesos.

2) Brinda la posibilidad única de poder ajustar las estrategias adecuadas mediante conversaciones, mientras se va desarro-

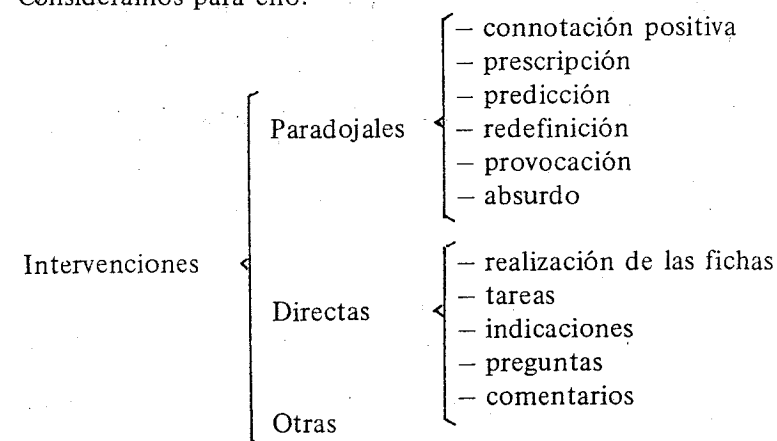
llando la entrevista. Además, este punto es de interés ya que es en el trabajo en dupla donde se arma y discute la alternativa terapéutica elegida y es en este espacio donde pueden surgir las distintas posibilidades de intervención.

Reconocemos que el trabajo en dupla implica un nivel importante de compromiso, en términos de acuerdos formales, y básicamente desde una relación de confianza mutua indispensable.

Tomando en cuenta el tema de la investigación, la presencia de la dupla en todas las entrevistas constituye una constante que no se puede modificar a riesgo de alterar los resultados.

Pongamos un ejemplo: una veta interesante de estrategia es estimular y frenar el cambio en marchas y contramarchas, separando las tendencias antagónicas del sistema y colocándolas en cada uno de los terapeutas. Decirle a la pareja que sería preferible para ellos no cambiar, ya que eso les traería peligros y riesgos como perder la unión, pero que el otro terapeuta (detrás de la Cámara) opina lo contrario, que sería bueno y útil para ellos y que podrían tolerar lo nuevo.

Incluimos para favorecer la comprensión del proceso, una breve descripción del arsenal terapéutico con que contamos, que son los distintos tipos de intervención alrededor de los cuales vamos a realizar el diseño y la discusión de alternativas. Consideramos para ello:



INTERVENCIONES TERAPEUTICAS ALTERNATIVAS

Entendemos que las intervenciones anteriormente expuestas, no son todas las posibilidades existentes, pero sí son algunos de los recursos que creemos viables dentro de un abordaje sistémico. Es necesario enfatizar, además, que no se pueden utilizar nunca en forma pura, sino que se usan de manera combinada, tanto en el transcurso de una sesión, como a lo largo del proceso terapéutico.

Así podemos dar una tarea, previa connotación positiva de la regla disfuncional, haciendo una alianza dual con la permanencia y con el cambio. O, por ejemplo, incluir una prescripción de la pauta interaccional, y al mismo tiempo, usar la provocación en forma individual.

Por ejemplo a Antonio:

“Usted tiene que seguir siendo un buen hijo luchador, un buen marido luchador, pero ¡ojo con cansarse! , sobre todo en esta época que su vida va a cambiar por la jubilación, y usted necesita mantenerse joven y fuerte, como si no hubiera llegado a los 60”.

Aquí recortamos arbitrariamente una posibilidad; a Magdalena:

“Continúe con su problema para que él siga luchando, aunque usted pierda tanto de la vida. Otra mujer a los 40 años podría elegir vivir a fondo, disfrutar en comer, en hacer cosas o en relaciones sexuales... a lo mejor usted ya ha hecho una elección definitiva y eso no es para usted”.

Utilizamos fichas clínicas, que deben ser llenadas individualmente por cada uno de los miembros. Son entregadas en la primer entrevista y devueltas por los pacientes días antes de la segunda entrevista. El uso de las fichas clínicas cumple algunos objetivos que son:

1) tiene el valor de una primera tarea, donde el terapeuta puede medir la permeabilidad del sistema frente a las intervenciones directivas: si las realizan, si aceptan la indicación de no consultarse, si las traen a tiempo, si están completas, etcétera. Estos son algunos indicadores válidos para elaborar el próximo paso terapéutico.

ESTRELLA JOSELEVICH - MARIA ESTER PANIZO

- 2) Aporta material para determinar con más exactitud:
- a) motivo y momento de la consulta
 - b) momento de aparición del síntoma y circunstancias vitales alrededor de él.
 - c) información sobre crisis anteriores y alguna idea de cómo las han resuelto.
 - d) datos históricos de vínculos en las familias de origen, donde se construye el modelo interaccional.

El terapeuta puede utilizar las fichas en la sesión misma, y/o elaborar la intervención con el supervisor, en base a la discusión de los datos.

Dividimos cada encuentro con la familia en tres momentos: pre-entrevista, entrevista y post-entrevista.

En las pre-entrevistas se evalúan las hipótesis acerca de la situación familiar y el/los síntomas y las reglas alrededor de las cuales se ha equilibrado disfuncionalmente el sistema. Estas hipótesis se confirman luego o no, pero el hecho de poder manejarlas, hace que se organice mejor el campo terapéutico, disminuyendo los riesgos de que el terapeuta sea arrastrado por la corriente de la familia.

Con respecto al desarrollo de la entrevista, ya hemos explicado cómo funciona.

La post-entrevista constituye un espacio donde se puede realizar una evaluación de las respuestas inmediatas del sistema, y a partir de ello, delinear el próximo sendero a transitar.

NOTAS SOBRE EL CASO

Se trata de una pareja derivada por la terapeuta individual de la señora, perteneciente a una obra social en la que está incluida también la institución.

El llamado telefónico lo realizó Antonio, capataz, de 60 años, para solicitar una hora: “... por problemas de uso sexual de mi esposa”. María Magdalena tiene 40 años y es ama de casa.

Antonio es viudo de su primer matrimonio, con hijos

INTERVENCIONES TERAPEUTICAS ALTERNATIVAS

casados y nietos. Junto a María Magdalena tienen dos hijos: Adrián de 14 años y Silvina de 11.

El motivo de consulta es la ausencia de relaciones sexuales por negativa de ella. El comienzo del problema data de varios años (para él dos y para ella diez). En el último año acuerdan que han suspendido casi totalmente las relaciones sexuales.

Detectamos una creciente depresión en ella, desgano, quedarse en cama, abandono de algunas tareas domésticas y falta de apetito, síntomas que en realidad nos preocuparon más a nosotros que a ellos mismos.

Durante la primera entrevista ya observamos que ellos muestran una relación donde prima el afecto y el cuidado mutuo. De aspecto prolijo, bien vestidos, ella aparenta ser unos pocos años mayor que sus 40, y él algo menos que sus 60.

Iremos viendo otros aspectos del caso a medida que ejemplifiquemos con secuencias de entrevistas y con diálogos de la dupla terapéutica.

Recortes tomados de sesiones:

El motivo de consulta.

El: "El asunto del uso sexual en esta época es total de parte de ella de no tener ningún interés, ninguna satisfacción. El rechazo es total. Yo sí quiero, siempre la busco, la toco..."

Ella: "El problema es sexual, ¿vivo?, que tenemos. El problema está hace por lo menos 10 años. hace tres años se puso mucho peor. Me siento así, con ese problema sexual, no tenía ganas de estar con él. Desde hace 1 ó 2 años el problema se puso más fuerte, no tengo nunca deseo..."

Para Antonio, el problema se inicia hace 2 años. Antes, él no había podido registrar la insatisfacción de María Magdalena como un problema.

Pauta interaccional redundante observada.

Isomorfismo de la regla esencial en área sexual y comida:

El: "Yo cocino, yo lavo, yo seco, ayudo con todo...",
"... le insisto, comé, comé..."

ESTRELLA JOSELEVICH - MARIA ESTER PANIZO

Ella: "A él le gustó meterse siempre en la cocina (risas). A mí me gusta, más que en el último tiempo, yo no quiero cocinar... no quiero cocinar tampoco... Lo que pasa, ¿vivo?, que yo no tengo ganas de comer, entonces me parece que nadie tiene ganas de comer. Es en estos últimos tiempos, antes no era así..."

El activo, realiza, insiste, y ella pasiva, se retrae.

Ella no quiere - el sí quiere. Observamos acá una pauta interaccional redundante.

Tarea (recortada de una intervención más amplia).

Probamos en este momento con una intervención directa, que tiende a que ellos cambien mínimamente la pauta redundante en términos de mayor actividad de ella ("decidir"). El terapeuta ratifica la importancia que le dan a la unión y al cuidado mutuo, y la solidez de la pareja construida en base a esos valores.

Ter.: "Esta semana, por favor, una semana a partir de hoy, de jueves a jueves, le voy a pedir a Ud., Magdalena, que *decida* el menú del día, lo que a Ud. le parezca mejor, se lo comunica después a Antonio. Ud. decide y después le comunica a él qué se hace, quién lo hace, cómo se hace. Los dos después, por favor, van a observar bien clarito, qué pasa después..."

Posteriormente se continuó con tareas en esta área, alimentación.

Evaluamos posibilidades al término de la primera entrevista:

Aparece la posibilidad de hacer una connotación positiva más directa sobre la regla de lo sexual o en la relación, del tipo: "Ud. siga, Magdalena, retirándose, no comiendo, no cocinando, aislándose, porque esa es una forma en que Antonio va a estar más cerca suyo. Y Ud., Antonio, siga así, haciendo eso de estar encima de ella cuidándola y cuidándola, porque esto le permite estar cerca, luchando por la pareja..."

Elegimos acá trabajar la regla de interacción sin mencionar el síntoma específico. No tomamos el problema sexual.

Otra alternativa es trabajar sobre el síntoma donde comenzaríamos por lo que ellos nos ofrecen en bandeja, lo que traen: el rechazo a las relaciones y la frigidez y así, al mismo tiempo de prescribir el síntoma, podríamos prescribir la pauta de interacción en la que él está inserto: "Que bueno que Ud. se retiró, Magdalena, si eso es motivo de que Antonio luche por Ud. ya que es un luchador que se siente así vital y joven...", "... siga, por favor, haciéndose desear, así él sigue luchando...".

Podríamos agregar a esta connotación positiva y prescripción de la pauta disfuncional, una predicción de la redundancia de la misma: "... es probable que Ud, Magdalena, se retire cada vez más, para que Ud. Antonio, pueda luchar cada vez más...".

Otra posibilidad es buscar una situación histórica, de donde este modelo de interacción sea una repetición.

No consideramos esta línea adecuada en este caso, por el momento del proceso terapéutico (estamos en la primer entrevista) y por la reticencia de ellos a entrar en el tema, por lo que decidimos esperar.

Agregamos en la post-entrevista una posibilidad: recabar información sobre el momento de aparición del síntoma, incluyendo las circunstancias vitales en que aparece.

Profundizamos en el modelo histórico interaccional.

El: "... soy el mayor, yo tenía 11 años, salía a rebuscármelas afuera vendiendo verduras, y a la tarde salía con el cajón a lustrar zapatos, para traerle las monedas a mi mamá (época en que el padrastro, ya que Antonio no conoció a su propio padre, estuvo enfermo durante un año); yo luché mucho en mi vida, trabajé siempre en dos trabajos...".

Ter.: "Ud., Magdalena, cuando lo rechaza, hace que también siga siendo un luchador, pero sí, pero vamos, adelante..., así sigue siendo un luchador, un gran trabajador...".

El: "... sí, porque yo la busco y la busco...".

Ter.: "... Pero entonces, Ud. un poquito le tiene que

agradecer a ella; ella lo ayuda para que Ud. siga siendo un luchador. Ud. (a ella), siempre se ha sacrificado por los otros tratando de hacerles el gusto, comenzando de chica con sus abuelos y toda la vida con Antonio...".

La terapeuta incluye un dato histórico: Magdalena, hija de madre soltera, fue criada por los abuelos a quienes quería satisfacer permanentemente.

Para ambos, cuidado - cariño fueron valores importantes en su crianza. En la medida que dar les aseguraba la permanencia del vínculo.

Anticipamos los peligros de cambio:

Ter.: "Les pregunto, no para que me contesten ahora, sino para que lo piensen, qué pasaría si Magdalena no tiene más el problema de "uso sexual" (el terapeuta usa las palabras de ellos), ¿no será difícil que todo, todo esté bien?, ¿no será peligroso en algún sentido para la pareja?"

Ante los primeros indicios de cambio, la estrategia consiste en tratar de frenarlo. Esta es sólo una de las maneras de hacerlo.

Otras tareas que incluyen la anticipación del peligro de cambio.

Ter.: "... para el día en la semana que Ud. Antonio, pone para tener uso sexual, Ud. Magdalena, decida cómo va a ser ese día la relación. A lo mejor, Ud. quiere hacerle el gusto, el máximo de gusto a él, o mirando TV o con dos almohadones (un problema de la relación era que a él le gustaba realizar el acto sexual con una almohada bajo la espalda de su esposa y a ella le desagradaba), o como sea..."; "... Quiero pedirle a Ud., Antonio, que para que no se nos escape nada, nada, anote todo lo que pasa y, por esta única vez, me lo traiga, pero no se lo da a leer a ella antes... (esto se hizo tomando en cuenta que él siempre anota todo lo referente a días de relación sexual y días en que su señora tiene el período menstrual)...".

Ya que con la comida la tarea resultó útil, y observamos

INTERVENCIONES TERAPEUTICAS ALTERNATIVAS

que de esta manera el sistema comenzó a “moverse”, y no deseábamos estratégicamente enfatizar los cambios, volvemos al síntoma, motivo de consulta. Esto serviría, además, para fortalecer la alianza terapéutica con Antonio, preocupado por las relaciones sexuales y reticente a hablar de sentimientos y pensamientos. Nos estamos refiriendo a la segunda y tercer entrevistas.

Matiz de insatisfacción:

El: “... ella muchas veces quiere comer algo que no hay en casa o que no preparó...”.

Ella: “... sí, no me lo preparó...”.

Ter.: “Ud. prefiere quedarse con las ganas...”.

Ella: “... yo terminaba de comer la comida y tenía ganas de comer *algo*, aunque comía mucho, y siempre estaba buscando algo más, algo diferente, iba a la heladera y buscaba una cucharadita de dulce o de miel...”.

Ella: “... no pasa nada, terminamos eso (relación sexual) y ahí quedó todo...”.

El: “... ella se queda, es un sacrificio para ella, cuando yo la invito, se pone ahí y ahí nomás quedó...”.

En las próximas entrevistas, observamos que comienzan a tener relaciones sexuales una vez por semana y con cambios de conducta de ella (“... me acaricia y me abraza” dice él).

La línea terapéutica elegida en este punto del proceso es frenar el cambio, y volver al área comida. La intención es que el cambio no quede “sancionado” como tal. El cambio sería para la pareja un “error” o desviación del sistema a corregir mediante un movimiento de feed-back negativo. Se le saca la significación de cambio deseable o permanente, para evitar ese movimiento de “corrección” y vuelta atrás del sistema.

De esta manera impulsamos contraparaódojalmente ese cambio. Así, viendo la permeabilidad del sistema (ella comenzó a

ESTRELLA JOSELEVICH - MARIA ESTER PANIZO

levantarse y comer) y para cambiar el matiz insatisfactorio de las relaciones, es que diseñamos esta intervención directa:

Ter: “... tres veces por semana le lleva a Magdalena algo que piensa que le puede gustar, algo pequeño, de comer, que le puede gustar muy especialmente; me parece que va por el lado de lo dulce...”.

“... a Ud., Magdalena, una sola vez le hace a él algo de comer que puede ser el bizcochuelo de la TV que a él le gusta..., de sorpresa; se lo presenta sin avisarle antes, Ud. elige lo que puede hacer. Otra cosa, que cuando Ud. piense “no, esto no quiero comer, en cambio quiero fideos” y ¡ojo! que esto es muy difícil, que Ud. vaya a la cocina y comience a prepararse eso que quiere comer, que ponga el agua y la sal, saque los fideos del armario, pero que no los cocine. Una sola vez tiene que hacer esto. Comienza todo y deja...”. ¿Cree que lo puede hacer? Antonio, por favor, Ud. anota todo y me trae el papel porque es importante...”.

El terapeuta insiste, reconociendo a los pacientes que les está pidiendo cosas difíciles y que además son varios pedidos. Busca que no usen estos argumentos para evitar cumplir con las tareas.

Mediante indicaciones desafía indirectamente a los miembros de la pareja.

Estas intervenciones, junto con el freno al cambio, y la rotulación del valor de la unión para ellos, son para continuar “encerrando” y resquebrajando al sistema. Queremos aumentar el poder de decisión, por el lado de lo activo (ya comenzado antes) más que siempre por el no, como rebeldía pasiva desde ella.

Es necesario enfatizar que a esta altura Magdalena no se encuentra deprimida, ha salido de la cama y de la abulia en que se encontraba. Han comenzado a mantener relaciones sexuales de una forma más satisfactoria.

Comentarios finales

¿Qué conclusiones hemos podido obtener? Por ahora sólo

INTERVENCIONES TERAPEUTICAS ALTERNATIVAS

guías para continuar con nuestro trabajo. Por eso con éstas quedan para nosotros, formuladas en términos de preguntas de otros procesos.

Es posible en este caso, afirmar que el trabajar en áreas isomórficas resulta clínicamente válido. Nosotros encaramos el trabajo alrededor del síntoma no-comer y depresión, inserto para nuestra observación en la misma pauta de relación que el problema que motivó la consulta, que es la falta de relaciones sexuales y la frigidez. Ellos se mostraron más reticentes aquí, mientras que con la comida, que no les preocupaba como problema, todo era más fluido. Tocamos la misma regla de interrelación que de alguna manera abarcaba ambos niveles. Cuanto más central a la organización del sistema es la relación o aspecto relacional que “tocamos”, mayor será la desestructuración y reestructuración del sistema, entendiendo que la regla más esencial y central de la organización es aquella de mayor redundancia en las áreas de funcionamiento familiar.

Si hacemos una evaluación del tipo de intervenciones usadas, a lo largo del proceso, podemos concluir que la línea general fue:

- *Una alianza explícita con el no-cambio*, donde el significado que toda conducta adquiere desde este contexto es no-cambio. Esta alianza se realizó mediante: prescripciones, indicaciones precisas de que no cambien, alertas anticipatorios de peligros posibles de cambio, disminución o minimización del valor de algunos cambios aparecidos, dudas acerca de la permanencia de las conductas nuevas al sistema, frenos a las conductas de cambio esbozadas.
- *Señalamiento y connotación positiva constante de la unión y afecto de la pareja.*
- *Tareas directivas que tienden a impulsar a los miembros del sistema a conductas diferentes*, por la vía de indicaciones que tienden a modificar la regla disfuncional, en una alianza con la morfogénesis, sin abandonar las anteriores.
- *Trabajo dirigido hacia una comunicación más clara y una mayor apertura afectiva entre ellos.*

ESTRELLA JOSELEVICH - MARIA ESTER PANIZO

Podemos evaluar que esta línea fue útil en este caso y de valor terapéutico; nos preguntamos: ¿es válido para otras sintomatologías? ¿Es válido para otras características familiares? ¿O lo es para niveles socio-económicos diferentes? ... Esperamos responder a esto en el futuro.

Si analizamos la evolución del tipo de intervenciones y el por qué deseamos algunas alternativas y elegimos otras en diferentes momentos, concluimos que:

- Hemos usado en el comienzo del proceso terapéutico, tareas concretas y específicas para realizar en casa, con el objeto de evaluar la permeabilidad y flexibilidad del sistema a los cambios. Por otro lado, era acorde al pedido de esta pareja que iba concretamente dirigido a pedir indicaciones según el modelo médico tradicional con que ellos se manejan, utilizándose así este ingrediente en favor del cambio.
- En un segundo momento del proceso, se decide suspender las tareas con el objetivo de promover la autonomía de la familia respecto del terapeuta.
- En la última etapa del proceso comenzamos a trabajar en una regla de nivel “meta”: la relación debe estar establecida en la *diferencia-complementariedad*. Entendiendo por meta-regla, la regla acerca de cómo deben armarse los juegos interaccionales, y en función de qué ítem básico o parámetro. Las diferencias entre ellos, rígidas y cristalizadas, les daban forma a casi todas sus interrelaciones. El ser diferentes ratificaba y consolidaba permanentemente la identidad de este sistema. Observamos así que el contrato de esta pareja se consolidó en la situación en que él la “saca de un apuro” y así se casan. Ella estaba en dificultades, él la ayuda para solucionar el problema y luego se casan. El la necesitaba porque estaba solo y sin nadie a quien ayudar, y ella porque necesitaba quien la ayude.

Surgen así a lo largo de su historia relacional, situaciones cimentadas en la complementariedad: la edad, uno enfermo y otro que cuida, uno que piensa y otro que no lo hace.

Observamos reiteradamente esta característica en las dife-

INTERVENCIONES TERAPEUTICAS ALTERNATIVAS

rentes áreas trabajadas: sexo, alimentación, manejo de los hijos, económica, social.

En este sentido, elegimos una línea orientada a la anticipación del futuro del sistema: envejecimiento-jubilación de él, fortalecimiento-madurez de ella. Habría una inversión de la regla provocada por el momento evolutivo de cada uno. La regla mantiene su articulación dentro de la meta-regla anterior. Y sobre esto trabajamos nosotros. Nuestra primera hipótesis (antes de la primera entrevista) estaba relacionada con la función del síntoma en relación a la diferencia de edad, pensando que ella con su síntoma, probablemente lograba perpetuar artificialmente la juventud y potencia de él.

Nos parece un punto interesante para desarrollar y comparar con tapes de otros procesos, el uso de diferentes líneas de intervención en diferentes momentos.

Insistimos: estamos tratando de mostrar el proceso del diseño de alternativas de la estrategia terapéutica, no el desarrollo y fin del caso clínico. Es por esto que la evolución del tratamiento de esta pareja está ejemplificado sólo parcialmente.

Temas que nos surgen para analizar en otros casos son: ¿La evolución de la sintomatología es siempre paralela a la modificación de la pauta disfuncional de la cual forma parte? ¿Cambia tanto y al mismo tiempo uno y lo otro? ¿Habría una autonomía secundaria de los síntomas (Hartmann, K. y L.) en algún caso, ya que para nosotros esto sería altamente improbable?

En este caso consideramos útil la línea de cuidar la unión de la pareja porque para ellos era un valor importante, ya que el riesgo que se presentaba era la ruptura, por la diferencia de edad, por el momento del ciclo vital de cada uno, que podía, al hacerse patente, constituir un motivo de ruptura:

Jubilación	vs	madurez
depresión	vs	vitalidad
declinación sexual	vs	madurez sexual de la edad media

¿Y si hubiera ocurrido una ruptura-separación de la pareja,

ESTRELLA JOSELEVICH - MARIA ESTER PANIZO

constituiría esto un cambio de segundo orden? ¿O, es posible un cambio de segundo orden en esta pareja, sin una ruptura?

Observamos además que cuando se pasó de la intervención en la regla a la intervención en la metarregla de la diferencia, se abandonó paralelamente la línea de las tareas y se intervino sobre esta metarregla con la anticipación, prescripción, etcétera, de esta característica.

Nos preguntamos si es válido al llegar al centro-identidad del sistema, anticipar las consecuencias y la dirección de los cambios.

Una tendencia terapéutica en este caso fue la de calibrar las intervenciones en función de los feed-backs del sistema frente a ellas, pero usándolas "a fondo", antes de abandonarlas y pasar a otras, porque de lo contrario no conoceríamos el grado de utilidad de las mismas. Así, cotejamos y esperamos los movimientos del sistema, para saber como seguir. No nos embarcamos en una línea definida a ultranza en ningún caso, por el contrario, dejamos abierta la posibilidad de viraje en la dirección terapéutica.

Mantenemos constante la fuente de datos para el estudio de la situación a nivel diagnóstico y para la evaluación de los resultados. De esta manera pudimos observar un mejoramiento en las relaciones sexuales, mayor frecuencia y satisfacción, una salida de la depresión, mejoramiento en el área alimentación, etcétera, problemas insertos en las reglas anteriormente mencionadas, que cambiaron. Hubo una flexibilización alrededor de la meta-regla de las diferencias que sustenta la relación, menos temor a una relación algo más pareja con posibilidad de verse "distintos". No hubo acá un cambio total sino, insistimos, flexibilización.

Podemos ratificar a esta altura de nuestro trabajo la riqueza y el valor operativo del trabajo en dupla terapéutica, y hemos experimentado el pasaje por un proceso de elaboración de reglas propias de la dupla, considerando que "nuestra" comida, la intervención, la preparábamos juntas, con ingredientes de ambas partes y la horneaba la terapeuta en la cocina del setting terapéutico.

INTERVENCIONES TERAPEUTICAS ALTERNATIVAS

Consideramos por último de valor especial el tipo de joining terapéutico entablado en esta familia por el T. a partir de:

- adecuación al estilo de comunicación de esta familia.
- calibración de las intervenciones según el nivel de tensión-relajación del sistema en cada momento.
- aumento leve y progresivo del grado de “libertad” del movimiento de la terapeuta, observable en algún pequeño chiste y cierto humor social en el juego terapéutico.

En estos comentarios finales hemos dejado delineadas las variables a comparar con los otros procesos terapéuticos. Nos han dejado asentado el camino que queremos transitar y significan recién el comienzo.

Resumen

El anterior trabajo, es el resultado de la culminación de un primer eslabón dentro de un proyecto prolongado de investigación con familias. Se desarrollan en él los objetivos de la misma, que giran alrededor del estudio de las estrategias terapéuticas y las diferentes alternativas con que cuenta el terapeuta, tratando de evaluar las características de implementación de las mismas, así como las modalidades y el momento de su utilización.

Se comienza planteando el sustrato teórico del proceso de investigación, se desarrolla luego el modelo de trabajo clínico en dupla terapéutica, y sus características particulares (frecuencia, etcétera). Se muestran algunos recortes del proceso terapéutico del primer caso clínico estudiado, que incluyen sesiones con la familia y discusiones de la dupla terapéutica, para mostrar algunas intervenciones y sus posteriores resultados. Se hace una breve reseña de las estrategias terapéuticas posibles de ser usadas y por último se incluyen comentarios finales y preguntas que sirven para el desarrollo de la investigación en el futuro y para la implementación y evaluación de la efectividad de las intervenciones terapéuticas.

Summary

This study is the result of a first stage in a long term project of research on families.

ESTRELLA JOSELEVICH - MARIA ESTER PANIZO

The objectives of this research are developed: the study of therapeutic strategies, different alternatives available and interventions in the family. An evaluation is made of the characteristics of their implementations as well as of the manner and moment of using them.

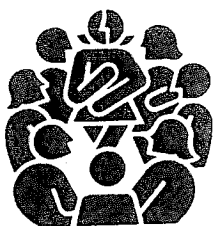
We begin by describing the theoretical basis sustaining our project. Then we develop the clinical work model and explain our system of working in therapeutic pairs, talk about the frequency, etc.

Some aspects of the clinical case are included (the case has been video-taped and then studied) as well as extracts of the sessions with the family and team discussions on therapeutic alternatives and evaluation of results.

We include a brief summary of the therapeutic strategies available to us and finally we add conclusions and questions about the future development of this research.

Bibliografía

- BATESON, G.: *Pasos hacia una ecología de la mente*, Ed. Carlos Lohle. *Espíritu y Naturaleza*, Amorrortu Editores.
- GURMAN, A. y KNISKERN, D.: “Family Therapy Outcome Research: Knowns and Unknowns”, en: GURMAN, A. y KNISKERN, D.: *Handbook of Family Therapy*, Bruner y Mazel, ed.
- HALEY, J.: *Terapia para resolver problemas*, Amorrortu Editores.
- HOFFMAN, L.: *Foundations of Family Therapy*, Basic Books.
- MINUCHIN, S.: *Families and Family Therapy*, Harvard University Press.
- PINSOF, W.: “Family Therapy Process Research”, en: GURMAN y KNISKERN: *Handbook of Family Therapy*, Bruner y Mazel, ed.
- PRATA, G. y SELVINI PALAZZOLI, M.: *Paradoja y contraparadoja*, Ed. A.C.E.
- WEAKLAND, J.: “Communication Theory and Clinical Change”, en: GUERIN, Ph.: *Family Therapy*, Gardner Press Inc.



**III CONGRESO ARGENTINO
Y I PANAMERICANO
DE TERAPIA FAMILIAR**

25 al 27 de agosto de 1985
Centro Cultural General San Martín
Buenos Aires - Argentina

Organizado por la
SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA FAMILIAR

RELATORES DEL EXTRANJERO

Dr. Harry Aponte Dr. Carlos Sluzki

TEMARIO

Violencia en la Familia
Modelos Intermedios en Terapia Familiar
Problemas Técnicos en Terapia Familiar
Familia y Empresa Familiar
Familia y Comunidad
Familia y Medicina Familiar
Familia y Drogadicción
Nuevas Organizaciones Familiares

Informes e Inscripción

Ana Juan Congresos
Sarmiento 1562 - 4° "E" y "F"
T.E. 35-4437/6703
1042 - Buenos Aires

C I S A M

Centro de Investigaciones para la Salud Mental

HOSPITAL DE DIA: NIÑOS Y ADOLESCENTES

- * Jornada completa y media jornada.
- * Enfoque terapéutico basado en la terapia familiar y el trabajo en sala que abarca: Acompañamiento terapéutico, Musicoterapia, Psicopedagogía, Foniatría y Psicomotricidad.

Armenia 1788 (ex Acevedo)

T.E. 71-3386

Secretaría: Horario 9 a 13 hs.

**1985 -- Programas de Entrenamiento del
Instituto de Terapia Familiar**

Directora: Lic. Nidia Madanes

**ENSEÑANZA CON SUPERVISION EN VIVO
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO**

Programa I: Una vez por semana de Agosto a Noviembre 1985.
Horario, Lunes 19 a 21 hs. Viernes 12 a 14 hs.

Programa II: Una vez por semana de Agosto a Noviembre 1985.
Horarios, Miércoles de 9 a 12 hs.

Programa III: Una vez por semana de Agosto a Noviembre 1985.
Horarios, Viernes 17 a 21 hs.

El grupo de alumnos se turna para entrevistar parejas y familias, mientras la Lic. Nidia Madanes realiza el trabajo de supervisión.

La enseñanza incluye seminarios teóricos a través de la permanente mostración de video-tapes de casos trabajados en Buenos Aires y en Washington en el Instituto de Terapia Familiar dirigido por Jay Hayley.

Para cualquier información adicional, dirigirse al Instituto de Terapia Familiar. Quesada 2568 (1429) - Teléfonos 701-6887 / 6888 / 6895, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 18 horas.

Complejidad interaccional y comunicación¹

CARLO RICCI* - MARA SELVINI-PALAZZOLI**

** Instituto de Psicología de la Universidad Católica, Largo Gemelli 1, Milán 20123, Italia. - ** Directora del Nuevo Centro para el Estudio de la Familia, Viale V. Veneto 12, Milán, Italia.*

Este artículo llama la atención sobre una simplificación que creemos ha sido hecha frecuentemente en el análisis de la comunicación interpersonal.

Esto sucede cuando uno usa los modelos de comunicación interpersonal que no encajan con la complejidad interaccional del sistema observado.

El propósito de este artículo es presentar algunos parámetros conceptuales (Territorialidad, Temporalidad, Dualidad) de un modelo N-ádico de comunicación, en el esfuerzo para encajar con la complejidad interaccional de los juegos de N-personas.

En otras palabras, si nosotros aceptamos el así llamado "modelo sistémico", nosotros necesitamos modelos comunicacionales que nos permitan observar distintos niveles de complejidad interaccional.

¹ Publicado en *Family Process*, Vol. 23, Nro. 2, 1984. Reproducido con autorización del editor y del autor. Traducido por Elena K. de Lebensohn.

CARLO RICCI - MARA SELVINI-PALAZZOLI

El observador (terapeuta) puede decidir en cuál nivel eligirá su instancia en referencia a un caso particular que tenga y las metas que se perseguirán en su estudio.

Más allá de la diada

La complejidad interaccional de un sistema está basada en por lo menos tres factores interconectados: a) el número de las partes, componentes o jugadores; b) la naturaleza de la interdependencia de las partes y c) el grado en que lo incierto afecta la conducta del sistema.

El problema de la complejidad interaccional no ha recibido suficiente atención aún por aquellos que proclaman haber adoptado el así llamado "modelo sistémico".

Aunque algunas manifestaciones teóricas concernientes al modelo sistémico son sólo jarabe de pico en relación a la importancia de visualizar el sistema tal como es, una totalidad, compleja.

Es así como muy pocos instrumentos se han desarrollado para analizar los procesos interaccionales complejos dentro de los sistemas.

Aún el primer factor, el número de jugadores, tan obvio para un punto de vista intuitivo, ha sido muchas veces subvalorado.

De hecho releando la literatura aparece rápidamente que el modelo más frecuentemente usado es el diádico. Pero en cualquier sistema la simple adición de un componente (en nuestro caso de un jugador) introduce un incremento de complejidad que no es simplemente aritmético, sino geométrico, por lo tanto se hace necesario estudiar las relaciones de relaciones.

De esta manera aún la simple transición del análisis de la diada ($N = 2$) a la triada ($N = 3$) puede ser considerado un salto cualitativo requiriendo diferentes métodos de observación y análisis.

Por ejemplo sería una peligrosa simplificación aplicar el paradigma diádico de emisor-receptor para analizar la comunicación de una pareja.

De hecho haciéndolo así, nosotros obtendremos una descripción aislada del intercambio de mensajes de la pareja.

Esto no significa que la diada en sí misma no exista. Podemos trabajar en este nivel acorde con nuestro propósito y situación pero siempre luego de una apropiada exploración de un nivel superior de complejidad. En este sentido uno de los problemas inherentes de adoptar el modelo diádico, es que éste no toma en consideración muchas variables importantes que pueden afectar el proceso de comunicación.

Por ejemplo este modelo excluye la totalidad del "Sistema extendido de comunicación" (S.E.C.), todas las otras personas o grupos que estando envueltos en la relación de la diada, concomitantemente, la influyen.

Por esta razón si nosotros expandimos nuestra observación al N-ádico sistema de comunicación, usando el modelo diádico corremos el gran riesgo de parcializar el sistema.

El sistema total de comunicación puede ser visto como la simple suma de diadas perdiendo de esta manera lo que nosotros llamamos "La complejidad interaccional del N-juego de personas".

El análisis de la comunicación interpersonal no debe estar basado en la diada sino en el N-ádico. El nivel del análisis de la complejidad interaccional no puede ser adecuadamente extendido a meros factores o jugadores que se suman en un modelo basado diádicamente.

Indudablemente muchos autores y lectores están alertados de las limitaciones conectadas con el uso de un modelo diádico. El modelo mismo genera una comprensión equivocada de la extrema complejidad de cualquier proceso de comunicación. Más aún la premisa cartesiana "lo más complejo puede ser explicado en términos de lo más simple" puede conducirnos a un serio error pragmático y conceptual.

El modelo sistémico demanda una premisa opuesta: "Es lo más complejo que explica lo más simple". En otras palabras una comunicación diádica es parte inevitable de un más amplio "Sistema Extendido de Comunicación" (S.E.C.), incluyendo un número indefinido de participantes. Cualquier comunicación

puede ser adecuadamente analizada sólo cuando el grado de complejidad generada por el S.E.C. se transforma en una parte integral del análisis. Por ejemplo dado un cierto "juego de tres personas" ($N = 3$) la comunicación de los tres participantes no puede ser explicada usando un modelo comunicacional que está basado en la diada $N = 2$ porque éste es más bajo en complejidad de la de aquél del juego que cursa.

De hecho, en el más alto grado de complejidad ($N = 3$) un nuevo perfil cualitativo aparece posible. Por ejemplo la posibilidad de formar coaliciones "dos contra uno", esto no puede tener lugar en el juego de dos.

Obviamente nuestro primer y más saliente problema es acertar la exacta dimensión del N-juego de personas.

Haciéndolo así los límites del S.E.C. se definirían. Claramente, es muy difícil y a veces imposible tener éxito en definir dichos límites, pero no obstante para ir más allá del análisis diádico de la interacción, deben ser desarrollados modelos N-ádicos de la misma.

El Modelo

Como punto de partida vamos a considerar el modelo de la comunicación sugerido por Watzlawick, Beavin y Jackson en "Teoría de la Comunicación Humana".

Desde este modelo nosotros sabemos que "uno no puede no comunicar" (axioma 1) y que cualquier comunicación interpersonal implica un compromiso.

Muy a menudo el receptor es visto como la persona que parece ser el que recibe la comunicación del emisor.

Pero focalizando, por ejemplo, en los dos que aparecen siendo los principales comunicantes (la aparente fuente-receptor) el riesgo es deslizarse dentro de un análisis diádico.

Desde el momento que una diada puede ser estudiada dentro de un N-ádico sistema de comunicación, cada comunicación, aún a un solo receptor (el aparente) inevitablemente compromete al emisor del juego de N-personas que está en curso.

COMPLEJIDAD INTERACCIONAL Y COMUNICACION

Por lo tanto, el juego en sí mismo, y no los varios jugadores, debe ser considerado el "real" receptor de la comunicación del emisor. En términos de transmitir y recibir información el esquema clásico de Haley:

1- Yo (emisor), 2- estoy diciendo algo (mensaje), 3- A Ud. (receptor), 4- en esta situación (contexto), puede ser modificado como sigue:

1- Yo (emisor), 2- estoy diciendo algo (mensaje), 3- A Ud. (aparente receptor) inevitablemente y concomitantemente. 4- A él/a ellos, 5- en esta situación (contexto); acorde con el anterior esquema, sería claramente una peligrosa simplificación conceptualizar cada comunicación como un evento privado entre los dos aparentes comunicantes, esto sería equivalente a aceptar la hipótesis que una independencia perfecta existe entre todas las diadas o partes, ignorando las muchas y complejas relaciones entre las diferentes partes y entre cada parte y la totalidad. Habiendo enunciado los anteriores conceptos el 1er. axioma de la comunicación puede ser reformulado como sigue: Uno no puede no jugar en el continuo juego de N-personas.

LOS PARAMETROS DE LA COMUNICACION

Territorialidad

El segundo axioma de la comunicación afirma que cada comunicación presenta al mismo tiempo un aspecto de "contenido" que nosotros llamaremos X y un aspecto relacional que nosotros llamaremos Y. Por lo tanto es posible de representar la comunicación del emisor (c) con este tipo de enunciado: $C = (X, Y)$ en donde X indica el contenido e Y la relación entre los comunicantes. Pero dicho enunciado no toma en cuenta la necesidad de determinar precisamente el receptor de la comunicación. En este momento es necesario introducir en el enunciado 1 como se muestra arriba un nuevo parámetro: el número de participantes del juego continuo. Nos vamos a referir a esto como "territorialidad" indicando esto con la letra N. Por lo tanto el enunciado se transforma: $C = (X, Y, N)$.

Cada comunicación es, por lo tanto, caracterizada por su

CARLO RICCI - MARA SELVINI-PALAZZOLI

propia N (territorialidad) con la cual las múltiples líneas relacionales definidas por el emisor se toman en cuenta y a través de las cuales el emisor inevitablemente define su relación simultáneamente con todos los otros jugadores en el juego de N-personas.

Cuando la territorialidad no está bien definida por los jugadores, el juego continuo permanece ambiguo, su ambigüedad puede causar que la comunicación aparezca irracional, de manera tal que los jugadores puedan acusarse unos a otros de ser ilógicos o a lo mejor "locos".

De hecho las condiciones bajo las cuales nosotros podemos llamar a una comunicación "racional" en un cierto valor de territorialidad (N) son diferentes, y aún contrarias a las condiciones que definen a la misma comunicación como racional en otro valor de territorialidad (N). Tomaremos un caso de nuestro libro "Sul Fronte dell'Organizzazione". El Director Principal de una gran corporación, queriendo reestructurar el departamento de compras, contrató a un experto altamente calificado sacándolo fuera de la empresa de su mayor competidor. Para persuadirlo, el Director de una manera confidencial lo invitó a algunas reuniones privadas. Luego, cuando el experto se hizo cargo de su trabajo la conducta del Director súbitamente cambió. El ni le dio la bienvenida ni lo introdujo a los otros ejecutivos pero en cambio lo hizo dirigirse muy formalmente al Vice-presidente del departamento de personal. Luego, por algunos días, no estuvo disponible para él ni siquiera por teléfono. Si la conducta del Director hacia el experto es visualizada dentro de la diada su conducta puede aparecer irracional, inconsistente y desatenta. Pero si incluimos en nuestra observación también al Vice-presidente amplificando la territorialidad desde el nivel N-2 al N-3 la conducta del Director puede tomar un nuevo significado.

De hecho, teniendo en cuenta la negativa del Vice-presidente de aceptar cualquier innovación, la ducha fría del Director al experto, sirve al propósito racional de reasegurar al Vice-presidente. Desde la perspectiva del experto, en vista de las charlas confidenciales con el Director su conducta puede aparecer

COMPLEJIDAD INTERACCIONAL Y COMUNICACION

inexplicable e inclusive cruel. Seguramente no sería fácil para el experto entender la conducta del Director como un intento de balancear el juego interaccional N que incluye también al Vice-presidente y otros empleados relevantes al concepto de territorialidad (N) como lo concebimos es diferente de aquel de un grupo como es normalmente entendido. Por ejemplo observando al emisor como un miembro familiar la territorialidad (N) de su comunicación (C) puede ser $\geq$ que el número de miembros del grupo familiar. El "grupo", como es definido por la territorialidad constituye lo que hemos denominado el juego de N personas. Le sigue que un importante paso hacia el análisis de la comunicación interpersonal emerge de la clasificación de la territorialidad de los comunicantes que marcan el perímetro del juego relacional. Pensamos que es fundamental remarcar la importancia de la territorialidad (N) en toda comunicación, particularmente si tomamos en cuenta que ésta puede variar en el tiempo, puede cambiar acorde con el contenido (X) y puede permanecer poco clara o ambigua para los comunicantes. Puede también pasar que el emisor, el aparente receptor y los co-receptores (por ejemplo las personas que componen el grupo familiar) todos pueden comunicarse de acuerdo a un valor diferente de territorialidad. Consecuentemente, cada miembro puede aparecer a los otros irracional o "loco".

La territorialidad que califica y da significado a las comunicaciones del emisor pueden ser $\geq$ que el número de los miembros de la familia nuclear.

Aún más, cada persona que participa en el juego continuo puede percibir la territorialidad de emisor en forma diferente. No obstante nosotros hipotetizamos que para cada comunicación hay un N-valor de territorialidad dentro del cual los mensajes aparentemente irracionales del emisor cobran sentido.

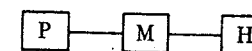
Adoptando el concepto de territorialidad (N) la complejidad interaccional aumenta. En este punto debemos reconsiderar cómo las relaciones (Y) entre los N jugadores, son definidas. Para describir este aspecto de la comunicación, Watzlawick y coautores formulan el quinto axioma: "Todos los intercambios

CARLO RICCI - MARA SELVINI-PALAZZOLI

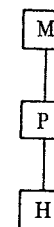
comunicacionales son simétricos o complementarios dependiendo si están basados en la igualdad o diferencia". En este sentido las relaciones complementarias dan lugar a la noción de dos diferentes posiciones: "Un jugador ocupa la que ha sido descrita como la posición superior primaria o 'one-up' y el otro la correspondiente inferior secundaria o posición 'one-down'. Por otro lado la relación simétrica es caracterizada por el 'mínimo de diferencia'".

El concepto de territorialidad introducido por nosotros pretende ir más allá de las descripciones diádicas, tomando en consideración tanto la posición del emisor en relación a todos los otros jugadores del continuo juego de N personas.

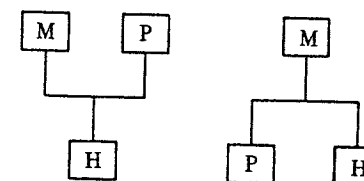
Sigue a continuación que las estructuras relacionales para ser tomadas en consideración se incrementan exponencialmente con el creciente N valor de territorialidad. En el caso de N-3 las posiciones asumidas por los jugadores interactuantes pueden ser descritas en la forma de esquema de organización. Nro. 1 muestra una estructura de igualdad en una triada.



Nro. 2 refleja la mayor diversidad.

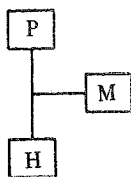


Números 3 y 4 muestran estructuras mixtas en dos niveles.



COMPLEJIDAD INTERACCIONAL Y COMUNICACION

Y el número 5 muestra una así llamada estructura de línea de staff en la cual un componente de la triada es colocado (con respecto a los otros dos) en la posición de "consultante".



En resumen, cambiando la posición de los 3 en las 5 diferentes organizaciones existe la posibilidad de 19 diferentes estructuras de relaciones triádicas. Las letras M, P y H representan diferentes estructuras relacionales de Padre, Madre e Hijo en un juego de 3 personas.

Imaginémonos a la Madre entrando en el dormitorio de su hijo temprano en la mañana diciendo "Son las siete en punto". Obviamente estas palabras pueden ser acompañadas por expresiones no verbales diferentes. Considerando lo que hemos dicho previamente en relación a territorialidad nosotros podemos concluir que en este mensaje la Madre no sólo define su posición en relación a su hijo sino también simultáneamente su posición en relación con el Padre.

La relación entre el P y el H también debe ser considerada. De esta manera una forma relacional triádica se estructura. Debe notarse que la presencia física del Padre no es necesariamente requerida en el momento de la comunicación cuando hay un juego continuo de 3 personas. Un ejemplo puede ser: "Cómo educar al hijo". Las 5 organizaciones denotan algunas de las relaciones triádicas definidas por la Madre. Para la conveniencia del lector hemos añadido a cada esquema una frase que refleja la estructura relacional dentro de la diada.

Organización 1:

—"Los tres estamos de acuerdo que esa es la hora correcta de levantarse".

CARLO RICCI - MARA SELVINI-PALAZZOLI

Organización 2:

—"Yo no soy como tu padre que te dejaría holgazaneando en la cama hasta las 10. ¡Levántate! "

Organización 3:

—"Tu padre y yo hemos decidido que esta es la hora en que tienes que levantarte".

Organización 4:

—"Tú eres un negligente como tu padre. Si yo no estuviera aquí para ponerte en movimiento".

Organización 5:

—"Como tu padre ha decidido que te levantes, yo supongo que es hora de levantarte".

Estos ejemplos obviamente no cubren las 19 estructuras relacionales triádicas potencialmente definibles por la Madre, que pueden ser reproducidas cambiando su posición en los diagramas esquematizados. En la organización 3 por ejemplo, si nosotros colocamos al Padre en el mismo nivel que el Hijo, los dos en una posición superior con respecto a la Madre la frase dicha por la Madre se traduciría de esta manera "Yo estoy aquí haciendo lo que tú y tu Padre han decidido".

En este momento ya debe ser claro que los efectos de la comunicación basada tradicionalmente (como por ejemplos anteriores) sobre el aparente receptor puede variar enormemente, de acuerdo a la percepción del receptor de la organización triádica.

En la situación presentada en la Organización 4. "Tú eres un negligente como tu Padre. Si yo no estuviera aquí para ponerte en movimiento"... el Hijo puede no levantarse no porque está en desacuerdo ni con la hora de despertar ni con el derecho de su Madre de llamarlo, pero más bien porque él está en desacuerdo con la definición que da la Madre de su Padre. La conducta del Hijo sólo puede ser entendida si el observador va más allá del nivel diádico.

Desde el momento que los aspectos relacionales de una comunicación que va más allá de la aparente diada emisor-re-

COMPLEJIDAD INTERACCIONAL Y COMUNICACION

ceptor son generalmente convenios no verbales y por lo tanto no están bien clasificados, el significado es frecuentemente ambiguo. Con esta ambigüedad pueden emerger situaciones conflictivas que son difíciles de resolver. El Hijo puede acordar acerca del contenido (que es correcto levantarse a las siete) y también acerca de la definición que la Madre da de ella misma en relación con él, pero él puede estar en desacuerdo con la definición de superioridad que la Madre da de ella misma en conexión con el Padre que ha sido puesto en el mismo nivel del Hijo. Es posible que todos estos aspectos relacionales que van más allá de la diada Madre-Hijo pueden constituir el área del desacuerdo del Hijo con su Madre y esto puede influenciar su conducta y provocar malentendidos. Por lo tanto considerando la naturaleza triádica de la comunicación en un juego de 3 personas el Hijo, más allá de su elección de quedarse en la cama o levantarse, ya está inevitablemente envuelto en el probable conflicto implícito entre los padres. Su respuesta conductual, sin tener que ver con su nivel de conciencia está basada triádicamente y deber ser considerada un "movimiento" en el juego continuo de N personas con el cual él se va a definir inevitablemente con respecto a la Madre y al Padre.

En este punto nosotros no consideramos necesario tomar en consideración todas las posibles estructuras relacionales triádicas y posibles conflictos que emergerían en un juego de 3 personas. Más bien, es suficiente haber mostrado que el cambio de un análisis diádico a uno triádico, incrementa exponencialmente el número de relaciones que deben ser consideradas.

El número y la calidad de posibles conflictos se incrementa proporcionalmente con la complejidad interaccional del juego de N-personas.

Esto confirma, una vez más, la necesidad de ir más allá de un análisis diádico para desarrollar N-ádicos modelos de comunicación con los cuales tratar de adecuarse a la complejidad interaccional del juego de N-personas.

El parámetro del tiempo:

Otro aspecto de la comunicación interpersonal que en

CARLO RICCI - MARA SELVINI-PALAZZOLI

nuestra visión ha recibido injustamente poca atención es el parámetro de tiempo (T). Nosotros deseamos señalar que este parámetro (T) debe ser incluido agregándolo a X (contenido), Y (relación) y N (territorialidad) en el análisis de la comunicación.

De hecho, en los mismos términos que X, Y y N es posible de calificar a cada comunicación de un modo diferente en conexión con el valor diferente del parámetro del tiempo (T) en el cual las variables X, Y y N son propuestas, por ejemplo, por un corto, medio o largo espacio de tiempo.

Por lo tanto, es ahora posible representar la comunicación interpersonal de la manera siguiente:

$$C = (X, Y, N, T)$$

Como la territorialidad, el tiempo es una variable que usualmente permanece indefinida. Puede suceder que los jugadores en el juego de N-personas se comuniquen de acuerdo a diferentes valores del tiempo (corto, medio o largo espacio de tiempo). El resultado de esta falta de atención focalizada en el valor tiempo puede causar que la comunicación parezca irracional generando ambigüedad y acusaciones mutuas. Aún más, es posible probar que las condiciones bajo las cuales uno puede llamar a una comunicación "racional" en un cierto espacio de tiempo, (por ejemplo en corto tiempo) son diferentes y aún contrarias a las condiciones que definen a la misma comunicación como racional en otro espacio de tiempo (por ejemplo en largo término). Le sigue que aunque se pueda realizar un acuerdo en X, Y y N, el acuerdo puede ser impedido a través de discrepancias en el valor T.

Un breve ejemplo:

En una organización algunas personas decidieron formar un grupo de investigación, todos de acuerdo que el grupo sería dirigido por un miembro determinado. Durante la fase final del proyecto de investigación se produjo una oposición inesperada de un miembro del grupo: lo racional por debajo de la objeción permaneció oscuro, haciendo que él pareciera irrazonable. A través del tiempo, se hizo aparente que él no se opuso al contenido del proyecto (X) ni a los aspectos relacionales y

jerárquicos (X) por ej.: el líder, ni a todos los miembros del grupo (N) pero solamente al parámetro ambiguo del tiempo (T). De hecho, aunque estaba preparado para aceptar X y N por un largo tiempo, él no deseaba aceptar al líder por un período indefinido.

Por lo tanto, la fórmula:

$$C = (X, Y, N, T)$$

muestra que con toda comunicación en un cierto tiempo (T) los jugadores deben clasificar el "espacio" (N), el tiempo (T) y el contenido (X) y los aspectos relacionales (Y) y de esta manera comprometiéndose los mismos en el juego continuo.

De esta manera se hace posible analizar cada comunicación como un "movimiento" en el juego de N-personas.

Es útil cuantificar la comunicación interpersonal usando la fórmula arriba dada ya que ésta nos posibilita describir cada comunicación con la misma "unidad de medida" que es generalmente usada para describir otros conceptos básicos en organizaciones —por ejemplo— el concepto de rol. De hecho, como los parámetros X, Y, N y T pueden definir la comunicación en sí misma, estos mismos parámetros son mostrados para ser igualmente válidos en la definición del rol. Un rol puede ser definido brevemente como la suma total de información especificando aspectos tales como a) qué hacer (X), b) cómo hacerlo (Y), esto es, cómo relacionarse efectivamente con los roles de los otros jugadores, c) el número de jugadores con los cuales uno debe hacer contacto (N) y d) el espacio de tiempo (T) dentro del cual señalan a, b y c que debe llevarse adelante. Usando la fórmula antes dicha es posible comparar el concepto de comunicación y rol. Esto puede constituir un antídoto contra la partición analítica de un proceso complejo como la comunicación interpersonal. De la misma manera los parámetros de la fórmula pueden ser usados como herramientas para analizar los procesos de comunicación en un sistema vasto de organización.

Dualidad:

De la fórmula se sigue que cada comunicación es caracteri-

zada por la forma en que los cuatro parámetros (X, Y, N, T) son combinados. Todas las posibles combinaciones de estos cuatro parámetros forman el completo universo de la comunicación. De esta manera la forma particular de los parámetros X, Y, N y T de cada comunicación se combinan representando una elección en el universo de la comunicación. Se sigue que toda comunicación revela no sólo lo que ha sido seleccionado pero también al mismo tiempo lo que ha sido excluido. Sin tener que ver con el nivel de conciencia que participa en hacer esa elección, la no comunicación puede tener un valor de cero en relación al juego continuo, tanto como "no decir o hacer nada" es una comunicación plena de sentido solamente por la virtud de lo que ha sido excluido al hacer esa elección.

De estos simples conceptos una importante propiedad de la comunicación emerge: *la dualidad*. Tomando en consideración el fenómeno simultáneo de inclusión/exclusión la complejidad interaccional de cualquier proceso comunicacional se incrementa.

En general, la atribución de significado es usualmente derivada de un aspecto individual: lo que ha sido comunicado con una cierta elección de X, Y, N, T. Sin embargo es también posible referirse a lo contrario, es decir, lo que ha sido excluido. Ningún problema aparece cuando la elección de la comunicación se hace en un universo de dos posibilidades: lo que ha sido elegido totalmente se corresponde con lo que ha sido rechazado y viceversa.

Puede aparecer confusión cuando la elección se hace en un universo que excede de dos diadas. Un breve ejemplo:

Un adolescente es fuertemente alentado por sus padres para hacer deportes. Con esfuerzo se convierte en campeón de su liga. En este punto se encuentra súbitamente con el descontento de sus padres. No va a ser fácil para él entender que el apoyo de sus padres para que juegue deportes no estaba basado en los méritos de la actividad en sí misma, sino más bien en lo que en la mente de sus padres los deportes excluían (es decir mala compañía, masturbación, drogas, etc.).

La dualidad es una propiedad de la comunicación que

COMPLEJIDAD INTERACCIONAL Y COMUNICACION

puede incrementar dramáticamente la complejidad interaccional, como también puede tener efectos nocivos en el proceso de aprendizaje de la conducta interaccional.

Conclusiones:

La comunicación interpersonal debe ser considerada un fenómeno en extremo complejo en el cual diferentes "niveles de realidad" están simultáneamente presentes.

Aquéllos que arriba hemos considerado no son una representación exhaustiva de las muchas dimensiones de la comunicación humana, aunque sí reflejan un primer paso hacia el desarrollo de modelos N-ádicos de comunicación que tratan de encajar con la complejidad interaccional de los juegos de N-personas.

De esta manera, si nosotros aceptamos la proposición que la comunicación es inevitablemente un movimiento que coloca a uno mismo en relación con otros jugadores en el continuo juego de N-personas, entonces cada comunicación debe ser juzgada como una operación compleja a través de la cual todos los "niveles de realidad" que caracterizan el juego de N-personas se transforman en integrados y llegan a una síntesis. En cada comunicación estos diferentes "niveles de realidad" pueden encontrarse y sin embargo permanecer diferentes o pueden combinarse y mezclarse, encontrando una cierta armonía a pesar de sus contradicciones. O si no, con sus incompatibilidades, ellos pueden formar una mezcla explosiva.

Conclusions

Interpersonal communication should be considered an extremely complex phenomenon in which different "levels of reality" are simultaneously present. Those considered above are by no means an exhaustive representation of the many dimensions of human communication, although they do reflect a first step toward the development of N-adic models of communication that try to match the interactional complexity of the N-person games. So, if we accept the proposition that communi-

CARLO RICCI - MARA SELVINI-PALAZZOLI

cation is inevitably a move to place oneself in relation to other players in the ongoing N-person game, then every communication should be judged as a complex operation through which all the "levels of reality" that characterize the N-person game become integrated and find synthesis. In every communication, these different "levels of reality" may meet and yet remain distinct or may blend and mix, finding a kind of harmony in spite of their contradictions. Or else, with their incompatibility, they may form an explosive mixture.

Bibliografía

1. HALEY, J.: "The Family of the Schizophrenic, a Model System". J. Nerv. Ment Dis.
2. SELVINI-PALAZZOLI, M.; ANOLLI, L.; DI BLASIO, P.; GROSSI, L.; PISANO, I.; RICCI, C.; SACCHI, M. y UGAZIO, V.; *Sul Fronte dell'Organizzazioni*, Milano Feltrinelli, 1981.
3. WATZLAWICK, P.; BEAVIN, G. and JACKSON; *Pragmatics of Human Communication*, New York, 1967.

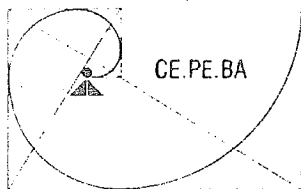


CENTRO PRIVADO
DE TERAPIAS BREVES

CURSOS 2do. CUATRIMESTRE -- AÑO 1985

- LAS HABILIDADES TERAPEUTICAS BASICAS
- TERAPIA BREVE, SU APLICACION EN PACIENTES ORGANICOS CRONICOS
- COMO EQUIVOCARSE EN TERAPIAS BREVES

INFORMES: Av. Libertador 5881, 1er. Piso "A", 785-1111, 782-9851,
783-3352, de 14 a 18 horas.



*Centro de Pediatría
Buenos Aires*

... Por una Pediatría hacia la familia

Cuerpo de Profesionales: Clínica Pediátrica, Dr. Alberto Greco, Dr. Mario Elman, Dra. Liliana Guaita, Dra. Silvia Marzo, Dr. Pablo Milman, Dra. Vera M. de Silinger, Dr. Enrique Silinger, Dr. Edgardo Syld. Clínica del Adolescente, Dr. Daniel Rempel. Ginecología Infanto Juvenil, Dra. Elida Logiovine. Obstetricia, Dr. Juan Carlos Gómez Luengo, Dr. Guillermo Lodeiro Martínez. Cirugía y Ortopedia, Dr. Hugo Marengo. Dermatología, Dra. Rita García Díaz. Oftalmología, Dra. Norma Graifman. Psicopedagogía, Lic. Lidia Crescente. Odontopediatría, Dra. Susana Maretto, Dra. Patricia Zalesky. Laboratorio, Dr. José Luis Morán. Kinesiología, Kga. Jenny Aaramayo. Psicología, Lic. Abel Zanotto.

Tel. 71-7093. Emergencias: Radiollamada 311-0056-59, Código 4141
Gorriti 4891 (1414) Palermo Viejo

INSTITUTO ARGENTINO DE INVESTIGACIONES DRAMATICAS

SEMINARIO TEORICO-PRACTICO DE PSICOTERAPIA DE PAREJAS CON TECNICAS DRAMATICAS

Horario: Martes de 10 a 11,30 horas
Iniciación: Martes 3 de Septiembre de 1985

LABORATORIO SOBRE PROMOCION DE LA CREATIVIDAD

Domingo 8 de Septiembre de 1985 de 9 a 19 horas

Ambos a cargo de:

Dr. Carlos M. Martínez Bouquet
y Lic. María C. Flórez Monroy

Informes e inscripción: Avda. Santa Fe 1385, 5° piso,
1059-Buenos Aires, Tel. 42-2090

CENTRO

de

D ocencia
I nvestigación y
A sistencia
P sicológica

Directores:

Dr. Roberto P. Montanelli
Dr. Carlos N. Díaz Usandivaras

PSICOPATOLOGIA DE ADULTOS
PSICOPATOLOGIA INFANTO JUVENIL
PSICOPEDAGOGIA Y CLINICA DEL APRENDIZAJE
PSICOTERAPIA MARITAL Y FAMILIAR

DOCENCIA EN: PSIQUIATRIA - PSICOLOGIA CLINICA
Y TERAPIA FAMILIAR

ESCUELA CLINICA DE TERAPEUTAS FAMILIARES
INVESTIGACION

ACASSUSO 907 - SAN ISIDRO - Tel. 743-8645 - 1642-Bs. As.

CERF

*Centro para el Estudio de
las Relaciones Familiares*

Director

Psic. Alberto González

Codirectora

Psic. Olga Benzaón de González

CURSOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 1985

A) INTRODUCCION A LA TEORIA Y TECNICA DE LA TERA- PIA FAMILIAR (Anual)

Programa I. (2 horas semanales)

Programa II. (4 horas semanales)

Programa III. (6 horas semanales)

Coordinación: Psic. Olga Benzaón de González

B) FORMACION EN PRACTICA CLINICA 1985-1987

Curso preparatorio de Septiembre a Noviembre 1985.

Coordinación: Psic. Alberto G. González

SOLICITAR ENTREVISTAS DE ADMISION EN:

Soler 3765 - 4° "J" N° 18

824-1188 de 8,30 a 16,30 hs.

Estructura y proceso en la terapia familiar

Dr. MAX HERNANDEZ, Lic. FERNANDO PRIALE* y Lic. ALBERTO S. FISZBEJN**

* *Sociedad Psicoanalítica del Perú, José Pardo 674, Dto. 802, Miraflores, Lima, Perú.* ** *Liga Israelita Argentina de Lucha contra la Tuberculosis y Medicina Preventiva, Humahuaca 4650, 3er. Piso, A, (1192) Buenos Aires, Argentina.*

Cuando menos desde el importante artículo de Lucien Sebag (1962), en el que definía la oposición entre las explicaciones de tipo histórico y las de corte estructural, la relación entre ambos tipos de propuestas explicativas ha sido objeto explícito de reflexión por parte de los psicoanalistas (Cf. Green, 1963, 1967).

En el campo de la terapia de familia —en el que el vocablo estructura ha sido usado con insistencia en la naciente teorización sobre los sistemas familiares— la información obtenida sobre la familia organizada en series dispuestas en términos narrativos y aquella que ordena los datos del campo de observación redistribuyéndolos de acuerdo a sus relaciones sistémicas, parecen provenir de dos opciones metodológicas claramente distintas.

Sin embargo la actividad clínica, y en especial el trabajo de intervención en crisis hecho en el grupo familiar conjunto, muestran en la proteiforme variedad de su presentación la

M. HERNANDEZ - F. PRIALE - A. FISZBEJN

posibilidad de encontrar un enfoque metodológico en el que lo estructural y sincrónico sea visto de modo tal, que la captación del funcionamiento familiar en las coyunturas críticas permita entrever los múltiples aspectos del proceso, por el cual los acontecimientos de la vida de una familia se cristalizaron en una configuración estructural determinada.

Cierto es que, a manera de cuestión previa insoslayable, es menester intentar algunas precisiones. La noción de estructura desde sus orígenes ha tenido tantos significados fundamentales y tantas acepciones como autores; acepciones perfectamente irreductibles a un común denominador e incluso totalmente autónomas (Bastide, R.). En su inserción en las diversas disciplinas en las que ha sido usada la palabra estructura, ha involucrado siempre los siguientes factores:

- 1) Un conjunto u organización;
- 2) Las partes o elementos de este conjunto u organización;
- 3) Las relaciones de esas partes entre sí.

Cada disciplina enfatizó uno u otro de esos factores. Así por ejemplo en biología se priorizó la organización; en lingüística las relaciones.

Las ciencias “exactas” o naturales han ejercido los poderes del ideal científico por definición. Su carácter simbólico, su nivel de perfección y logro han pasado a menudo de ser una referencia constante a ser motivo de crudas extrapolaciones, para abordar la realidad humana. Las ciencias humanas y sociales, han intentado acceder a un nivel de simbolización similar al de las ciencias “exactas”, vía la noción de estructura (Priale, R. F.; 1982).

Estructura significa construir y es sinónimo de orden. Es pues establecer un orden; construirlo.

En las ciencias físicas, en la lógica simbólica, en las matemáticas, esto se logra por abstracciones sucesivas; desde una base o percepción intuitiva de la realidad y la selección de algunas propiedades, abstraídas de un conjunto mayor, para organizarlas según reglas o definiciones primarias o axiomáticas. La propuesta estructural es una propuesta de espacialidad y simultaneidad que tradicionalmente ha excluido la sucesividad

del orden temporal. Concebida así la noción de estructura, sólo la historia podía dar cuenta del movimiento y del cambio.

“La finalidad de la historia es el estudio de los cambios, mientras que todo modelo teórico expresa en primer término el análisis de un equilibrio y de una estabilidad” (Vilar, P.; 1980). La unidad familiar discurre dentro de un proceso evolutivo que involucra los ciclos vitales de sus miembros. La familia en su conjunto atraviesa una serie de estadios evolutivos cada uno de los cuales presenta al grupo familiar con una serie de tareas específicas que debe superar de manera de evitar una crisis crónica, un estancamiento o la instauración de patrones disfuncionales.

Pero también el tiempo es una propiedad del espacio. Una geometría es la forma de organización de un espacio que definimos, de manera general, como una colección arbitraria de objetos homogéneos entre los que existen relaciones similares a las relaciones espaciales (continuidad, distancia, adherencia) (Alexsandrov, A. D.; 1976).

Los diversos espacios se clasificarán de acuerdo a los tipos de relaciones espaciales o propiedades definidas.

Sucede sin embargo que las nociones de distancia o continuidad son intuitivamente “evidentes”. El tiempo, considerado como una propiedad más, no nos resulta tan evidentemente intuible. Sin embargo, definido para una geometría no euclidiana es decir, una geometría que no corresponde a nuestro entorno inmediato, presenta una simetría cuasi-perfecta en las cuatro dimensiones del continuo indisoluble espacio-tiempo.

Esta referencia a la interpretación einsteniana tiene por objeto poner de manifiesto que antes de él, espacio y tiempo eran consideradas como entidades independientes y absolutas. Espacio y tiempo modelaban una apariencia simétrica perfecta con un orden y una coherencia interna tales que al decir de Whitehead se hallaban muy cerca del “orden celestial”. La lógica misma que se desprende del sistema encontraba en la “inmediatez espacial” puerto seguro a la explicación causal. Todo proceso de verificación sincrónica se basa en el prestigio

“eterno” de que goza la lógica: nunca aporta nada que no pueda ser visto ya de golpe.

De lo señalado se desprenden dos precauciones definitivas:

- 1) que el concepto de causa —como lo señalaba Croce en su cruzada contra las inteligencias “envueltas en las sombras del naturalismo o del positivismo”— es *sensu strictu*, extraño a la historia, porque surgido del terreno de las ciencias naturales cumple su oficio en el interior de dicho ámbito.
- 2) que en lo estructural y sincrónico la dimensión temporal está presente así fuese en unidades temporales muy pequeñas.

La terapia familiar ha repetido ciertos hábitos de pensar “newtonianamente” su espacio estructurante. A pesar del énfasis puesto en el pensamiento interaccional y en la causalidad circular, ha seguido formas análogas a las del causalismo al procesar la información. Esto es enfocar en “una sola estructura” global (espacio), todas las explicaciones posibles de la dinámica familiar. El movimiento interno, las crisis, los cambios repentinos, las pautas estructuradas de interacción, la historia misma de la familia, todo es encajado a duras penas en el esquema, rompiéndolo en contradicciones o diagramando la historia de un amor imposible: diacronía-sincronía. Y esto debido al hábito de asignarle el mismo tiempo uniforme y absoluto a todos los elementos del conjunto, como si desde cada uno de ellos se percibiesen los mismos hechos “simultáneos” desde la misma óptica. Si recurrimos a una metáfora geométrica la familia es una geometría de espacios vitales conjugados y asimétricos en su calidad temporal.

El modelo sistémico ha prevalecido como metáfora explicativa por más de tres décadas. Lo más promisorio de dicho marco conceptual es que permite a la vez cuestionar el modelo médico y desplazar el foco del individuo al grupo familiar. Sin embargo, los conceptos de homeostasis y equilibrio, centrales a la teoría hacen difícil acercarse al dato cotidiano del cambio producido en las familias por el paso irreversible del tiempo. Como señalan Giacomodonato y Weissmark (Giacomodonato &

Weissmark; 1981) es frente a esta problemática que los conceptos referidos muestran lo relativo de su utilidad.

A nuestro parecer se ha relegado a un segundo plano el valor de los procesos en el acontecer de los fenómenos familiares al modelar conceptualmente la familia en base a la teoría general de los sistemas, pretendiéndose agotar en dicha metáfora todas las explicaciones posibles. El encuadre psicoterapéutico del grupo familiar conjunto, al disminuir la brecha entre las interacciones observables y las relaciones inferidas, amplía la significación del "aquí y ahora", pues, como señala el informe del G.A.P. (Grupo para el Avance de la Psiquiatría), desde la perspectiva motivacional las interacciones del "aquí y ahora" son inseparables tanto de las interacciones que inmediatamente las preceden cuanto del pasado familiar. Más allá de las interacciones confinadas a la situación de observación, están las relaciones "invisibles" derivadas del prolongado contacto que los miembros de la familia mantienen entre sí, en el interior del átomo de parentesco en la unidad doméstica y que están representadas en las fantasías inconscientes de los miembros (Hernández, M. y Escribens, A. 1983).

Pasaremos a definir el concepto de pauta estructural considerándola como la relación que discurre entre los miembros componentes de una familia por efecto del proceso histórico.

Definida de esta manera, es posible mediante la aproximación psicoanalítica intentar esclarecer la articulación armónica, conflictiva o disyuntiva que media entre la representación más o menos precisa que los miembros de una familia tienen de la misma y las cristalizaciones de las fantasías inconscientes que surgen de las disposiciones, movimientos pulsionales, demandas y deseos referidos a las relaciones intrafamiliares, al procesarse en torno a los planos de clivaje que separan las generaciones y los sexos, derivados de la institución del Edipo (Lidz, Lemlij).

Las familias son también sistemas adaptativos complejos de tipo abierto, sujetos a continuas presiones internas y externas que cada estadio evolutivo le imprime. Esto entendiendo como adaptabilidad del sistema familiar la capacidad de persistir a través de modificaciones. La estructura familiar varía con el

tiempo pero mantiene las relaciones de continuidad entre sus miembros. Como todo sistema viviente sigue las pautas de la evolución. En el caso de la familia de procreación el fin de la pareja es predominantemente permanente. En el de la familia de orientación el fin es más bien transitorio; en ella priman las disposiciones centrífugas.

A partir de la pareja podemos señalar, el paso de la familia por los siguientes estadios del ciclo vital.

1°) La relación de cortejo en la cual la elección de objeto supone la elaboración previa de la problemática de la identidad sexual y la metamorfosis de la pubertad que permitan la búsqueda exogámica de la pareja. Los evitamientos fóbicos y las confusiones de identidad son algunas de las respuestas patológicas más frecuentes.

2°) El matrimonio que exige el encuadre armónico del deseo sexual dentro de los marcos de la ley. Las dificultades esquizoides frente a la convivencia, la frigidez, y la impotencia post-matrimoniales, la psicosis del ama de casa son algunas de las reacciones disfuncionales observables.

3°) El nacimiento (la adopción) del primer niño, esto es, la aceptación fáctica de un tercero. Las esterilidades psicogénicas. La depresión puerperal, la reactivación de impulsos hostiles de estirpe edípica, las rupturas familiares derivadas de la incapacidad de compartir, etc., son patologías propias de esta situación.

4°) El compartir la educación de los hijos con otras autoridades. Las dificultades en este sentido pueden expresarse en los rechazos a la escuela (la llamada fobia a la escuela), reacciones hostiles de suspicacia a los maestros, etc.

5°) El compartir la autoridad con los hijos adolescentes. La vasta problemática que va desde la rebeldía adolescente, las crisis de identidad, el consumo de drogas, parece indicar las dificultades de la familia en enfrentar creativamente esta tarea del desarrollo familiar. Las deserciones paternas o maternas pueden ser síntoma de la misma imposibilidad.

6°) La reorientación de la relación de pareja cuando los hijos se van. Una acentuación unilateral del rol materno en desmedro de otras posibilidades expresivas y de realización

puede estar en la base de respuestas del tipo depresivo involutivo o de depresiones con síntomas paranoides.

7°) La intensificación del sistema diádico a partir de la jubilación o retiro. De la madurez o integridad de los cónyuges depende la capacidad de enfrentar las angustias propias del envejecimiento y el deterioro de las capacidades físicas y mentales. La capacidad de contener patologías propias de la senectud deriva de la capacidad de la reestructuración de los vínculos de pareja y de la individuación de los miembros.

8°) La situación individual luego de la muerte de un cónyuge. El desarrollo de la capacidad de estar solo (Winnicott, 1965) y la posibilidad de enfrentar las situaciones de duelo y pérdida de manera adaptativa, sin negaciones maníacas ni trastornos depresivos, no sólo dependen de los fundamentos infantiles de la personalidad sino de todo lo elaborado durante el transcurso vital.

Todas estas transiciones, más o menos normativas, así como las transiciones más bien aleatorias, que la familia debe llevar a cabo en su conjunto y el enfrentamiento a las diversas tareas que el fluir de la vida exige de manera insoslayable, constituyen coyunturas en las que la familia activará de manera preferencial ciertas pautas transaccionales alternativas. Esta capacidad de producir respuestas adaptativas depende de la flexibilidad de las pautas estructuradas de interacción. Es en estas coyunturas donde es posible observar los plurales aspectos del proceso de la estructuración de los datos históricos en una pauta de intercambio. *Lo estructural y sincrónico explica los acontecimientos tanto como éstos las cristalizaciones estructuradas.*

El trabajo interpretativo del terapeuta de familia es el que facilita a través de la ocurrencia actual de la prueba de realidad que la familia pueda percibir los eventos presentes libres del sometimiento a factores defensivos inconscientes. Así se posibilita el corte que distingue el ahora del entonces restaurando el flujo de la temporalidad a la familia y a aquellos de sus miembros que lo hubiesen perdido. El espacio interpretativo readjudica el tiempo a aquellas experiencias que fueron excluidas y puestas detrás de la esfera del recuerdo. Esto intenta

llamar la atención sobre las instancias del tiempo en la dinámica familiar y lleva a examinar en los procesos, la calidad de los tiempos involucrados: tiempo del observador fuera y dentro del sistema, tiempo de cada miembro familiar, de cada relación y del sistema global.

Lo antedicho podríamos resumirlo del siguiente modo. Frecuentemente se piensa en un divorcio necesario entre las estructuras estáticas y las dinámicas. Es decir se asume que una estructura por definición, debe mantenerse igual a sí misma en el tiempo o de otro modo deja de ser una estructura. Greimas entre otros, observa que un denominador común crónico se divide en sincronía y diacronía y resuelve este impasse para la lingüística proponiendo una perspectiva a-crónica. Cualquiera que fuese el valor de esta solución para la lingüística creemos que para la comprensión de las familias debemos asumir que son sistemas en transformación permanente cuyo proceso de reestructuración mantiene un sentido de continuidad entre sus elementos y relaciones primordiales. La dimensión temporal es solidaria de la espacialidad implícita en la noción misma de estructura. El encadenamiento temporal de las estructuras instaaura el sentido. En el decurso histórico de los ciclos vitales de sus miembros vemos que cada ciclo vital posee por así decirlo, su propio tiempo conjugado a su espacio de desarrollo propio.

Intentaremos a continuación bosquejar la aplicación de los conceptos mencionados a la problemática presentada por un grupo familiar. Las consideraciones teóricas, metodológicas e incluso epistemológicas priman sobre las técnicas. Tal vez el proceso dialéctico entre la teoría y la técnica muestre, en lo que vamos a exponer, un sesgo hacia lo teórico. No obstante pasaremos al ejemplo.

Luego de un período de psicoterapia individual de orientación gestáltica, Juan un adolescente de 17 años, es derivado al CEDAP. Tras la evaluación y la apreciación diagnóstica se recomienda a la par que tratamiento psicofarmacológico, terapia familiar conjunta. Durante el curso de la terapia familiar Juan fue internado en dos oportunidades en un hospital psiquiátrico por intensificación de su agresividad con sus fami-

liares. Al cabo de algo más de un año la familia abandonó el tratamiento.

Juan, el tercero de cuatro hermanos había sido diagnosticado como esquizofrénico-paranoide. En la evaluación los padres incidieron sobre su violencia, actitudes inadecuadas, descontrol urinario, desobediencia y continua actividad masturbatoria. Juan habló más bien de sus temores y angustias, de sus dificultades escolares —estaba repitiendo de año— y de sus expectativas. Subrayó su conflicto de autoridad con su padre y también la buena relación que estableció con su anterior terapeuta, el cual viajó al extranjero, motivo por el cual suspendió su tratamiento.

Una larga entrevista domiciliaria nos permitió acceder, a partir de la comprensión de pautas estructuradas de conducta familiar observables, a dos aspectos subyacentes a la disfunción familiar.

Desde que habíamos llegado a la casa, los coterapeutas (antes del almuerzo) el padre y el resto de los hijos permanecía en una especie de estar-comedor, el cual estaba dividido del dormitorio de los padres por una cortina, mientras que la madre y Juan se encontraban en la cocina. Mientras preparaba el almuerzo, la madre daba primero el desayuno y luego el almuerzo a Juan. Luego del saludo de recepción sólo la volvimos a ver dos horas después cuando decidió venir a la sala donde habíamos almorzado con el resto de la familia. Luego de un cuarto de hora de conversación que giró en torno a la dependencia establecida entre ella y su hijo, un ruido insistente, que resultó ser el ruido de una cucharita contra una taza de hierro enlozado, determinó que la madre se levantara inmediatamente mientras decía: Me está llamando. Un código sólo compartido por ellos pero aceptado por los demás había impulsado a la madre a la acción. Al señalarle la cualidad casi automática de su respuesta, en flagrante contradicción con la exigencia familiar de que Juan hiciese las cosas por sí solo aún cuando hasta hablaban por él, la madre se entretuvo un rato con nosotros. Juan empezó a gritar pidiendo “quiero-té-quiero-té-quiero-té...” y al poco tiempo ingresó al dormitorio de los

padres para golpear con furia el catre mientras insistía “quiero-té - quiero-té...”. La madre dijo a los terapeutas “Voy, si no me va a matar”. Soslayando al padre, pidió al hijo mayor que la protegiera y acudió a cubrir la demanda de Juan con muestras visibles de pánico. Fue luego a preparar un té. Al servírselo a Juan éste se calmó.

Notamos aquí la ausencia de la interdicción paterna. El padre no ha podido introducir el código social que regula, restringe y da sentido tanto a la relación de Juan con la madre cuanto a la de éstos con el padre. Madre e hijo conforman una unidad narcisística im/pene/trable en la cual el padre no puede introducir el código social que evita la perpetuación de la simbiosis.

Además el fragmento señalado muestra en la rigidez invariable de la estructura de roles cuya conveniencia parece acentuada y cuya divergencia parece escarmentada, la presencia de características de pseudo-mutualidad en la relación, el esfuerzo de adecuación de la madre a las demandas de Juan, del padre a la pasividad resignada, de Guillermo el hijo mayor, al rol de celador del orden familiar y de las hermanas a la indiferencia militante, se realiza a expensas de la diferenciación de la identidad de cada uno de los miembros de la familia. Dicha pseudo-mutualidad se constituye en una barrera tanto para el crecimiento y desarrollo individual cuanto de la familia en su totalidad. El desconocimiento de las diferencias de identidad personales conlleva alteraciones de las relaciones familiares que afectan necesariamente las fronteras generacional y sexual en el interior del grupo familiar.

También la historia de la familia nos lleva a conocer los acontecimientos de la vida familiar que fueron cristalizando en la configuración de las pautas familiares disfuncionales.

Los padres se conocieron como pareja en Lima adonde habían migrado, él desde una provincia del Norte y ella desde una provincia del Sur. Luego de un noviazgo breve se casan cuando él tenía 25 años y ella 26. A los tres años de casados nace Guillermo y dos años después María. Tres años después nace Juan. La madre narra en ese momento: “En cada parto

me quedaba anémica. Perdía mucha sangre, en éste me dio prolapso. El ha nacido pasándose de la hora. Yo escuché 'hay que salvar a la madre, aunque sea... está negro. ¡Vive!'. Es el único que ha podido no nacer". En el mismo período nace una niña fruto de la relación del padre con una hermana de la madre. La noticia causó consternación. Juan era voraz, exigente, tardó en caminar, y durmió en una cuna en el dormitorio de los padres hasta que nació su hermana menor. Para ese entonces tenía nueve años. El padre tuvo una mala relación con Juan, nunca tuvo paciencia con él y lo trató como un incapaz y un incompetente. Los hijos estuvieron todos de acuerdo en que el padre era un tirano con toda la familia y que más bien la madre fue en demasía pasiva y tolerante. Cuando Juan ingresó a la pubertad las dificultades entre él y su padre se hicieron más severas. Guillermo y María, los mayores, habían optado por los amigos y el mundo externo. Juan quedaba solo en el centro del conflicto familiar presentando un comportamiento contradictorio en el que las conductas infantiles afirmaban su dependencia y por otra parte mostraba sus intentos radicales de independizarse. En el medio familiar sus intentos de independencia eran combatidos. Su madre generalmente lo trata como un bebé cumpliéndole hasta el más mínimo capricho, y el padre exigiéndole que estudie, trabaje y se comporte maduramente en pleno proceso psicótico. Cada acto de independencia o afirmación personal de Juan resulta abiertamente descalificado o simplemente ignorado. Los padres aparecen claramente distanciados, manteniendo roles complementarios y estereotipados. Ella es la engreidora, tolerante y pasiva en situaciones críticas; él es tirano y exigente.

Al intentar responder a la pregunta de qué factores han intervenido para que se haya desarrollado en uno de los miembros del grupo familiar una psicosis, pensamos en la relación extramarital mantenida entre el padre y la tía materna; suceso que fue revelado en la época del nacimiento de Juan. Pensamos que esta consumación fáctica de una relación simbólicamente incestuosa origina la constitución de otra pareja

incestuosa en la fantasía inconsciente familiar compartida: la pareja madre-Juan.

Su nacimiento se inscribe en un punto de disrupción de la estructura familiar (saludable hasta entonces en la medida en que se mantenían claros los clivajes sexual y generacional), pues se transgredió la prohibición que les dió origen. A partir de la transgresión se inició una nueva etapa familiar con clivajes endebles. Esto creó una marcada distancia entre los componentes del sub-sistema parental y al excluir al padre, desdibujó los límites necesarios para una relación saludable madre e hijo.

A partir de ese momento el desarrollo de Juan le exige tener que definir una identidad personal, más él se encuentra anclado históricamente en un pacto secreto e intercambio macabro, por el cual su sacrificio como "ser humano" sirve para expiar una culpa incestuosa.

Los problemas de Juan y sus padres se exacerban durante su adolescencia cuando él tiene que afrontar las tareas críticas de superar su dependencia de éstos y de la remoción objetal (Katan, A.), y cuando los padres deben poder compartir la autoridad con él, tarea que resulta imposible por cuanto el padre dejó de ser autoridad a partir del momento mismo en que transgredió la ley.

Obviamente la transición saludable de cualquier fase evolutiva se basa en la resolución de los problemas de los períodos pasados. Dado que en este caso existió una predominancia de relaciones pregenitales en el interior de una relación simbiótica, es posible suponer que Juan no dispone de recursos o mecanismos de superación o defensa lo suficientemente aptos para enfrentar individualmente las tareas citadas. Además, en lugar de tener una imagen positiva del padre, Juan encontró en él, un modelo denigrado de identificación, y en su madre un afecto asfixiante.

Hemos señalado que en el interior del tratamiento del grupo familiar, Juan hubo de ser internado en dos ocasiones. Existen datos que sugieren que el motivo del primer internamiento estuvo íntimamente relacionado con el clima de tensión generado en la familia con la revelación del secreto familiar y

ESTRUCTURA Y PROCESO EN LA TERAPIA FAMILIAR

agravado por las dificultades de la familia para poder elaborar y procesar los conflictos ligados al mismo.

Los hijos y la madre habían disminuido las acusaciones dirigidas a Juan. Ahora era el padre quien se sentaba en el banquillo de los acusados y a quien se le exigía una reparación. La situación se tornó intolerable. Juan respondió a la tensión con una intensificación de sus síntomas regresivos y de su agresividad. Así al volver a definirse como paciente "hizo" que todos se ocuparan de él y no del padre o de la complicidad de la madre. Para el sistema familiar esa salida era la única viable y ya conocida frente al drama irreparable y el temor de la desintegración familiar.

Luego del primer internamiento, cuando Juan estaba asintomático, las exigencias familiares sobre él se incrementaron. Esto provocó el paulatino incremento de su agresividad. Las sesiones de terapia volvieron a centrarse sobre él. Juan agredía a su madre y previamente al segundo internamiento los familiares refirieron que en una oportunidad golpeó a su madre y la tiró a la cama. El suceso parecía condensar dos tendencias: por una parte el intento de renunciar a la madre pues si se hacía adulto podía convertir en realidad lo que sólo pertenecía a la fantasía inconciente compartida por la familia y por otra manifestaba el intento de consumación incestuosa o de repetir la tragedia familiar. Para evitar esta alternativa optó por la regresión. Tras la reactivación de la tragedia todos *eligieron* sin saberlo la psicosis de Juan.

Al final, la familia decidió abandonar el tratamiento. Nuestra intervención produjo en el momento de la grupalización de la experiencia de la familia (aquí utilizamos un concepto sobre el que nos llamó la atención V. H. RECK) una amenaza de ruptura del esquema familiar.

A la postre la familia decidió abandonar la terapia convirtiendo a los terapeutas en "chivos expiatorios" frente a la posibilidad de la ruptura familiar. Jackson (Jackson; 1961) señalaba los serios inconvenientes que podría plantear una terapia familiar cuando al intentar modificar los "códigos" propios de la comunicación esquizofrénica se producían conflic-

M. HERNANDEZ - F. PRIALE - A. FISZBEJN

tos familiares cuyos resultados podía llevar a erupciones de alcoholismo, desórdenes psicosomáticos o ruptura del grupo familiar. Evitando continuar en la terapia, la familia reactivó las defensas estructuradas contra la comprensión de sus conflictos. En este caso tal vez nosotros obtuvimos más de la familia que ella de nosotros.

Resumen

El presente trabajo, intenta ser un aporte en la construcción de un modelo teórico y un enfoque metodológico válido para la terapia familiar, para ellos postulamos: a) un punto de vista estructural; y b) un punto de vista histórico.

Luego de una introducción en la cual se analizan los conceptos de estructura e historia demostrando cómo hasta el momento en las ciencias sociales ambas variables han constituido siempre una dicotomía; denotamos que en la terapia familiar ha prevalecido una concepción newtoniana del sistema familiar; proponiendo a cambio de ello, la necesidad de contar con un modo einsteniano de concebir los fenómenos familiares.

Llamamos la atención respecto de que la metáfora sistémica aplicada a la familia ha puesto el acento en los conceptos de homeostasis y equilibrio, relegando a un segundo plano el valor de los procesos en el acontecer familiar.

Definimos pauta estructural como la relación que discurre entre los miembros componentes de una familia por efecto del proceso histórico.

Nos ocupamos de desarrollar la importancia del ciclo vital familiar, constituido por diferentes estadios que imponen tareas a la familia en medio de continuas presiones internas y externas que deben superarse.

Revalorizamos el aporte de la aproximación psicoanalítica a la familia por considerarla acorde con el enfoque propuesto.

Por último, hemos pretendido ejemplificar el modelo teórico-metodológico expuesto, analizando la problemática presentada por un grupo familiar con un miembro psicótico tratando de demostrar cómo el punto de vista histórico y el estructural integrados dialécticamente nos permiten un acercamiento más preciso a la comprensión de la dinámica familiar.

Summary

This work tries to be a contribution to the elaboration of a theoretical model and a methodological approach valid for family therapy. For that purpose, we state: a) a structural point of view, and b) a historical one.

After an introduction in which the concepts of structure and history, showing how up to now both variables have always constituted a dichotomy in social sciences, we denote that, in family therapy a Newtonian conception of the family System has prevailed, suggesting instead the need of an Einsteinian way of conceiving the family phenomena.

We remark that the systematic metaphor applied to the family has emphasized the concepts of homeostasis and equilibrium, putting aside the value of the processes in family situations.

We define the structural guideline as the existing relationship among family members due to the historical process.

We are concerned with the development of the importance of the family vital cycle, made up of different stages that burden family members with certain tasks, in an atmosphere filled with continuous internal and external pressures that must be overcome.

We revalue the contribution of the psychoanalytic approximation to the family, since we consider it in accordance with the suggested approach.

Finally, we have tried to exemplify the theoretical-methodological model mentioned, analysing the conflict presented by a family group with a psychotic member, trying to show how the historical and structural points of view integrated in a dialectical way make it possible for us to achieve a closer and more precise approach to the understanding of the family dynamics.

Bibliografía

- ALEXSANDROV, A. D. y colaboradores *La matemática: su contenido, métodos y significado*. Ed. Alianza Universidad, 1975. Madrid.
- BASTIDE, R. (Compil.). "Introducción al estudio del término estructura". En *Sentidos y usos del término estructura en las ciencias del hombre*. Paidós, Buenos Aires.

- GIACOMODONATO, D. y WEISSMARK, M. "Familias como sistemas adaptativos complejos". En *Revista de Terapia Familiar* 7/8 Ed. A.C.E. Buenos Aires, 1981.
- HERNANDEZ, M. y ESCRIBENS, A.; "El ámbito de la terapia familiar". Trabajo presentado en el Primer Symposium Interdisciplinario de Familia. Lima, Junio 1983.
- JACKSON, D. D., "Family interaction, family homeostasis and some implications for conjoint family psychotherapy". En J. H. Masserman (dir.) *Science and psychoanalysis, II Individual and familial dynamics*. Nueva York; Grune & Stratton. 1959.
- KATAN, A. "The role of displacement in agoraphobia".
- LIDZ, T y FLECK, S.; "Schizophrenia, human integration, and the role of the family". En D. D. JACKSON (dir.), *Etiology of schizophrenia*. Nueva York: Basic Books, págs. 323-345, 1960.
- LEMLIJ, M., *El complejo de Edipo*. Trabajo presentado en el Primer Symposium Interdisciplinario de Familia. Lima, junio 1983.
- PRIALE, R. F., *Historia y Estructura*. Ensayo. Lima, 1982.
- VILAR, P., *Iniciación al vocabulario del análisis histórico*. Ed. Grijalbo, Madrid, 1980.
- WINNICOTT, D. W., "The capacity to be alone". En *The maturational processes and the facilitating environment*. Ed. Hoggarth Press. London, 1965.
- WYNNE, L. C., RICKOFF, I. M., DAY, J. y HIRSCH, S. I., "Pseudomutuality in the family relations of schizophrenics". *Psychiatry*, 21, 205-220. 1958.

Los trastornos del aprendizaje y la dinámica familiar. Una interacción mutua.¹

JULES C. ABRAMS, Ph.D.* y FLORENCE W. KASLOW, Ph.D.**

* *Profesor de Trastornos del Aprendizaje en la Universidad Johns Hopkins, Hahnemann College, 230 North Broad St., Filadelfia, PA, 19102, USA.* - ** *Profesora Adjunta de Psicología Médica de la Universidad de Duke. Directora de Florida Couples & Family Institute, Northwood Medical Center, Suite 404, 2617 North Flagler Drive, West Palm Beach, Florida 33407, USA.*

Introducción

No existe una etiología única para todos los trastornos del aprendizaje. Por el contrario, éstos pueden obedecer a múltiples factores, que suelen estar en profunda interrelación. Lamentablemente, con frecuencia el niño es estudiado desde un punto de vista unívoco y así quedan sin descubrir aspectos importantes de su trastorno individual. La tendencia de cada profesión a observar el problema desde su “punto de vista especializado” con frecuencia enmascara factores vitales que pueden exacerbar la dificultad original. No es válida la concepción de una solución aplicada por igual a todos los trastornos del aprendizaje.

Con frecuencia el niño con dificultades es producto de un entorno que, por su insensibilidad, actúa antes de comprender, exige en vez de guiar y castiga en detrimento del afecto necesario. El estudio de casos clínicos nos muestra que el niño con un trastorno de aprendizaje grave, por regla general ha

¹ Aparecido en el *Journal of Child Clinical Psychology*, Spring, USA. Publicado con permiso de los autores y del editor.

JULES C. ABRAMS - FLORENCE W. KASLOW

sufrido, en un período temprano y crucial de su vida, una amarga experiencia, en que los guías y mentores —padres y maestros— que necesitaba con urgencia, ignoraron su problema y lo agravaron. Esos casos también revelan que el niño expuesto en permanencia a un mundo que no le presta auxilio, termina por considerar a los que debieran ayudarlo como enemigos. Al llegar a la edad escolar, el niño ha aprendido a desconfiar de los que pretendían ser sus amigos, sus figuras significativas. Esta actitud constituye un obstáculo serio para su desarrollo intelectual, social y emocional.

Nuestro enfoque de los trastornos de aprendizaje se basa en la psicología psicoanalítica del Yo. La atención se centra en el funcionamiento del Yo del niño con problemas. De acuerdo con los esfuerzos precursores de Hartmann, Kris y Loewenstein, las funciones básicas de la personalidad en desarrollo son consideradas “las funciones del Yo en desarrollo”; estas funciones desempeñan un papel crítico en la adaptación del individuo a la vida. En realidad, estas funciones, percepción, memoria, conocimiento, pensamiento, acción, postergación de la gratificación, represión, ansiedad, integración y síntesis, forman la esencia misma de la vida psíquica. Como lo señala Pearson, todo aquello que interfiere con el desarrollo del Yo o de sus funciones, influye en la adaptación del niño al medio, y esto incluye una adaptación específica: la capacidad de aprendizaje (1954).

El énfasis en el funcionamiento del Yo del niño debe incluir el rol fundamental que desempeña la familia, no sólo como factor que contribuye al trastorno, sino estudiando el efecto del problema de aprendizaje sobre el grupo familiar. Nuestra tesis sostiene que existe interacción mutua; que el desarrollo del Yo del niño se ve afectado por el entorno; y que el trastorno del aprendizaje, cualquiera sea su etiología, ejerce un efecto profundo sobre la gestalt familiar.

Reacciones Parentales ante el “Niño Problema”

Los padres que esperan un hijo se forman una imagen

idealizada de cómo será ese niño. La preparación psicológica de la espera incluye normalmente la fantasía de un niño perfecto, algo así como un ideal del Yo. Los padres, de manera explícita o implícita, pueden desear un hijo con todas las características que admiran en ellos mismos; y que no tenga sus defectos. En general, se produce cierta disparidad entre el niño que los padres sueñan y el real. Aceptar y resolver esa discrepancia es una de las etapas del desarrollo parental y uno de los aspectos en la evolución de una relación materno-infantil sana. Pero cuando la disparidad es demasiado acentuada, como sucede en el caso en que nace un niño seriamente disminuido, o cuando los sueños de los padres son demasiado ambiciosos, puede producirse un trauma.

El niño normal realiza durante su primera infancia el aprendizaje de los procesos básicos del Yo, y despierta así en la madre sentimientos de alegría y orgullo. La madre con frecuencia percibe al niño literalmente como su "producto", y como un logro personal. Pero cuando el niño es "defectuoso" o se atrasa en el desarrollo de sus funciones normales, puede provocar en la madre una respuesta diferente. Es como si ella pensara: "¿Cómo pude producir este niño con tantos problemas y tan poco atractivo?".

Inicialmente, la madre deposita en el niño mayor carga narcisista que el padre, a causa de su rol global más íntimo en el proceso de gestación. Por ello, toda discrepancia entre sus ilusiones y la realidad del niño tendrá un mayor impacto en ella. El hecho de que el niño no presente un defecto físico obvio, sino que parezca simplemente "lento" o "diferente", aumenta el miedo y las fantasías de la madre; su orgullo y su autoestima se ven seriamente amenazados. Es interesante observar que las madres de niños que sufren de parálisis cerebral no experimentan este amor propio herido. Debido al defecto físico aparente, les resulta más fácil aceptar lo que la suerte les ha deparado y el hecho de que el niño "tiene algo mal"; aparentemente sufren menos sentimientos obsesivos de culpa.

Pareciera que el proceso que permite asumir el defecto del niño es análogo al de dolor y duelo que se desencadena cuando

es inminente la muerte de un ser querido. Al darse cuenta o al ser informados de que el niño tiene un problema, los padres sufren la pérdida del "niño perfecto" de sus fantasías. Primero niegan el defecto; se aferran a su ilusión; comienza la peregrinación en busca del médico que les dé un diagnóstico o un pronóstico más favorable. Cuando el defecto es confirmado repetidamente, aparece la rebelión. La madre se pregunta: ¿por qué tenía que sucederme esto a mí? ¿Será el castigo por alguna transgresión mía o de mi marido? Una infinidad de fantasías y de frustraciones irrumpen en la conciencia, mientras la madre lucha con las emociones contradictorias que siente por el niño y su furia contra Dios, los médicos y otras fuerzas menos específicas.

Luego aparece el intento de pactar con el destino: promesas de asumir ciertas conductas si el niño se cura. Pero esta búsqueda es fútil. Sólo cuando puedan enterrarse los restos del niño fantaseado y pueda llevarse a cabo el trabajo de duelo, podrá el niño real, con sus defectos, vivir y desarrollar al máximo sus capacidades, con el aliento y hasta el amor de sus padres. La aceptación del niño tal cual es y por lo que puede llegar a ser dentro de los límites de sus posibilidades, es esencial para el progreso del niño y de los padres.

El diagnóstico de una lesión cerebral mínima o de algún trastorno del aprendizaje, produce un desconcierto inicial respecto a las causas del mal. Los padres sienten una gran ambivalencia que despierta sentimientos intolerables de culpa y vergüenza. La agresión y la hostilidad que casi inevitablemente despierta el niño no pueden ser toleradas por el Superyo de los padres, y se erigen barreras que niegan estos sentimientos. Para compensar al menos parcialmente la intensa culpa que sienten por su hostilidad, los padres asumen una actitud de sobreprotección y exagerada indulgencia. Estos mecanismos de defensa, a su vez privan al niño de oportunidades de crecer y desarrollar los procesos secundarios de adaptación del Yo. El niño, en cambio, comienza a utilizar su trastorno para manejar a sus padres.

En un sentido muy real, se convierte en el déspota depen-

diente. Esta sobredependencia manipuladora desempeña un papel importante en la lucha por el poder que se entable entre los padres y el niño... el mismo tipo de conducta se traslada a la escuela y provoca problemas entre el niño y sus maestros. (Abrams y Kaslow, 1975).

Lamentablemente, es común que los profesionales "culpen" a los padres por los problemas de los hijos. A menudo el terapeuta también se culpa a sí mismo por su propia impotencia para resolver el problema del niño. La agresividad muy humana del terapeuta con frecuencia termina por dirigirse hacia los padres, que aparecen como la causa "real" de los problemas del niño en el medio familiar y en la escuela. Si bien es cierto que los padres son responsables de algunos de los problemas del niño, y que numerosos padres carecen del "insight" necesario para comprender los mecanismos de esos problemas, ello no basta para definir toda la relación padres-hijos. Los padres en general han tenido una larga experiencia de dudas y confusión en la relación con el niño con trastornos, y han recibido opiniones contradictorias. Además, la naturaleza misma de las falencias del niño dificulta seriamente la tarea de resolver los problemas que produce en la vida diaria. Obligados a enfrentar estos problemas, los padres con frecuencia sufren cansancio, ansiedad e irascibilidad. Por desgracia, la interacción entre el padre y la madre termina por manifestar tan sólo irritabilidad y agresión. Comienzan a ver en el niño un factor irritativo. Uno de los padres, por diferentes causas, puede comenzar a asumir el rol de único protector y aliado del niño. Se produce un sentimiento de devoción abnegada y una fusión del niño con el padre o la madre que obstaculiza el proceso de diferenciación. El otro miembro de la pareja queda excluido de la coalición. Se establece una rivalidad por la atención y el afecto del niño que les impide asumir su rol de guías del niño y como cónyuges.

Situaciones familiares que pueden contribuir a los trastornos de aprendizaje

En general, cuando se habla de "dificultades de aprendiza-

je", se describe un síndrome en que existe un problema de aprendizaje específico que aparece como relativamente independiente de la influencia del entorno. Sin embargo, nuestro concepto de una dificultad de aprendizaje es considerablemente más amplio. Por las razones ya expuestas anteriormente, admitimos que debemos considerar el funcionamiento global del individuo, incluyendo importantes factores psicológicos, biofisiológicos y familiares. Por ejemplo, el entorno familiar del niño puede presentar situaciones conflictivas que afecten gravemente su capacidad de aprendizaje. Las reyertas de los padres, algún miembro de la familia alcohólico o gravemente enfermo pueden desconcertar al niño. Si está preocupado por conflictos familiares, problemas financieros o se encuentra expuesto a un intento de seducción, no podrá concentrarse de manera eficaz en actividades de aprendizaje.

La actitud parental hacia el niño es determinante para su receptividad al proceso de aprendizaje. Si lo han infantilizado o sobreprotegido, no estará maduro para iniciar la escolaridad. Inversamente, algunas familias acentúan exageradamente la importancia de los logros escolares. El niño aprende rápidamente que es imperativo que obtenga buenos resultados si quiere mantener una adecuada relación afectiva con la figura materna. Cuando el niño comienza a perder la esperanza de obtener alguna vez la aprobación total de sus padres, se retrae y abandona la lucha. Es como si comprendiera que no podrá complacer a sus padres, y que, no importa cuánto se esfuerce, sólo recogerá críticas; es incapaz de satisfacerlos, de modo que, ¿para qué intentarlo?

El estudio de Harris (1961) señaló la influencia significativa de la discordia conyugal asociada al rechazo materno en la etiología de algunas dificultades de aprendizaje. Resulta difícil determinar qué trastorna más a un niño pequeño, si las peleas crónicas entre sus padres o una madre que no está disponible, porque se encuentra fuera del hogar ya sea física o psíquicamente. Cuando ambos elementos están presentes en un grupo familiar, su efecto en el niño es muy traumático. Harris señala que el porcentaje de niños con dificultades provenientes de

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE Y DINAMICA FAMILIAR

hogares en que coexiste la discordia conyugal y una madre que trabaja, combinación que denomina "doble desorganización", es tres veces más elevado que el de casos provenientes de hogares en que no existe esa combinación.

El stress financiero y emocional que soportan las familias de niños con dificultades de aprendizaje es más difícil de soportar que el de las familias con niños normales. Las consultas con neurólogos, psicólogos y otros especialistas son costosas y engorrosas. La ambigüedad y los diagnósticos conflictivos de los médicos incrementan la ansiedad, la culpa y/o el deseo de huida en los padres. Estos alternan entre la indulgencia y el rechazo; entre presentar un frente común por el bien del niño, y odiarse mutuamente por haber concebido un niño imperfecto. Si el niño es hiperactivo y exige mucha atención, los padres pueden necesitar tiempo libre para la pareja; pero puede resultarles imposible encontrar un sustituto dispuesto a enfrentar la conducta difícil del niño. Otras veces, como mecanismo de compensación, uno de los cónyuges puede negarse a salir y a dejar al niño, convirtiéndose así en un prisionero resentido. Finalmente, la furia aumenta y periódicamente hace explosión y así se perpetúa el círculo vicioso del resentimiento, la culpa, la sobreprotección y la indulgencia exagerada, con desdichadas consecuencias para todo el grupo familiar. Un niño que se encuentra preso en este tipo de mecanismo, no tiene energía disponible para la tarea de aprender.

El niño con trastornos de aprendizaje se convierte a veces en el blanco de las burlas de la familia, y asume el rol de chivo expiatorio. (Vogel, Bell, 1968). Es percibido como la fuente de todos los problemas familiares y cumple la función de ayudar a los padres a evadir otros conflictos profundos. También puede convertirse en el vínculo negativo que mantiene unida a la pareja; es el símbolo viviente de una tarea conjunta en la que ambos comparten la culpa y de la que ninguno puede escapar. Aunque el matrimonio sea totalmente insatisfactorio, "debe mantenerse intacto por el bien del niño"; y porque el abandono de uno de los cónyuges en esas circunstancias resulta

JULES C. ABRAMS - FLORENCE W. KASLOW

intolerable. De manera, que, a la carga de aprender, se agrega para el niño la tarea de servir de vínculo entre dos cónyuges desdichados.

El impacto del niño sobre los hermanos

Cuando los padres reciben la noticia de que el niño sufre una disfunción cerebral mínima, o es disléxico o tiene alguna otra dificultad de aprendizaje, generalmente los otros hijos no se encuentran presentes. Con frecuencia los padres les disimulan esta información; en parte por vergüenza, y en parte para protegerlos de la "terrible verdad". Los hermanos y hermanas normales no están incluidos en los planes de los padres para el niño con problemas, y su posible aporte al manejo y a la solidaridad familiar se encuentra excluido. El constante misterio que rodea al problema les produce ansiedad y fantasías crecientes (Silver, 1974). Al desconocer la naturaleza del mal no pueden asumirlo ni enfrentarlo. Sólo cuando los padres se sinceran y asumen una actitud positiva, los otros niños pueden aceptar la "diferencia" de su hermano.

Los hermanos y hermanas de los niños con dificultades de aprendizaje son personajes vitales para él, y viceversa. Logran con él una relación razonablemente espontánea y bastante afectuosa o bien pueden reaccionar con rigidez, agresividad y rechazo. El alivio que sienten al no ser ellos los que sufren el problema puede producirles sentimientos de culpa. Con frecuencia los hermanos reprochan al niño con trastornos la cantidad desproporcionada de atención que recibe de sus padres. Además les produce vergüenza, y evitan traer amigos a la casa o ser vistos en público con el hermano afectado. Los padres suelen intensificar esta animosidad si sostienen, con poco realismo, que los niños no deben pelear, reprimiendo de ese modo la expresión y la resolución normales del conflicto.

Distintos abordajes de tratamiento diferencial. Un continuum

Hemos identificado cierto número de posibles modos de

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE Y DINAMICA FAMILIAR

abordar estos casos; cada uno de ellos puede constituir el "tratamiento electivo", dependiendo de una variedad de factores (Abrams y Kaslow, 1975). Al discutir cada estrategia de tratamiento, analizaremos los motivos para su elección y las ventajas inherentes a su utilización. Si bien hablamos de un continuum, no pretendemos que un abordaje sea mejor que otro; más bien, cada uno puede estar más indicado en diferentes contextos. Con seguridad no hemos agotado todas las posibles modalidades de intervención.

Intervención Educativa

Cuando el niño parece sufrir únicamente de una dificultad de aprendizaje, están indicadas las técnicas de enseñanza especializada aplicadas al área de mayor déficit o dificultad, para proveer una mejor base, aumentar la destreza y desarrollar un mejor funcionamiento del Yo gracias al progreso obtenido. Para optar por esta técnica, el responsable de la evaluación deberá asegurarse de que existe un entorno familiar estable y razonablemente feliz y una relativa ausencia de problemas emocionales en el niño.

Terapia del aprendizaje

El efecto de este tipo de intervención se basa en la idea de que la maestra experta puede utilizar numerosas técnicas psicoterapéuticas que complementen sus conocimientos didácticos. Con frecuencia no se presta la suficiente atención a los factores intrapsíquicos e interpersonales que interfieren con la adquisición y la utilización de los conocimientos escolares. Estas interferencias son a menudo similares a los conflictos que el niño ha experimentado en el hogar. Por ejemplo, la misma frustración y la misma hostilidad que experimentan el padre o la madre en su relación con el niño, pueden también ser sentidas por la maestra, y tal como sucede con los padres, ésta

JULES C. ABRAMS - FLORENCE W. KASLOW

asumirá una actitud inflexible que disminuirá su eficacia. La maestra que expresa su hostilidad abiertamente y como castigo o que se esfuerza para enseñar a la vez que siente aguda frustración que no puede expresar, o que siente vergüenza y culpa por su hostilidad, no podrá mantener su rol de apoyo por mucho tiempo. La maestra que se encuentra en situación constante de enfrentar a un niño que despierta su agresividad podrá, realizando un gran esfuerzo, sobreponerse a este sentimiento y enseñar a pesar de él, pero no podrá ser la influencia estabilizadora que el niño requiere.

Hemos llegado a la conclusión de que los maestros con empatía, intuición y experiencia pueden aprender a utilizar estrategias que ayuden al niño con dificultades de aprendizaje a adaptarse más fácilmente al medio escolar. Prosiguiendo en la línea de Waldman (1971), los maestros especializados utilizan una serie de técnicas en cuatro áreas principales: de Prevención, Desactivación, Integrativas y de Mantenimiento de Contacto.

Las *técnicas preventivas* son aquellas que se utilizan para evitar que el entorno escolar contribuya a la desorganización del Yo del niño. Teniendo en cuenta que los niños con trastornos de aprendizaje graves son en general muy sensibles al mundo que los rodea, se centra la atención en todos los medios que pueden utilizarse para que ese mundo sea lo menos frustrante posible.

Las *técnicas de desactivación* se utilizan cuando han fallado las de prevención. La desactivación es una tarea difícil para todos los que se ven involucrados en ella; el niño que requiere un abordaje de este tipo está generalmente desbordado por fuerzas internas sobre las que su Yo tiene escaso o ningún control. La maestra que se enfrenta con este tipo de niño debe resolver sus propios sentimientos y estos problemas interfieren con la eficacia de su manejo del niño y su capacidad para motivarlo.

Las *técnicas integrativas* son las que requieren que el Yo del niño examine críticamente su propio comportamiento para hacerle reconocer las pautas que constantemente lo obstaculizan. La maestra especializada, quizá conjuntamente con el

terapeuta, puede desempeñar un papel importante favoreciendo el "insight" del niño.

Las *técnicas para mantener el contacto* pueden ser utilizadas por todos, pero son especialmente importantes para la maestra que trabaja a diario con el niño. A través de estas técnicas, la maestra capacitada demuestra al niño que lo considera importante. Los contactos informales con el niño durante las horas de clase, una charla ocasional, el relato de una anécdota personal son algunos de los elementos que pueden cobrar importancia. Este tipo de contactos forma la estructura de contención de la relación, dentro de la cual pueden resolverse los momentos difíciles.

Es fundamental señalar que la maestra experta en dificultades de aprendizaje no reemplaza al psicoterapeuta individual. La primera tiene como meta principal impartir al niño conocimientos dentro del contexto de una buena comprensión del niño y sus necesidades.

Psicoterapia individual

Cuando los problemas del niño están muy internalizados y parece aconsejable una reestructuración de la personalidad, la terapia infantil intensiva es el tratamiento más adecuado. Esto es sobre todo cierto cuando no hay nada que indique que los padres debieran estar en tratamiento. Deberá mantenerse contacto ocasional con los padres, oportunidad en que éstos podrán suministrar al terapeuta información referente al niño, y aquel a su vez podrá aconsejarlos sobre las técnicas más adecuadas de manejo del niño. En lo que respecta a la posible colaboración del psicoterapeuta con el experto en trastornos de aprendizaje, uno de los medios de ayudar al niño y al maestro individualmente y en su interacción, consiste en emplear un psicoterapeuta dentro de la estructura escolar. En ese caso el psicoterapeuta advierte muy rápidamente los aspectos que deben ser tratados en el niño que ha perdido el control, para poder así proseguir con la enseñanza. Cualquiera que sea el

problema es fundamental transmitir al niño que sus dificultades han sido percibidas y que serán atendidas activamente. Es importante comprender que las diferentes perspectivas del maestro especializado, que ve en el niño un alumno que se esfuerza por aprender y por competir, y del psicoterapeuta que ve al niño esforzándose por mantener el equilibrio intrapsíquico, forzosamente se superponen y se complementan.

Grupos de orientación para padres

Cuando los padres de un niño con problemas de aprendizaje se llevan bien y funcionan normalmente, no se justifica una terapia formal. Sin embargo, la pareja puede desear compartir la vida del niño en la escuela y puede resultarles útil recibir orientación educativa e interpretativa. Los grupos de orientación para padres constituyen un modo eficaz de ofrecer esta ayuda. Los padres pueden aprender a incorporar las tres R de rutina, regularidad y repetición a la vida diaria de sus hijos; pueden recibir ayuda para romper el ciclo de fracaso —incapacidad-dependencia— martirologio que han estado perpetuando y pueden aprender a "interpretar o decodificar la conducta del niño en términos de los sentimientos emocionales subyacentes que son los detonadores de la conducta" (Adamson, 1972). El grupo provee un foro en que se discuten temas que interesan a todos. Los miembros pueden recibir apoyo y aliento mutuo, y aquellos que logran resolver algunos problemas con éxito pueden compartir su experiencia y agregar sus sugerencias personales a las del terapeuta y del maestro. Las reuniones de grupo se convierten en momentos en que los padres no necesitan disimular sus preocupaciones o pretender que "todo anda bien". Además, sirven para aliviar el sentimiento de soledad ante el propio problema.

Con demasiada frecuencia los grupos de padres son en realidad grupos de madres. Queremos subrayar que es importante tratar de alentar a los padres para que se involucren activamente; el trastorno del niño también les produce angustia

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE Y DINAMICA FAMILIAR

sobre todo cuando llega a la edad escolar y no puede competir con éxito en las actividades escolares, atléticas y/o mecánicas y esto se convierte en fuente de vergüenza para Papá. No deben descuidarse detalles tales como programar los horarios del grupo por la noche.

“Tutoring” parental

En el terreno de la educación especializada, en que los padres han sido considerados con frecuencia como la causa de los problemas de sus hijos, ellos no han sido tratados como colaboradores para el programa educativo del niño. En los últimos tiempos, los educadores consideran con creciente frecuencia que la cooperación de los padres con la escuela es beneficiosa para el niño.

Los que alegan que los padres no deben involucrarse en el proceso terapéutico se basan en dos creencias falsas: porque si bien es cierto que la mayoría de los padres: 1) son responsables por una parte de los problemas de sus hijos, y 2) no tienen “insight” de esos problemas, y hasta pueden en ocasiones desear, por lo menos parcialmente, que el niño no cure, eso no significa que estas fuerzas negativas definan la totalidad de las relaciones padres-hijos, ni tampoco que no pueda confiarse en la mayoría de los padres para ayudar activamente en la terapia de sus hijos. Muchos profesionales sostienen que los padres tienen capacidad de cambio y sugieren que seríamos más eficaces como educadores si intentáramos trabajar en colaboración con ellos para obtener progresos en el niño.

Las tendencias actuales de la investigación demuestran la eficacia de la participación de los padres en muchos aspectos del proceso terapéutico. Esa participación puede concretarse ya sea asistiendo a grupos de discusión acerca del manejo del comportamiento, o ayudando en la enseñanza de niños en edad preescolar, o bien actuando como auxiliares de los maestros en el aula. Muchos tipos de trastornos se benefician con una interacción hogar-escuela. Hasta la fecha, sin embargo, son las

JULES C. ABRAMS - FLORENCE W. KASLOW

técnicas de orientación las que más se han utilizado en programas de colaboración con los padres. Si se reconociera la importancia de la participación parental en la terapia de niños con trastornos de aprendizaje, se podría utilizar a los padres de dos modos: a través de la orientación familiar y como auxiliares terapéuticos que trabajen con los niños con dificultades. Esencialmente, lo que intentamos lograr es que los padres incrementen su capacidad de comprender y enfrentar los problemas de aprendizaje de sus hijos.

Terapia del niño asociada a “tutoring”

Cuando los padres resultan inaccesibles o cuando no necesitan tratamiento, y cuando la instrucción escolar normal necesita ser complementada, el niño puede requerir psicoterapia individual y “tutoring”. Las ventajas de esta combinación incluyen las del párrafo anterior. Además, el “tutor” puede convertirse en otro adulto clave en la vida del niño, actuando como psicopedagogo.

La combinación de estos dos tipos de intervención no es necesariamente el mejor abordaje. La relación del niño con otro adulto-clave, el “tutor” puede diluir la terapia, así como la existencia del terapeuta puede diluir la intensidad y el valor de la relación con el “tutor”, de manera que es esencial proceder a un cuidadoso examen especializado, para determinar si es preferible usar una o ambas técnicas y en qué secuencia.

Terapia de los padres y del niño con distintos terapeutas

Cuando el niño y los padres necesitan ayuda pero requieren un tratamiento y un terapeuta individual, deben ser tratados por profesionales distintos pero que colaboren estrechamente entre sí. Este puede ser el “tratamiento electivo” en aquellos casos en que los padres sientan demasiada hostilidad o estén demasiado perturbados para poder ser tratados conjuntamente

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE Y DINAMICA FAMILIAR

con el niño; cuando la relación entre padres e hijos es demasiado estrecha y los padres necesitan apoyo para no sumergirse totalmente en el niño; cuando el niño sufre una carencia emocional tan grave que es incapaz de compartir el tiempo y la atención del terapeuta, o bien cuando el niño debe ser protegido del aluvión de críticas que recibiría de sus padres. Si alguno de los involucrados es muy desconfiado, no creará en el compromiso de confidencialidad y en ese caso es casi imperativo recurrir a dos terapeutas. Si las sugerencias constructivas del terapeuta en lo que respecta a 1) cómo manejar al niño en el hogar adoptando una rutina estable para reducir su ansiedad y su confusión y para incrementar su confianza; 2) cómo llevar a cabo tareas de desarrollo normal con ecuanimidad para evitar desencadenar una crisis y 3) cómo enfrentar las presiones y los prejuicios de la comunidad; si este tipo de sugerencias, decimos, son interpretadas por los padres como críticas cuando el niño está presente, entonces es aconsejable recurrir a dos terapeutas distintos.

Esta fórmula ofrece una oportunidad para que cada uno pueda elaborar separadamente sus reacciones ante el trastorno de aprendizaje y todos los complejos factores que están asociados con éste, así como comprender los sentimientos mutuos y adoptar una actitud más positiva y comportamientos interactivos. En el transcurso de la terapia, los padres pueden enfrentar las frustraciones, las desilusiones, las heridas y los reproches que emanan de los trastornos del niño y pueden aprender a distinguir entre lo que surge del estado del niño y lo que expresa la discordia conyugal. En caso de evidenciarse esto último, la terapia de pareja puede ser más eficaz que dar a los padres orientación sobre la comprensión y el manejo del comportamiento del niño y sus reacciones ante el mismo.

Terapia concurrente con un mismo terapeuta

Cuando los padres y el niño requieren sesiones separadas pero no están tan inmersos en una lucha por el control o no

JULES C. ABRAMS - FLORENCE W. KASLOW

son tan competitivos que son incapaces de compartir un mismo terapeuta, este abordaje puede ser muy beneficioso. Se elimina el riesgo de dos terapeutas que trabajen contradictoriamente o que los miembros de la familia usen a uno contra el otro. Un terapeuta único puede lograr una perspectiva más clara y más amplia y puede integrar el progreso de sus varios pacientes. Conociéndolos a todos, puede ayudarlos más fácilmente a alterar su rutina diaria para que sea más conveniente para todos y mantener un equilibrio dinámico.

Además de todas las ventajas mencionadas en la opción anterior, esta técnica tiene la virtud de dar a los padres y al niño la sensación de participar en el esfuerzo por mejorar la situación; es un abordaje que los hace "sentirse unidos". Como el terapeuta trata al niño directamente, los padres deducen que entiende lo que ellos deben enfrentar y se muestran más dispuestos a aceptar sus sugerencias acerca de cómo ayudar al niño a alcanzar autosuficiencia o más habilidades.

Terapia conjunta del grupo familiar

El hecho de que las vidas diarias del niño, sus padres y hermanos están estrechamente entrelazadas, hace que las necesidades y los actos de cada uno repercuta e influya en los demás. Este sistema permite al terapeuta una mejor comprensión de la dinámica familiar y de la dinámica intrapsíquica de cada uno de sus componentes (Kaslow, 1973). Cada uno reacciona ante el niño con dificultades de aprendizaje (que en este contexto es el paciente identificado y quizás el chivo expiatorio de la familia) de acuerdo con su propia idiosincracia. Se logra el máximo beneficio terapéutico cuando la familia funciona como una unidad tratando de mejorar una situación que implica el narcisismo de todos sus miembros e influye en sus relaciones con el resto de la familia, los vecinos, amigos y compañeros de trabajo. Casi siempre la presencia de un niño con trastornos de aprendizaje perturba el equilibrio familiar, contribuye a su desorganización y pone a dura prueba sus mecanismos de

adaptación. Bowen aportó el concepto de "Yo grupal indiferenciado" (1965) a la teoría familiar. Quisiéramos proponer un concepto de "Yo familiar" que se refiera a su capacidad de funcionar a un nivel satisfactorio de vida como una unidad. Esta debería ser la meta principal de la terapia de familias con un niño que sufre de dificultades de aprendizaje. Resulta también el abordaje más adecuado para incrementar la capacidad de comprender y enfrentar los acontecimientos que forman parte del ciclo de la vida familiar.

La terapia familiar conjunta (Satir, 1964) crea una atmósfera en que cada miembro puede lograr un mejor conocimiento de sí mismo, de los demás y de su interacción. Al tratar a todos conjuntamente, el terapeuta cuenta con algo así como un laboratorio en que puede obtener una historia familiar con perspectivas multifacéticas y evaluar la real naturaleza de los sentimientos y las interacciones. Friedman (1973) recomienda que durante el proceso de evaluación del niño con problemas, la familia sea entrevistada como una unidad, que sean evaluados su funcionamiento y su dinámica y que se realice un diagnóstico familiar que sirva de base a la enseñanza especial y a la terapia que se pondrán en práctica. Este sistema reduce las distorsiones, ya que lo que ocurre durante las sesiones se convierte en el contenido, en lugar de las percepciones subjetivas relatadas por cada sujeto, a través del filtro de su memoria (Ferber, 1972).

Las sesiones de terapia familiar ofrecen una oportunidad continuada de participar conjuntamente en la solución del problema y para enfrentar las actitudes y comportamientos irritativos de manera honesta, en el "aquí y ahora"; al mismo tiempo permite a los miembros del grupo familiar brindarse mutuo apoyo. Al estar todos involucrados se minimizan las posibilidades de sabotear el progreso. Los miembros pueden reforzar los progresos mutuos ya que están conscientes de los esfuerzos realizados para lograrlos. El terapeuta, por su parte, al abrir los canales de comunicación, ventilar los secretos familiares y promover la sinceridad (Satir, 1964) permite que toda la familia acceda a un modo de vida más gratificante.

Conclusión

Cuando se estudia a un niño con trastornos de aprendizaje graves, siempre se torna evidente que son múltiples los factores que han contribuido a producir y perpetuar sus problemas; intentar tratar a ese niño de manera estática y mecánica representa un total disparate. Por el contrario, debe centrarse constantemente la atención en la interrelación de los factores fisiológicos, psicológicos, sociales y del entorno que interactúan entre sí produciendo el trastorno.

El presente trabajo está centrado en el funcionamiento del Yo del niño en su intento por adaptarse a un entorno que con demasiada frecuencia se ha vuelto opresivo para él. Hemos subrayado que no existe un método único de intervención. La técnica ideal no consiste siempre en un abordaje educativo estrictamente prescriptivo, ni tampoco en un programa de terapia individual o familiar. No existe una panacea. Debemos seguir explorando y evaluando todo nuevo camino o toda combinación de distintas técnicas que puedan cumplir con el objetivo de beneficiar al niño.

Summary

One can not approach a severely learning disabled youngster without being impressed by the manifold factors that have contributed to and sustained his problems: to attempt to deal with such a child in a static, mechanical fashion represents the height of folly. One must instead focus constantly on the dynamic interrelationships of factors —physiological, psychological, social and environmental which interact with one another to produce the handicap.

The focus of this paper has been the ego functioning of the child as he attempts to deal with an environment, which, all too often has become oppressive for him. We have emphasized that there is no one mode of intervention. Neither a strictly prescriptive educational approach nor a program of individual or family therapy is always ideal. No panacea exists. We must continue to explore and evaluate any avenue or combination of techniques which may ultimately be of value to the child.

Bibliografía

- ABRAMS, J. C., Parental Dynamics - Their Role in Learning Disabilities, *The Reading Teacher*, 23, Mayo 8, 1970.
- ABRAMS, J. C. y KASLOW, F. W., *The Learning Disabled Child and His Family: Differential Diagnosis as the Key to Effective Intervention and Treatment*, Paper presented at the Association for Children with Learning Disabilities (ACLD), Annual Conference, New York, Febrero, 1975.
- ADAMSON, W. C., Helping Parents of Children with Learning Disabilities, *Journal of Learning Disabilities*, Junio, Julio, 1972.
- BOWEN, M., Family Psychotherapy with Schizophrenia in the Hospital and in Private Practice. En NAGY y FRAMO (Eds.), *Intensive Family Therapy*, New York: Harper and Row, 1965.
- FERBER, A. MENDELSON, M. y NAPIER, A., *The Book of Family Therapy*, New York, Science House, 1972.
- FRIEDMAN, *Family Roots of School Learning and Behavior Disorders*, Illinois, C. Thomas, 1973.
- HARRIS, I. D., *Emotional Blocks to Learning*, Glencoe, New York, Free Press, 1961.
- KASLOW, F. Family Therapy: Viewpoints and Perspectives, *Clinical Social Work Journal*, 1, 3, 1973, 196-207.
- PEARSON, G. H., *Psychoanalysis and the Education of the Child*, New York: W. W. Norton & Co., 1954.
- SATIR, V., *Conjoint Family Therapy*, California: *Science and Behavior Books*, 1964.
- SILVER, L. B. Emotional and Social Problems of the Family with a Child Who has Developmental Disabilities. En R. E. WEBER (ed.) *Handbook on Learning Disabilities*, New Jersey: Prentice-Hill 1974, 97-130.
- VOGEL, E. y BELL, N., The Emotional Disturbed Child as the Family Scapegoat, en *A Modern Introduction to the Family*, (Ed. Vogel and Bell), New York; Free Press, 1968.
- WALDMAN, M., *Adjunctive Programming for Special Education Teachers*, no editado, 1971.



EXPANDING WORLDS OF FAMILY THERAPY

AAMFT 2ND INTERNATIONAL / 43RD ANNUAL CONFERENCE

October 17-20, 1985
New York

- | | |
|---|--|
| • Live Family Interviews
with the Masters | • Video Festival |
| • Networking Lunches | • Exhibits |
| • Hundreds of Workshops,
Seminars and Institutes | • Presidential
Dinner Dance |

For Conference Information or Applications regarding:

- Advertising in Conference Program
- Exhibiting at Conference
- Video Festival Entries

Write: AAMFT Conference
1717 K Street, N.W., Suite 407
Washington, D.C. 20006

La terapia familiar: una aproximación distinta al alcoholismo

Dr. ARTURO ROIZBLATT S.

Servicio de Psiquiatría del Hospital del Salvador de Valparaíso, Chile.

En 1945 Jellinek (1) resumió en su estudio que el 52% de los alcohólicos tenían ya sea un padre o madre alcohólico, sino ambos.

En 1970 un trabajo de Winokur (2) encontró que de 156 pacientes hombres de un hospital psiquiátrico 29% tenían padre alcohólico, 6% madre alcohólica, 46% hermanos alcohólicos, 5% hermana alcohólica y 31% hijos alcohólicos. En el mismo estudio, de 103 mujeres del mismo hospital psiquiátrico 44% de los padres, 3% de las madres y 50% de los hermanos; 8% de hermanas y 50% de los hijos eran alcohólicos.

En Inglaterra Rathod y Thomson en 1971 (3) hacen un estudio en que de 30 hombres y 30 mujeres tratados en una unidad de alcohólicos, el 50% tenían un padre alcohólico.

Surge entonces la duda si el alcoholismo se transmite por factores genéticos, ambientales o la combinación de ambos.

Goodwin y asociados (4-5), Schuckit (6) en un estudio de

ARTURO ROIZBLATT S.

hijos adoptados de padres biológicos alcohólicos en Dinamarca concluye que la teoría genética provee una explicación convincente al alcoholismo "severo y crónico"; por otro lado Roe y Burks (7) no encontraron un resultado semejante.

Ewing y Fox (8) fueron uno de los primeros en aplicar algunas de las nociones teóricas sobre familia o matrimonios alcohólicos. Ellos propusieron que el matrimonio alcohólico es un "mecanismo homeostático establecido para resistir el cambio a través de períodos largos de tiempo y que la conducta de cada esposo está rígidamente controlada por el otro". Si uno de los esposos intenta alterar el rol de su conducta esperada, el equilibrio se ve amenazado y el otro esposo renueva su esfuerzo para mantener el status que dé la familia.

Clásicamente los estudios de patología en la familia del alcohólico apuntaban hacia las características de la esposa. Ha sido considerada la mártir, la víctima. Se le describe como una personalidad anormal con conflictos de dependencia.

Ella domina el matrimonio ocupando los roles que el marido no asume y después lo castiga por insuficiente (10, 11, 12).

En contraste con lo anterior los primeros trabajos de Jackson (13, 14, 15), enfocan a la familia como unidad ajustándose al alcoholismo de uno de sus miembros.

Ewing y Fox (8) utilizando la teoría general de sistemas y la teoría interaccional sostienen que el factor que perpetúa en forma más importante los patrones de ingesta excesiva de alcohol es la necesidad imperiosa de mantener la homeostasis familiar que se ha desarrollado en la familia. La unidad a estudiar sería entonces el "sistema alcohólico" más que el miembro alcohólico de la familia.

Steinglass y colaboradores (16) presentan un modelo que describe la forma en que la familia -se ve envuelta en una situación en que unos miembros de ella manipulan a los otros y ajustan su conducta para mantener una relación psicopatológica complementaria (basada en las diferencias). La ingesta de alcohol operaría de dos formas:

UNA APROXIMACION DISTINTA AL ALCOHOLISMO

- a) La conducta alcohólica de un miembro sirve como síntoma o expresión de stress creado por conflictos dentro del sistema. Funciona entonces como válvula de escape para ese stress.
- b) La conducta alcohólica puede constituir una parte integral del programa de trabajo dentro del sistema. Podría servir a necesidades inconscientes de los miembros del sistema en áreas como diferenciación de roles o poder. Este modelo ofrecería un puente entre las teorías psicológicas y sociológicas.

Ablon (17) postula la existencia de un paradigma cultural que perpetúa el abuso de alcohol y que se transmite a través de las generaciones.

Steinglass (18) realizó un estudio en familias alcohólicas en un período de 6 meses desarrollando un modelo de historia de vida de la familia alcohólica a través del tiempo. Para construir este modelo se basó en 3 conceptos: a) El sistema alcohólico b) La homeostasis familiar y c) La fase de familia alcohólica.

a) *El sistema alcohólico*: Se ha postulado que en ciertos sistemas interaccionales (siendo la familia uno de ellos) el alcohol se transforma en un mecanismo organizacional en torno al cual se moldea la conducta interaccional, tal es así que se llega a definir a un "sistema alcohólico" (hay que destacar que Steinglass encuentra aplicable este término a familias que se mantienen estructural y económicamente intactas a pesar del alcoholismo).

Se sugiere en este estudio que las familias prácticamente hacen un ciclo entre dos estados, uno asociado con sobriedad y otro con intoxicación.

b) *Homeostasis familiar*: Don Jackson fue el primero en proponer que el concepto fisiológico de homeostasis de Cannon (que describía a mecanismos de retroalimentación como responsables de controlar procesos fisiológicos en el cuerpo), podría ser una metáfora adecuada para describir procesos similares en los sistemas interaccionales de la familia. Se refiere a que la familia

ARTURO ROIZBLATT S.

tiende de alguna forma al balance, a la estabilidad y tiene mecanismos para resistirse a cualquier cambio que modifique ese balance.

Por ejemplo una enfermedad crónica desarrolla patrones estereotipados de conducta los que pasarían a integrar mecanismos homeostáticos que se asociarían a la estabilidad de la familia.

c) *La fase de alcoholismo familiar*: Se postula que el uso cíclico de alcohol tiene una dimensión microscópica diaria y una macroscópica longitudinal. En la dimensión macroscópica hay períodos "secos" y "mojados". Estos dos períodos demarcarían experiencias y patrones de conducta sumamente diferentes, lo que podría llegar a hacer pensar en etapas del ciclo de vida dentro del cual habrían fases de alcoholismo familiar. Habría entonces una fase seca, una fase mojada y una fase transicional de la seca a mojada y viceversa.

Cuando el uso de alcohol y la conducta consecuente se constituyen en el principio de organización central de la vida interaccional, la familia está en la fase "mojada estable". Si la transición de los estados mojado a seco se maneja exitosamente, la familia entra a una fase "estable seca".

Aunque para algunas familias la transición de la fase mojada a seca es un período difícil; la mayoría de las familias caracterizan su etapa media de la vida por períodos que ciclan entre lo "mojado" y lo "seco".

En este modelo, finalmente la familia entra a un período de "resolución tardía", el que sería de 4 tipos: 1. La familia estable-mojada, son familias que a través de los años de ingesta permanecen sin grandes cambios no obstante el alcohol y las consecuencias de éste para la vida familiar. Se mantienen como sistema alcohólico.

Un segunda posibilidad de resolución: La familia estable-seca alcohólica. Ha logrado mantenerse en estado seco por un período largo. Aunque el miembro alcohólico no bebe, la vida de la familia en alto grado continúa organizada en torno al alcohol, por ejemplo participando en centros de abstemios o con conversaciones constantes en torno al tema.

UNA APROXIMACION DISTINTA AL ALCOHOLISMO

Una tercera etapa de resolución: La familia estable-seca no alcohólica que se diferencia del grupo anterior porque ya no se considera un sistema alcohólico. El alcohol se ha eliminado en un sentido físico y emocional. Hay poca preocupación por el alcohol.

Un cuarto tipo es la familia no alcohólica con un bebedor moderado estable (aunque aún es controvertido el hecho que un alcohólico pueda llegar a beber controlado) (19, 20).

Existe un concepto de "identidad familiar" como la imagen que tiene la familia de sí misma y que la diferencian de otras familias. La identidad de la familia trasciende la identidad individual de cada uno de sus miembros y es un amalgamamiento de creencias compartidas por la familia como unidad en relación al pasado, presente y futuro. Este concepto común, ha mantenido unida a la familia.

La familia lucha por mantenerse igual, incluso transgeneracionalmente; trata de mantener los roles que desempeñan sus miembros, los valores, las creencias que comparten, las reglas de cómo deben hacerse las cosas, en esencia, todos los factores que definen a esa familia como un grupo único. El sentido de continuidad de la familia se estimula por el conocimiento de su pasado y por la certeza de que la generación siguiente va a perpetuar la herencia familiar.

Benett y Cols (9) encuentran que los rituales y mitos que usa la familia son en gran parte el vehículo para transmitir la identidad familiar de una generación a otra.

Los rituales que realiza una familia (ejemplo: horas de comida, visitas, uso de horas libres y vacaciones, celebraciones, etc.) transmiten informaciones importantes respecto al comportamiento de ella y es la forma de relacionarse con su pasado entregando reglas, valores y creencias a los hijos y así asegurar su mantención. En ese estudio se propone que aquellas familias en que el alcoholismo se transforma en el principio de organización central para la vida familiar y los rituales se desarrollan alrededor del abuso del alcohol, la recurrencia del alcoholismo en los hijos será significativamente mayor. En las familias en que los problemas que el alcoholismo suscita se mantienen

ARTURO ROIZBLATT S.

separados de los rituales familiares, disminuiría el riesgo de alcoholismo en los hijos.

Respecto a tratamiento

Es importante recordar que la sobriedad y estado alcohólico se distinguen también cualitativamente. Mientras la sobriedad mantiene una estabilidad dinámica y variabilidad, el estado alcohólico implica rigidez, estereotipia.

Se ha considerado el consumo de alcohol no como "mal adaptativo" sino como que produce consecuencias que permite adaptaciones dentro de la interacción familiar que refuerza la conducta de ingestión. De esta hipótesis se consideran dos implicancias para la terapia (16): a) Ver cómo el alcohol cumple una función adaptativa en la familia con problema alcohólico y; b) Cuando se han encontrado las consecuencias adaptativas del beber, la terapia se puede estructurar ayudando a manifestar esa conducta adaptativa durante los períodos de sobriedad y de esa manera aprender conductas alternativas efectivas.

Las fases iniciales incluyen a toda la familia en el procedimiento terapéutico removiendo el alcohol, para posteriormente tratar al sistema familiar sin alcohol.

Aunque algunos autores como Tisminetzky (21) no imponen la abstinencia por considerarlo un enfrentamiento con el sistema y producir desconocimiento de hábitos particulares de ingestión.

Si habitualmente es difícil incluir en terapia a una familia, más aún lo es con familias alcohólicas. Desde el comienzo se considera el alcohol en la homeostasis familiar. El rol del terapeuta en un comienzo será:

- a) Tratar a la familia como unidad.
- b) Reorientar el problema como un asunto familiar.
- c) Aumentar la motivación por el cambio.

Interesa que la familia como tal, tome la responsabilidad del tratamiento y trabaje la resistencia para alterar la homeostasis del sistema. El que el terapeuta evite tomar una posición de confrontación por temor al abandono de la familia ayuda a

UNA APROXIMACION DISTINTA AL ALCOHOLISMO

mantener la situación alcohólica de la familia. Dar a conocer y crear conciencia del alcoholismo como un síntoma de alteración en la interacción de la familia es una forma de entrada a estos patrones interaccionales.

Si dentro de la perspectiva sistémica el alcoholismo no es sólo un síntoma de un individuo o causa de problema, sino parte integral de una familia; el peor error que un terapeuta de familia podría cometer es confundir la abstinencia inicial con el fin de la terapia. Como hemos mencionado, esta primera etapa presenta una alteración en el patrón rígido predecible y estable que la familia alcohólica tiene. La primera fase de abstinencia es de transición y deberá llevarse el problema desde lo individual a la responsabilidad de la familia; lo que es sumamente difícil, ya que se insiste en entregar el problema al individuo ya etiquetado como portador de la enfermedad. Lentamente se tendrá que ir examinando la dinámica familiar llegando por lo menos a reconocer que los esfuerzos por cambiar que los miembros han realizado, han fracasado, sumado a que cada uno contribuirá de alguna manera a la perpetuación del problema.

“Pero si él es el que toma, si él dejara el trago todo cambiaría”, es la frase que habitualmente escuchamos. Si el alcoholismo es un problema para la familia, entonces será la familia en terapia familiar quien deberá darle solución.

Se trata de modificar la lente para mirar el problema, transformando a la abstinencia —condición necesaria pero no suficiente— en una de las variables del tratamiento.

Remover el alcohol del sistema

Una vez que el sistema familiar está en tratamiento la primera meta es llevar a toda la familia a un patrón basado en la abstinencia. Aquí deberán considerarse los factores médicos que sean necesarios. Por otro lado será importante realizar un contrato para conductas específicas (23) siendo importante que en estas conductas se incorpore a todos los miembros de la familia. Si no se produce cambio en el sistema familiar la abstinencia se hará más dificultosa. La reincidencia en esta

ARTURO ROIZBLATT S.

etapa no debe considerarse como un retroceso tan importante, sino que hay que insistir en ella como un síntoma del sistema.

Marión Lazar y Cols. (24) han encontrado que en aquellos casos en que no se logra la abstinencia, hay un mal pronóstico para el cambio en la homeostasis familiar y para la recuperación en particular. En todos los casos en que hay reducción en la cantidad de consumo de alcohol, esta reducción habitualmente va seguida por un aumento de la ingesta al finalizar el tratamiento y sólo se logran mejorías escasas en la relación familiar.

El sistema familiar sin alcohol

Hemos dicho que el alcohol llega a ser el principio central de la organización de la familia. Cuando el alcohol se retira de la familia, el sistema se ve sumido en una crisis, y aquí se comprueba que el uso del alcohol ocultaba los problemas básicos de esta familia. Los individuos de este sistema aparecen emocionalmente distantes, aislados, con necesidad de apoyo emocional y cercanía. Los esposos no están dispuestos a ceder para comenzar a acercarse; afloran disfunciones sexuales; los niños se sienten inseguros para acercarse a los padres; cada uno se siente solo y emocionalmente aislado en la familia. La familia se siente deprimida y desesperanzada sobre su situación, ya que se sienten incapaces por sí mismos para remediar este aislamiento. A esta fase se le ha llamado de “desierto emocional”.

Habitualmente son sistemas cerrados y rígidos que no han incorporado mucho de afuera del sistema ni han proporcionado un medio propicio para el desarrollo de formas flexibles y abiertas de relación.

Tienen un escaso repertorio para relacionarse, incluyendo la expresión afectiva y formas para enfrentar situaciones conflictivas.

Ante la situación descripta, en que por un lado hay un gran esfuerzo por mejorar, enfrentando todas las experiencias habituales de una familia, pero ahora sin alcohol y por otro lado, la desilusión de observar que la abstinencia no sólo no ha

UNA APROXIMACION DISTINTA AL ALCOHOLISMO

solucionado todos los problemas, sino que pone en evidencia otros; se hace manifiesta una crisis. Según observaciones (24) se darían básicamente cuatro tipos de respuestas:

- a) Reintroducen alcohol en el sistema, reestableciendo la homeostasis.
- b) Mantienen la abstinencia, pero la familia se separa. Se culpan unos a otros de sus dificultades y frustraciones. Se culparía al alcohólico de no cambiar "ni siquiera cuando abstemio". La reincidencia se podría interpretar acá como un esfuerzo por salvar la unidad de familia al volver a la conducta pasada, y aunque no puede considerarse beneficiosa, sí puede constituirse en un llamado para continuar el tratamiento.
- c) Se puede enfrentar estos conflictos estableciendo una nueva homeostasis sin alcohol, en que el apoyo externo recae en uno o dos miembros de la familia con escaso cambio de los patrones de interacción familiar y división emocional de la familia. Esto puede darse por ejemplo al participar en forma excesiva de actividades en centros de abstemios.
- d) El cuarto tipo de respuestas y óptimo para la familia es el cambio básico dentro de la homeostasis permitiendo más cercanía, mayor interacción afectiva y un aumento en la satisfacción de las necesidades afectivas, aparte de un aumento en el repertorio para enfrentar conflictos considerando una mayor autonomía de los miembros del sistema. Hemos escuchado "dejar de tomar ¿para qué?". La respuesta: para que..., podría considerarse en el contrato del cual se habló anteriormente.

La conexión entre beber y otros problemas de la familia será muy importante para el desarrollo de la terapia sobre todo porque en la fase inicial va a permitir mantener el foco en otras metas. Por otro lado si la reincidencia ocurre en una fase en que se están tratando estos otros problemas el terapeuta podría interpretar el uso de alcohol como respuesta a la dificultad para cambiar el funcionamiento familiar.

Así como la terapia familiar provee el estímulo para cambiar el sistema familiar, los centros de abstemios proporcionan otra fuente de apoyo y estabilidad para la familia (25).

ARTURO ROIZBLATT S.

Para finalizar, sabiendo el grave problema de salud pública que representa en Chile la enfermedad alcohólica, y teniendo conciencia por otro lado de lo dificultoso de su tratamiento, tenemos que estar atentos a cualquier abordaje terapéutico que nos pueda ser de utilidad.

El segundo informe especial del Congreso de U.S.A. en Alcohol y Salud (26) dijo respecto a la terapia familiar: "Es el avance más notable en el área de la psicoterapia del alcoholismo".

Repito, la terapia de familia sólo nos proporciona una nueva lente para enfocar este problema. En Chile recién se están dando los primeros pasos para su aplicación terapéutica y en la medida que vayamos haciendo nuestra experiencia podremos apreciar su real efectividad en nuestro medio.

Resumen

Se hace una revisión del alcoholismo bajo el enfoque sistémico y la terapia de familia.

Se considera al alcoholismo como un mecanismo usado por la familia para mantener un equilibrio en que cada uno de los componentes favorece la continuidad del alcoholismo. No se habla entonces de "el enfermo alcohólico", sino del "sistema familiar alcohólico". Este concepto teórico se podría unir al tratamiento médico clásico de esta enfermedad.

Se menciona el ciclo de esta enfermedad en la familia y las fases que se siguen en el tratamiento.

Bibliografía

1. JELLINEK E. M.; "Heredity of the Alcoholic"; *Quart J. Stud Alc.*, 105, 1945.
2. WINOKUR G., REICH T., RIMMER J., PITTS, F. N.; "Alcoholism: Diagnosis and Familial Psychiatric Illness in 259 Probanas", *Arch Gen Psychiat*, 23:104, 1970.
3. RATHOD, N. H.; THOMSON, I. G.; "Women Alcoholics, *Quart J. Stud. Alc.*, 32:45, 1971.

UNA APROXIMACION DISTINTA AL ALCOHOLISMO

4. GOODWIN, D. et. al., "Alcohol Problems in Adoptees Raised Apart from Alcoholics Biologic Parents", *Arch. Gen. Psychiat.*, 28: 238, 1973.
5. GOODWIN D. Et. Al.: "Drinking Problems in Adopted and Nonadopted Sons of Alcoholics", *Arch. Gen. Psychiatric*. 31:164, 1974.
6. SCHUCKIT, M.; GOODWIN, D.; WINOKUR, G.; "A Study of Alcoholism in Half-sibling", *Am. J. Psychiat.*, 128:1.132, 1972.
7. ROE, A.; BURKS, B.: "Adult Adjustment of Foster Children of Alcoholic and Psychotic Parentage and the Influence of the Foster Home", *Quart. J. Stud. Alc.*, 5: 378, 1944.
8. EWING, J. A.; FOX, R. E.: "Family Therapy of Alcoholism in Masserman J. H.", Ed., *Current Psychiatric Therapies*, GREENE AND STRATTON, New York, 1968.
9. BENNETT, L. A.; WOLIN, S. J. y NOONAN, D. L.: "Family Identity and Intergenerational Recurrence of Alcoholism". *Alcoholism Journal on Alcoholism and Related Addictions*, Vol. XIII, 100-107, 1977.
10. PRICE, G. M.; "A Study of the Wives of 20 Alcoholic". *Quart J. Stud. Alc.*, 5:620-627, 1945.
11. FUTTERMAN S.; "Personality trends in Wives of Alcoholics"; *J. Psychiat. Soc. Work*, 23:37-41, 1953.
12. MC. DONALD, D.E.; "Mental Disorders in Wives of Alcoholics", *Quart J. Stud. Alc.*, 17:282-287, 1956.
13. JACKSON J. K., "The Adjustment of the Family to the Crisis of Alcoholism", *Quart J. Stud. Alc.*, 15:562-587, 1954.
14. "Alcoholism and the Family". *Ann. Am. Acad. Polit. Soc. Sci.*, 315: 90-110, 1958.
15. "Alcoholism and the Family", en D. J. Pittman, y C. R. Snyder (Eds.) *Society Culture and Drinking Patterns*, New York, Wiley, 1962.
16. STEINGLASS P.; WEINER S. and MENDELSON, J. H.: "A Systems Approach to Alcoholism: A Model and its Clinical Application", *Arch. Gen. Psychiatry*, 24:401.
17. ABLON JOAN. "The Significance of Cultural Patterning of the 'Alcoholic Family'", *Family Process*, 19:128-143, 1980.
18. STEINGLASS, PETER. "A Life History Model of the Alcoholic Family". *Family Process*, 19:3, 211-226, 1980.
19. ARMOUR, D.; POLICH, J. and STAMBUL, H.: *Alcoholism and Treatment*, Santa Mónica, Rand Corporation, 1976.
20. EWING, J. A. and ROUSE, B. A.: "Failure of an Experimental Treatment Program to Inculcate Controlled Drinking in Alcoholism", *Brit. J. Addiction*, 71:123-134, 1976.
21. TISMINETZKY, MARIO y FRANKEL, DANIEL: "Comprensión y trastorno interaccional del alcoholismo. La familia alcohólica", *Terapia Familiar*, 10:187-215, 1982, Ed. ACE, Buenos Aires.

ARTURO ROIZBLATT S.

22. STANTON, M. D.; "Marital Therapy From a Structural Strategic View Point" in: Sholevai, G. P. Ed., *The Handbook of Marriage and Marital Therapy*, New York, Spectrum, 1981.
23. USHER LAZAR, MARION; JAY, J.; GLASS, D.: "Family Therapy as a Treatment Modality for Alcoholism"; *Journal of Studies on Alcohol*, 43:9, 927-938, 1982.
24. STEINGLASS, P.: "Experimenting With Family Treatment Approachs to Alcoholism". 1950-1975, *A Review Fam. Process Basel*, 15:97-123, 1976.
25. DAVIS, D. I.: "Alcoholics Anonymous and Family Therapy". *J. Marital and Fam. Ther.*, 6:75-81, 1980.
26. KELLER, M. (Ed.) 1974: "Trends in Treatment of Alcoholism" in *Second Special Report to the U.S. Congress on Alcohol and Health*, págs. 145-167, Departament of Health, Education and Welfare, Washington, D. C.



LIBRERIA PAIDOS

CENTRAL
DEL LIBRO
PSICOLOGICO

LE OFRECE AL PROFESIONAL TODO SOBRE

-- PSICOTERAPIA	TODAS LAS EDITORIALES
-- PSICOANALISIS	TODAS LAS NOVEDADES
-- PSICOPATOLOGIA	TODOS LOS TEMAS
-- FAMILIA-PAREJA	
-- REVISTAS	
ESPECIALIZADAS	

EN SU LIBRERIA ESPECIALIZADA

Av. LAS HERAS 3741
Local 30

Tel. 801-2860

La función del grupo en la formación del terapeuta familiar¹

Dr. RODOLFO DE BERNART

Profesor del Instituto de Terapia Familiar de Roma y Director del Instituto de Terapia Familiar de Florencia, Italia. Viale Milton 27, 50129 Florencia.

Introducción

Escuelas que difieren mucho por las premisas teóricas y por las técnicas adoptadas concuerdan en que la formación en Terapia Familiar (TF) es más rápida y eficaz si es efectuada en pequeños grupos compuestos por 6-15 operadores (Andolfi-

(1) El material y las ideas de este trabajo son el fruto de una elaboración conjunta hecha en el Instituto de Terapia Familiar de Roma, en donde fui alumno de M. Andolfi, C. Saccu, P. Menghi y A. M. Nicoló y sucesivamente ya docente, enseñé colaborando con C. Angelo, C. Saccu, A. M. Nicoló, R. Piperno, S. Soccorsi y G. Montanari y en el Instituto de Terapia Familiar de Florencia donde enseñé con C. Dobrowolski y K. Giacometti. La elaboración de este trabajo es personal mas está influida por las discusiones informales tenidas, a través de los años, con todos los colaboradores mencionados, en particular Menghi, Saccu y Soccorsi y de la elaboración de una parte del material con A. M. Nicoló por un trabajo empezado por nosotros y jamás terminado.

Traducido por Sandra de Canevaro.

RODOLFO DE BERNART

Menghi, 1978; Berman, 1979; Bodin, 1979; Duhl & Duhl, 1979; Ferber, 1972; Flomenhaft & Carter, 1977; Garfield, 1979; Haley, 1977; La Perriere, 1979; Liddle & Halpin, 1978; O'Hare et al., 1975; Sluzki, 1974; Stanton, 1975; Stier & Goldenberg, 1975; Wertheimer, 1978). Las explicaciones que cada escuela da son naturalmente muy distintas. A mi manera de ver existen tres posiciones fundamentales.

Una primera posición comprende todos aquellos que consideran el grupo sólo como una posibilidad de multiplicar las experiencias personales. Entre estos Bowen (1979) declara desear un crecimiento personal del alumno a través de un largo trabajo para diferenciarse de la familia de origen, otros (Sluzki, 1974; Bodin, 1969; Haley, 1977) consideran hasta contraproducente el crecimiento personal del alumno y utilizan al grupo sólo como ocasión común de aprendizaje de técnicas. Esto parece coherente con las premisas teóricas de estos autores que consideran al terapeuta como agente externo al sistema familiar. El alumno terapeuta, en su formación, tiene entonces que limitarse a aprender un buen número de técnicas útiles a modificar el sistema familiar sin verse atrapado en su interior. Una segunda posición considera importante el crecimiento personal del alumno y admite vincular este crecimiento con la experiencia grupal, pero lo encuadra dentro de la óptica analítica.

Los autores comprendidos en esta categoría sugieren distintos ejercicios para la formación del grupo (Duhl & Duhl, 1979; La Perriere, 1979) o postulan la necesidad de una terapia de grupo separada en la cual el proceso del grupo mismo y los esquemas interaccionales de sus miembros permitan un crecimiento personal y un mayor conocimiento de sí mismo (Berman & Dixon-Murphy, 1979). Estos autores sostienen que la comprensión y la aceptación del propio mundo interno son aún más importantes en terapia familiar que en terapia individual y que un análisis personal individual es menos eficaz que uno grupal para alcanzar este objetivo. Skynner (1976), capta muy eficazmente los límites de esta impostación y subraya cómo las técnicas normalmente empleadas para el análisis de grupo no

brindan un modelo realmente correcto para la formación de terapeutas de familias, ya que se basan en incentivar fantasías transferenciales regresivas en relación a un terapeuta relativamente pasivo. Por lo tanto, para este autor parece necesario un nuevo modelo con el fin de mantener las proyecciones transferenciales entre los miembros y lejos del líder y de desalentar la regresión a través de un líder más activo, más provocador y más involucrado.

La tercera posición, con la cual me identifico y que llamaré del "crecimiento sistémico", reúne aquellos que utilizan análisis e intervenciones sistémicas para la formación en grupo de terapeutas orientados hacia la óptica sistémica. Liddle & Halpin (1978) en su bibliografía sobre training y supervisión, observan que esta área está todavía inexplorada en la literatura. Solamente Siegel & Dulfano (1973) han estudiado un modelo de enseñanza en el cual se da particular atención a los roles que el alumno asume en el grupo de training. Estos autores, en efecto, han notado que en el momento de la formación de un grupo de training, los miembros asumen posiciones funcionales que contribuyen al equilibrio del grupo mismo. Uno o más líderes, un chivo expiatorio y un moderador de la tensión se manifiestan en el grupo que se subdivide a su vez en subgrupos sostenidos por alianzas y coaliciones.

Estas funciones con el tiempo pueden modificarse o ser asumidas por distintas personas, más generalmente permanecen invariadas y ligadas al mismo individuo si no hay intervenciones del trainer sobre los miembros y sobre el grupo. Para Siegel & Dulfano esta intervención es indispensable, tanto que la evaluación del grado de aprendizaje del alumno al terminar el training está hecha también a través de la observación del "progreso" realizado con respecto a las posiciones funcionales adoptadas inicialmente. Justamente a través del trabajo de grupo el alumno comprende cómo la familia es un sistema dinámico. En efecto, en el grupo el alumno tiene que confrontarse desde el comienzo con la ansiedad de la competición con los otros miembros y con el miedo de ser criticado cuando se expone. Si el trainer consigue que todos se expongan en igual medida, la

ansiedad y la consiguiente defensa disminuyen. El miembro individual puede entonces renunciar a defenderse a través del grupo y reivindicar su diferenciación y su unicidad. Es justamente éste el proceso al que deberá tender a continuación en el trabajo terapéutico. Aprender el mutuo respeto y aceptar la diferenciación propia y la de los demás, en el grupo, hace más fácil, según Rosenbaum & Serrano (1979) "enseñarlo" a una familia en terapia.

Sin embargo estos últimos conceptos si bien interesantes, me parecen incompletos desde el momento que no toman en consideración el crecimiento sistémico del trainer y del alumno, como individuos, y de la totalidad del grupo. Mi hipótesis, por lo contrario, es que del encuentro entre trainer y alumnos se constituye un verdadero y propio nuevo sistema que podemos llamar *sistema de formación*, en analogía al *sistema terapéutico* que se forma por el encuentro entre terapeuta y familia. Por esto, me parece necesario que el trainer tenga presente la existencia de este nuevo sistema, tenga conciencia de formar parte de ello, conozca la modalidad de su constitución y reglamentación, para poder estructurar un contexto de aprendizaje eficaz.

El sistema de formación

Trataré de describir en estas líneas algunas de las modalidades de constitución de este sistema y dar a conocer algunos paralelismos existentes entre la constitución de este *sistema de formación* y la constitución del *sistema terapéutico* entre terapeuta y familia. Trataré además de proponer algunas modalidades de intervención a través de las cuales sea posible utilizar este sistema para un aprendizaje más eficaz. Me refiero al modelo de intervención en los sistemas rígidos propuesto por Andolfi, Menghi, Nicoló, Saccu (1978) y por Andolfi, Angelo, Menghi, Nicoló-Corigliano (1982) para la terapia de familias con miembro esquizofrénico y a las primeras presentaciones del modelo de training del Instituto de terapia familiar de Roma (Andolfi, Menghi, 1978; Saccu, 1983).

En el Instituto de terapia familiar de Roma y en el de Florencia, se prefieren en la selección para la formación, grupos

EL GRUPO EN LA FORMACION DEL TERAPEUTA

pre-formados de operadores que trabajen desde tiempo atrás en equipo en una realidad territorial o institucional. Sin embargo aceptan también operadores que se presten aisladamente o juntos a otros dos o tres colegas. En este segundo caso se forman grupos de 10-12 alumnos que frecuentemente provienen de realidades de trabajo profundamente distintas entre sí. Naturalmente, mientras que los primeros tienen ya una historia en común, emociones, ataduras, alianzas, etc., los segundos necesitan de un cierto tiempo para creárseles (alrededor de dos o tres meses según mi experiencia). En este trabajo tomaré en examen sobre todo los grupos del primer tipo pero mis consideraciones serán válidas también para los grupos del segundo tipo una vez que sea creada en ellos una unidad emocional (2).

Puede ser interesante notar, de todas formas, que, si la formación de un grupo "maduro" y en condiciones de aprender activamente necesita algunos meses, la "noitá" de defensa del grupo se crea, por lo contrario, inmediatamente.

Por "noitá"* entiendo, con Spaltro (1969), la fase de pasaje, a nivel de la experiencia del grupo, de la condición individual a la grupal, señalada por el hecho que el lenguaje empieza a expresarse poco a poco en primera persona plural en lugar de singular: "nosotros" en lugar de "yo". He notado que ya en la primera sesión también en los grupos del segundo tipo aparecen las primeras demandas y definiciones formuladas con "nosotros". Es decir, que se crea una cohesión funcional "artificial" que mueve al individuo hacia el grupo y, crea un conformismo, que no puede todavía ser una cultura de grupo,

(2) Los grupos así formados se encuentran con un ritmo quincenal o semanal por 16 horas en el mes y por 10 meses en el año y tienen acceso después de un primer año de pre-training a 3 años de training clínico o institucional al término del cual pueden acceder a grupos de supervisión indirecta y/o directa de su clínica con las familias. Una selección mediante un coloquio individual es efectuada para el acceso al pre-training y una ulterior valuación y selección se hace entre el año de pre-training y el training, y entre este último y la supervisión.

* Neologismo tomado del inglés "weeness" que significa "lo que es propio de nosotros", la "nostridad" (N. de la T.).

RODOLFO DE BERNART

sino sólo una forma de defensa, inicialmente necesaria para el control de los otros y sólo más adelante reforzada por un componente efectivo dado por el "nosotros" y por el "estar juntos" (Spaltro, 1969). En esta fase la presión hacia la conformidad y hostilidad con respecto a aquellos que violan las normas del grupo tienen una influencia importante en el impedir el aprendizaje, tanto que en algunos casos puede parecer que un grupo trabaja bien mientras que en realidad no pasa nada. El poder que el grupo tiene es enorme y puede influenciar y paralizar no solamente a los propios miembros sino también al trainer (Luft, 1973). Por lo tanto será necesario que el trainer sea conciente de estos riesgos y se mueva para superar las resistencias al cambio de manera de consentir una crisis por la cual el individuo llegue, por etapas no necesariamente fáciles, a un "crecimiento personal", sin tener que pensar, en hacer una "terapia" sino solamente ofrecer aquel sostén sin el cual ni el miembro ni el grupo puede llegar al fin prefijado que en este caso es la formación (Devoto & Romaneli, 1978). Andolfi y Menghi (1978) notaron cómo en los grupos del primer tipo (pre-formados) el pedido de formación nace siempre de una incomodidad experimentada por el equipo en su propia actividad. La incomodidad (técnica o política) parece representar el más importante elemento unificador del equipo. Esta incomodidad y estas dificultades de comunicación y de relación indudablemente existen desde tiempo adentro del equipo, pero paradójicamente es justamente la particular situación que se tiene en el momento del pedido de formación que permite a los miembros del grupo adosar a la incompetencia la responsabilidad de la incomodidad. El mandato explícito que el trainer recibe de parte de los miembros del grupo es en efecto el de formarlos en una nueva técnica, de hacerlos competentes y de esa manera eliminar su displacer.

No podría ser de otra manera. No se puede por cierto pedir a un docente cambiar las relaciones preformadas en el interior del grupo haciendo, así, una intervención terapéutica más didáctica. Más, al mismo tiempo, los miembros del grupo no tardan en señalar con su propio comportamiento (por consi-

guiente con un mensaje analógico e implícito) que las dificultades que provocan la incomodidad son otras. No solamente la comunicación y la relación entre los miembros del grupo son difíciles, sino que el equilibrio se puede mantener solamente a través del mantenimiento de la homeostasis. A esto contribuyen de varias maneras los miembros obligados a renunciar a la expresión de su propia persona para asumir funciones útiles, o indispensables para el mantenimiento de la homeostasis.

Lo que cada miembro recibe por esta renuncia a ser "persona" es la posibilidad de no exponerse y de estar siempre cubierto por el grupo. Quien está ocupado en ser "líder", "chivo expiatorio", "moderador", "atenuador de tensión" u otro, no corre, en efecto, el riesgo de ser sí mismo y de estar enjuiciado por lo que es.

Es evidente que cada miembro elige, en el interior del grupo, una función sintónica para la cual ya está predispuesto por su propia historia familiar. Por ejemplo, un alumno que, en su familia, tenga la función de líder, la asumirá muy probablemente también en el grupo y la mantendrá en el sistema de formación, si esto se es necesario (3).

Así como la familia se presenta al terapeuta con el síntoma del paciente designado para encubrir sus dificultades de comunicación, el grupo se presenta, entonces, al trainer con su incompetencia técnica para encubrir las dificultades de relación entre sus miembros. La familia pide al terapeuta que le diga, cómo hacer para cambiar sin modificar nada, o sea, modificar una situación en el interior de aquellas reglas de relación que la han sostenido en el tiempo. Paralelamente el grupo le pide al trainer resolver su displacer sólo a través de la enseñanza de una técnica. En ambos casos la tarea es imposible. Estamos, en efecto, frente a una verdadera y propia provocación llevada por la familia al terapeuta (ayúdanos aunque en verdad no te permitamos ayudarnos) y respectivamente del grupo al trainer (enseñanos a cambiar, enseñándonos la técnica pero sin pedir-

(3) Una posible interpretación grupo-analítica de este fenómeno está dada por los "asuntos de base" (Bion, 1979).

nos cambiar de verdad). Observemos ahora al trainer en su imposible elección: entre el pedido explícito de enseñanza y el implícito de terapia y de cambio hechos contemporáneamente por el grupo. Si acepta el mandato explícito y por lo tanto trata de resolver el problema de la incompetencia, enseñando la técnica, convalida implícitamente algunos presupuestos que le serán un obstáculo más adelante. El primero es que el trainer en el grupo de formación puede aceptar responder el solo pedido explícito sin cuidarse de los pedidos implícitos del grupo. Paralelamente el terapeuta alumno aprendiendo el "modelo" creará poder hacer lo mismo en sus terapias. El segundo, consiguientemente, es que la terapia resulta ser sólo la aplicación de una serie de técnicas, donde este aprendizaje es lo único importante en el training, y con las cuales se puede obtener cualquier cambio sin poner en juego su propia personalidad. El terapeuta se convierte así, a los ojos del alumno en un experto en toda una serie de trucos que aplicará en el momento justo, fríamente, con pericia, sin involucrarse, defendiéndose, por lo contrario, con su rol, de un contacto "demasiado peligroso" con la familia. Por lo contrario, si el trainer decide no aceptar el mensaje y el mandato explícito del grupo pero trabajar sobre el implícito pedido de cambio, se encuentra frente a la dificultad de no haber recibido oficialmente de parte de los miembros del grupo el mandato terapéutico necesario para tal intervención. En el primer caso cada tentativa de enseñanza resultará imposible dado que lo será también la situación en la cual está hecha esta tentativa. Las dificultades de comunicación en el grupo harán imposibles experiencias interaccionales en el interior del contexto de aprendizaje por lo cual los alumnos no podrán exponerse personalmente y analizar el significado sistémico de sus comportamientos.

En el segundo caso, por lo contrario, el riesgo es el deslizamiento de un contexto de aprendizaje a un contexto terapéutico. Por lo tanto, el trainer tendría que hacerse cargo responsablemente de eventuales problemas surgidos entre miembros del grupo, olvidando su mandato de docente. Para salir del

EL GRUPO EN LA FORMACION DEL TERAPEUTA

impasse el trainer no tiene otra alternativa que negar estratégicamente la posibilidad de una formación para los miembros del grupo. Por lo tanto les declarará no poder iniciar un trabajo de formación hasta tanto el grupo no podrá garantizarle saber utilizar sus canales de comunicación para ampliar y desarrollar lo que aprende. De esta manera el trainer no acepta ni el primer mandato ni el segundo, mas devuelve el problema al grupo señalando, mientras tanto, haber comprendido el real motivo de la incomodidad. Al mismo tiempo, estimula el grupo para afrontar y resolver sus propios problemas, ya que esto es la única manera de obtener una formación real. El mensaje implícito es, en efecto, que ningún aprendizaje es posible a través sólo de técnicas, sin una exposición personal.

La intervención del trainer continúa después a través de un constante pedido de definición hecho por los miembros del grupo sobre cada problema que surge en las primeras sesiones de training. La organización del trabajo, los horarios, la división en subgrupos de profundización, la grabación y la transcripción de las sesiones serán objeto de acuerdo entre los miembros a quienes el trainer sólo asistirá para evitar que se aparten de esta confrontación. Cada ensayo de reforzar las funciones de los miembros a expensas de sus "personas" debe impedirse. Es evidente que en esta fase el trainer está realmente ocupado en un papel terapéutico que de todas maneras tiene que negarse. El trainer niega, en efecto, querer o poder hacer una terapia y afirma que ningún contrato de aprendizaje puede todavía hacerse hasta tanto el grupo no pueda garantizarse y garantizarle un contexto en el cual eso sea posible.

En el momento en el cual el grupo y sus miembros empiecen a señalar con sus comportamientos que se ha formado un contexto más idóneo para el aprendizaje, el trainer podrá empezar un trabajo de formación en un sistema distinto al de partida, con reglas de asociación entre los miembros profundamente distintas. En este nuevo sistema, en efecto, la regla de camuflar incomodidades y frustraciones personales para proteger la unidad ficticia del grupo es abiertamente violada por el trainer a través de la negación estratégica del aprendizaje y de

RODOLFO DE BERNART

la terapia. La regla misma es violada una vez más por los miembros del grupo porque es la única manera de obtener las condiciones ofrecidas por el trainer para la formación.

Se crea así en el *sistema de formación* una profunda ligazón emocional entre el trainer y los alumnos que permite iniciar un trabajo también sobre la *persona* del alumno durante la formación.

La modalidad activa a través de la cual se hace este trabajo es la *provocación*.

La provocación

El significado de la palabra "provocación" es: "llamar afuera, excitar, empujar" y con esta palabra se define un acto que induce una persona hacia sentimientos intensos, en general de cólera, que se pueden manifestar con comportamientos agresivos y/o violentos. La provocación entonces, es una comunicación en donde las finalidades no son explícitas (Piperno, 1979), su objetivo es empujar una persona a una reacción, en general incontrolada, que de todas maneras no se presenta como autónoma sino como una respuesta a la acción que la ha provocado (Nicoló, 1981). En el continuar el trabajo con el grupo, el trainer se encontrará muchas veces frente a nuevas tentativas de reafirmar las funciones de los individuos a expensas de sus personas. Para favorecer la diferenciación personal es necesario por lo tanto que el trainer ataque la función de cada miembro y la homeostasis del grupo a través de la provocación, creando al mismo tiempo una profunda ligazón emocional con los miembros y con el grupo a través de la formación de un sistema que empieza a tener su propia historia. Del otro lado, si se acepta considerar como provocatorio el mensaje que la familia envía al terapeuta así como el grupo al trainer, en su encuentro, entonces, se puede imaginar una respuesta que sea una contraprovocación directa hacia el sistema. En terapia ella consiste (Andolfi et.al., 1978; Nicoló, 1981) en el amplificar de manera contraprovocatoria el mensaje que la familia nos envía (y que representa la valencia homeostática del sistema) con el fin de sostener la parte del yo de cada uno de los miembros de

la familia que propende cada vez más hacia la transformación. Pero esto no puede suceder sin que el terapeuta ponga en juego partes de su propia persona en la contraprovocación terapéutica. En efecto esta no es una maniobra mecanicista ni un insulto al paciente o a su familia, sino un acto comunicativo verbal y analógico que nace de una profunda relación entre terapeuta y familia, en el sistema terapéutico neoformado, y para la cual el terapeuta debe estar convenientemente preparado y emocionalmente disponible. A mi modo de ver esta preparación sólo puede ser alcanzada por el alumno liberándose, a través de la provocación soportada, de la función asumida en el ámbito del grupo de training y aprendiendo así en carne propia (4) cómo diferenciar su propio yo.

La modalidad de ser del grupo se puede, en efecto, definir como "coexistir en el nivel de función". Ya que no es posible coexistir como personas, se acepta por lo tanto vivir en una especie de función recíproca el uno por el otro. Las maneras son muchas: la sobreprotección, el rechazo, la burla, la distracción, etc. (Piperno, 1979). La tendencia a llegar, a través de una propia individuación, a la desimbiotización está sustituida por la necesidad de controlar el estado de autonomía del otro-significativo. En la duda, se vive como amenazador, que éste pueda emanciparse antes. En un sistema abierto, por lo contrario, está consentido a los miembros una honesta expresión de sí mismo, las diferencias están consideradas una cosa natural, el individuo puede decir lo que siente y piensa para garantizarse el propio crecimiento personal, sin por esto poner

(4) Según Whitaker (1961) "...los psicoterapeutas son testarudos como mulas, y dicen que las mulas son alumnas difíciles. En una ciudad, un tipo decidió aprender la tarea de campesino y se compró una mula, pero no podía sacarla del patio. Así que llamó en su ayuda al viejo vecino y éste empezó a pegar tranquilamente a la mula en las costillas y cabeza con un grueso bastón... El tipo de la ciudad protestó diciendo que este método era cruel (palabra cuanto más pertinente en esta discusión) y el viejo campesino contestó: 'Mire... si quiere enseñar algo a una mula, cualquier cosa, antes tiene que llamar su atención'. El problema es entonces cómo obtener la atención del alumno terapeuta..."

en peligro a los otros miembros del sistema ni a sí mismo (Satir, 1973). Para favorecer la diferenciación personal de los miembros del grupo es por lo tanto necesario que el trainer ataque la función de cada miembro individual y la homeostasis del grupo a través de la provocación. Esta puede ser llevada a cabo directamente por el trainer o por otro miembro del grupo sobre pedido del trainer; puede ser hecha a través del canal verbal y el no verbal, explícitamente y directamente o metafóricamente (Andolfi et al., 1982) y también a través del uso de técnicas usadas en terapia familiar en manera distinta; como por ejemplo la escultura del grupo de training (Satir, 1973; Andolfi, 1977); o el objeto metafórico (Andolfi et al., 1983), o los audiovisuales (5). Aclarada la función de un miembro del grupo, el trainer puede, por ejemplo, pedir a otro miembro que ataque esta función provocándola. Al mismo tiempo el trainer debe, sin embargo, negar la función terapéutica de lo que está sucediendo, declarando que la función es la de aprender qué es la provocación. Mientras tanto el miembro encargado de actuar la provocación pronto se dará cuenta cómo es imposible para él provocar la función del colega sin renunciar a su vez a su propia función. Se realiza así un marco paradójal en dos niveles: el primer nivel de la provocación, porque es imposible provocar la función de los otros manteniendo la propia, por lo cual es imposible simular cambiar con el fin de aprendizaje, sin cambiar en la realidad; en un segundo nivel porque el trainer hace justamente lo que niega hacer, o sea hace terapia (obtiene un cambio entre los alumnos) justo cuando la niega, y a través de esta terapia negada obtiene la formación de los alumnos.

De esta manera la ligazón emocional que se va creando gradualmente, permite la constitución de un setting coherente y consistente que "conteniendo" al sistema de formación permite su "crecimiento" paralelo e indivisible de aquella de los individuos que lo componen. En el ámbito de esta estructura

(5) Pienso ampliar este argumento en: de Bernart R., "El uso de los audiovisuales en la formación del terapeuta familiar". En preparación para Terapia Familiar.

EL GRUPO EN LA FORMACION DEL TERAPEUTA

continente, coherente y continua en el tiempo, los alumnos pueden, en efecto, traer sus propias necesidades e inseguridades. Dado que el setting mismo es terapéutico en cuanto "contenedor", el trainer podrá seguir negando la respuesta a estas demandas y podrá derivar esta tarea al grupo o mejor al *sistema de formación*, que ahora está en condiciones de elaborar la solución activamente. La presencia del trainer en esta fase es importante sólo porque permite, a través del sostén de este "setting", el uso del grupo para dar vida a una experiencia emocional de los alumnos y porque su lectura de la situación puede "modificar atributos y características individuales, definiéndolas y haciéndolas vivir como funciones en el interior de una relación y no como propiedades intrínsecas" (Saccu, 1983, p. 80).

Los miembros del grupo, cuando objetivamente están confrontados con datos que se relacionan con su comportamiento y sus efectos, y cuando participan de manera no defensiva en una metacomunicación sobre éstos, pueden completar de manera muy significativa su formación a través del conocimiento del sí mismo, de las actitudes de respuesta de los otros con respecto a ellos y del comportamiento del grupo (Mucchielli, 1970). Todo esto está permitido desde que se instauran en el grupo nuevas modalidades relacionales similares a aquellas presentes en la familia "sana". Estas modalidades, o "funciones comunicativas" son reglas de asociación peculiares de una cierta relación, en un determinado momento, y podrán variar en el tiempo con el variar de las necesidades de cada miembro o del grupo en su totalidad. Y es justamente esta variación de modalidades relacionales que permite a cada uno experimentar partes de sí (funciones nuevas) que serán el espejo del grado de diferenciación adquirido en el interior del sistema (Andolfi, et al., 1982). Y, por otra parte sólo el grupo permite, en cuanto sistema interaccional, hacer aquella experiencia de canje y de confrontación que lleva a cada uno a construir su propia imagen en base al reflejo que los otros dan de él (Pines, 1983). El grupo es el instrumento y el espacio para que suceda una experimentación de la posibilidad de puntos de vista distintos y

RODOLFO DE BERNART

por lo tanto de la relatividad de sus propias convicciones (Pines, 1983 b).

A través de este canje continuo y recíproco los componentes de un sistema adquieren progresivamente una imagen de sí y de los otros, y de sí con respecto a los otros, y definen siempre más claramente un confín entre sí y los otros. Esta modalidad de ser en el grupo es llamada por Andolfi et al., (1982), "coexistir en el nivel de persona" porque es como si el espacio personal de cada uno quedara libre para convivir con el de los otros, en lugar de existir sólo en función de los otros. De la capacidad de identificar un espacio propio nace la posibilidad de encontrarse con el otro en un "espacio interaccional", con un intercambio real de experiencias que cada uno transfiere y elabora sucesivamente en su propio espacio personal (Andolfi et al., 1982). Podemos concluir con Saccu (1983) que el trainer ha puesto en marcha un proceso que no tiene un término preestablecido porque se sobrepone al del crecimiento personal de cada individuo y tendrá entonces tiempos y espacios de elaboración individual. El terapeuta aprendió, de todas formas, que no es suficiente proveerse de un bagaje de técnicas, sino que es necesario utilizar cada parte de sí mismo, tanto en la formación como en la terapia porque esta última no se limita a ser un encuentro artificial entre esquemas definidos y previsibles, sino que, por el contrario, se transforme en un encuentro humano, inicio de un proceso de crecimiento tanto para la familia como para el terapeuta.

Resumen

Después de una breve reseña de la literatura sobre el uso del grupo en la formación del terapeuta familiar, el autor define la existencia de tres posiciones distintas y se identifica en la tercera. La formación del terapeuta no es una simple adquisición de técnicas, sino que está ligada a un crecimiento personal, al cual el hecho de estar en grupo, como continente de las emociones y laboratorio de la experiencias, puede dar un empujón decisivo.

El autor postula la existencia de un *sistema de formación* que nace

EL GRUPO EN LA FORMACION DEL TERAPEUTA

del encuentro entre trainer y alumnos, paralelo al *sistema terapéutico* que nace del encuentro entre terapeuta y familia y hace algunas consideraciones sobre su constitución, sus reglas, y sobre su uso en la formación de los terapeutas familiares.

Summary

After a brief review of the literature on the use of the group in Family Therapy Training, the author defines three different positions and includes himself in the third one. Training Family Therapists is not only teaching techniques, but requires the Therapists' personal growth. The group of peers is very useful and important in providing a holding of the emotions and a workshop for the elaboration of experiences.

The author suggests the existence of a *Training System* built in the meeting of trainer and trainees, similar to the *Therapeutic System* built in the meeting between therapist and family (or patient).

The building of this system, its rules and its use in training-process are examined.

Bibliografía

- ANDOLFI M., MENGHI P., NICOLÒ A. M. y SACCU C., "L'interazione nei sistemi rigidi: un modello di intervento nella famiglia con paziente schizofrenico", *Terapia Familiare*, 3, 1978; 35-66.
- ANDOLFI M., *La terapia con la famiglia*, Astrolabio, Roma, 1977.
- ANDOLFI M. y MENGHI P., "Un modello di training in terapia familiare", *Terapia Familiare*, 4, 1978; 77-98.
- ANDOLFI M., ANGELO C., MENGHI P. y NICOLÒ CORIGLIANO A. M., *La famiglia rigida*, Feltrinelli, Milano, 1982.
- ANZIEU D., BEJARANO A., KAES R., MISSENARD A. y PONTALIS J. B., *Il lavoro psicoanalitico nei gruppi*, Armando, Roma, 1975.
- BATTEGAY R., *Psicoterapia di gruppo e psichiatria clinica*, Giunti-Barbèra, Firenze, 1967.
- BERMAN E., DIXON-MURPHY T. F., "Training in marital and family therapy at free-standing institutes", *Journal of marital and family therapy*, 5/3, 1979; 29-42.
- BION W. R., *Esperienze nei gruppi*, Armando, Roma, 1979.
- BODIN A., "Family Training Literature a Brief Guide", *Family Process*, 8, 1969; 272-279.

RODOLFO DE BERNART

- BOWEN M., *Dalla famiglia all'individuo*, a cargo de Andolfi M. y de Nichilo M., Astrolabio, Roma, 1979.
- DEVOTO A. y ROMANELLI P., *Gruppi e crescita personale*, La Nuova Italia, Firenze, 1978.
- DUHL F. J. y DUHL B. S., "'Structured spontaneity' the thoughtful art of integrative family therapy at Boston Family Institute", *Journal of marital and family therapy*, 5/3, 1979; 59-76.
- FARRELY F. y BRANSDMA J., *Provocative therapy*, Celestial arts, Millbrae, Usa, 1974.
- FERBER A., "Teachers and learners - Introduction", en Ferber A., Mendelsohn M. y Napier A., *The book of family therapy*, Houghton Mifflin, Boston, 1972.
- FERBER A. y MENDELSON M., "Training for family therapy", *Family Process*, 8/1, 1969; 25-32.
- FLOMENHAFT K. y CARTER R. E., "Family therapy training: program and out-come", *Family process*, 16/2, 1977; 211-218.
- GARFIELD R., "The Hahnemann master of family therapy program", *Journal of marital and family therapy*, 5/3, 1979; 15-22.
- GIACOMETTI K., "Terapia familiare: un modello di sviluppo ed una proposta di classificazione", *Terapia Familiare*, 6, 1979; 7-32.
- GOLDENBERG I., STIER S. y PRESTON T., "The use of a multiple family marathon as a teaching device", *Journal of marital and family therapy*, 1, 1975; 343-349.
- HALEY J., "Problems in training therapists", en Haley J., *Problem solving therapy*, Jossey Bass, San Francisco, Usa, 1977.
- KNISKERN D. P. y GURMAN A. S., "Research on training in marriage and family therapy: status, issues and directions", *Journal of marital and family therapy*, 5/3, 1979, 83-94, traducción al italiano: "La ricerca sul training in terapia familiare e di coppia", *Terapia Familiare*, 4, 1978; 61-76.
- LA PERRIERE K., "Family therapy training at the Ackerman Institute: thoughts of form and substance", *Journal of marital and family therapy*, 5/3, 1979; 53-58.
- LIDDLE A. H., "On teaching a contextual or systemic therapy: training content goals and methods", *The American journal of family therapy*, 8/1, 1980; 58-69.
- LIDDLE A. H. y HALPIN R. J., "Family therapy training and supervision: a comparative review", *Journal of marital and family therapy*, 4/4, 1978; 77-98.
- LIDDLE A. H. y SABA G. W., "Teaching family therapy at the introductory level: a conceptual model emphasizing a pattern which connects training and therapy", *Journal of marital and family therapy*, 8/1, 1982; 63-72.

EL GRUPO EN LA FORMACION DEL TERAPEUTA

- LUFT J., *Introduzione alla dinamica di gruppo*, La Nuova Italia, Firenze, 1973.
- MUCCHIELLI R., *La dinamica di gruppo*, Editrice Elle Di Ci, Torino-Leumann, 1970.
- NAPIER A. y WHITAKER C., "Teaching open communication and commitment to intimacy", en Harks S. J. y Berg S. (eds.), *Doing the unknown*, Dell, New York, Usa, 1973.
- NAPOLITANI D., "Gruppi interni e modelli relazionali nel reale, nell'immaginario e nel simbolico", *Psicologia clinica*, 1/2, 1982; 200-258.
- NICOLO A. M., "La provocation en tant que réponse thérapeutique", *Thérapie Familiale*, 2/4, 1981; 293-300.
- O'HARE C., HEINRICH A. G., KIRSCHNER N. W., OBERSTONE A. V. y RITZ H. G., "Group training in family therapy: the student's perspective", *Journal of marital and family counseling*, 1, 1975; 157-162.
- PINES M., "La specularità nella terapia di gruppo", en *Quaderni di psicoterapia di gruppo*, 1, *Individuo e gruppo*, 1983; 75-107.
- PINES M., "Fattori terapeutici nella psicoterapia analitica di gruppo", en *Quaderni di psicoterapia di gruppo*, 1, *Individuo e gruppo*, 1983; 145-161.
- PIPERNO R., "La funzione della provocazione nel mantenimento omeostatico dei sistemi rigidi", *Terapia Familiare*, 5, 1979; 39-50.
- RESNIK S., "L'individuo ed il gruppo", *Quaderni di psicoterapia di gruppo*, 1, *Individuo e gruppo*, 1983; 11-58.
- ROSENBAUM I. S. y SERRANO A. C., "A rationale and outline for a training program in family therapy", *Journal of marital and family therapy*, 5/3, 1979; 77-82.
- SACCU C., "La storia di Deutero", *Terapia Familiare*, 13, 1983; 71-81.
- SATIR V., *Psicodinamica e psicoterapia del nucleo familiare*, Armando, Roma, 1973.
- SIEGEL L. y DULFANO C., *Family therapy an overview*, Career directions, 2, 7, Sandoz Pharmaceuticals Inc., 1973.
- SKYNNER A. C. R., *Systems of family and marital psychoterapy*, Brunner Mazel, New York, Usa, 1976.
- SLUZKY C., *Treatment, training and research in family therapy*, trabajo presentado en el N. W. Ackerman Memorial Conference, Cumaná, Venezuela, Febrero 1974.
- SPALTRO E., *Gruppi e cambiamento*, Etas Kompass, Milano, 1969.
- STANTON, M. D., "Family therapy training: academic and internship opportunities for psychologists", *Family Process*, 14, 1975; 433-439.
- STIER S. y GOLDENBERG I., "Training issues in family therapy", *Journal of marital and family counseling*, 1, 1975; 63-88.
- TUCKER B. y LIDDLE H. A., "Intra and interpersonal process in the

RODOLFO DE BERNART

- group supervision of beginning family therapists", *Family Therapy*, 5, 1978; 13-28.
- WERTHEIMER D., "Family training in Israel", *Journal of marital and family counseling*, 4/2, 1978; 83-90.
- WHITAKER C., "The on-going training of the psychotherapist", en Dellis N. D. y Stones H. K. (eds.), *The training of the psychotherapist*, Baton Rouge LA, Usa, Louisiana State University Press, 1961.
- WHITAKER C. y NAPIER A. Y., *Problems of beginning family therapist, comunicazione personale*, 1979.

PAIDOS

- S. Minuchin y H. Ch. Fishman: **Técnicas de terapia familiar**
 A. Kornblit: **Semiótica de las relaciones familiares**
 M. Andolfi: **Terapia familiar**
 M. Andolfi e I. Zwerling: **Dimensiones de la terapia familiar**

OTRAS NOVEDADES

- D. McQuail: **Introducción a la teoría de la comunicación de masas**
 M. Mahler: **Estudios 1. Psicosis infantiles y otros trabajos**
 M. Mahler: **Estudios 2. Separación-individuación**
 B. Osman: **Nadie con quien jugar**
 M. Mannoni: **De un imposible al Otro**
 M. Safouan: **El inconsciente y su escritura**

DIALOGOS

Diálogo entre el Dr. Gianfranco Cecchin y el Dr. Alfredo Canevaro

Alfredo Canevaro: Gianfranco, querría saber qué piensas acerca de los desarrollos teóricos recientes, cómo pueden enriquecer la terapia familiar y además, cómo ves el movimiento de la terapia familiar y su futuro.

Gianfranco Cecchin: Los terapeutas familiares son sustancialmente clínicos que trabajan con el material humano que ven, con los sistemas humanos que ven. Primero hacen el trabajo y luego tratan de teorizar sobre lo que hicieron. Al menos así fueron nuestros comienzos en Milán con Selvini-Palazzoli, Prata y Boscolo. Primero hacíamos nuestros experimentos, nuestras intervenciones y después tratábamos de explicar qué habíamos hecho. Por lo tanto es una tradición en terapia familiar: primero accionar y después tratar de explicar, de teorizar, y en cierto sentido tratar de mejorar nuestras intervenciones. Distinguir entre aquellas eficaces y las menos eficaces. Por lo tanto esta búsqueda de teoría ha existido siempre dentro del movimiento de la terapia familiar.

Alguien podría pensar que hay una crisis en la terapia

GIANFRANCO CECCHIN - ALFREDO CANEVARO

familiar dada la búsqueda de ciertos personajes teóricos que contribuyan. Yo no pienso para nada en esto ya que hay una continua dialéctica entre práctica y teoría, teoría y práctica. Es casi imposible tener una teoría y después aplicarla con éxito. Se debe trabajar de consuno.

A. C.: ¿Dices esto por la contribución de gente como Prigogyne, Maturana y Von Foerster, por ejemplo?

G. C.: Así es, los terapeutas familiares continúan organizando reuniones e invitando a estos célebres personajes, ya que son éstos quienes hablan de la así llamada "segunda cibernética". En Palo Alto, y en los primeros tiempos se trabajaba con la llamada primera cibernética, o sea, se observaba el sistema, cómo estaba organizado, cómo se autodeterminaba. Existía el concepto de homeostasis y transformación, pero no se teorizaba sobre la presencia del observador en el sistema. El sistema era un objeto para examinar y para teorizar. Al menos así lo hicimos nosotros en los tiempos de Paradoja y Contraparadoja. Luego de este período, ha habido un movimiento hacia la segunda cibernética, o sea una intervención en el observador, o sea el observador en el sistema. No se trata ya de observar sólo el sistema familiar, sino el sistema más el terapeuta. Prácticamente este concepto es la "cocreación de la realidad". Familia y terapeuta crean juntos una nueva realidad. Ahora bien, saber cómo llegan a crearla, ése es un gran problema. De ahí la contribución teórica de Maturana con su concepto de que es el ser humano, en cierto sentido, quién organiza su "realidad". No es la realidad a descubrir sino que es el observador quien crea la realidad que está descubriendo. Este es un concepto muy útil, así como las ideas de Von Foerster, con su "constructivismo radical" que puede ser útil como expresión de lo que hacemos. Estos movimientos nos dan ideas, pero no explicaciones completas. Sólo algunas ideas sobre aquello que está sucediendo. Por lo tanto esta conversación continúa entre clínicos y teóricos, parece estimulante y útil, sobre todo en este período, para salir del concepto del sistema como una cosa mecánica.

A. C.: ¿Cómo es esto de la llamada crisis de la terapia familiar, en qué sentido?

DIALOGO

G. C.: A veces se habla de esto porque la terapia familiar no ha sido exitosa en influir sobre los grandes sistemas y no ha influido en la psiquiatría clásica. Hay muchos grupos, como por ejemplo el de Andolfi en Roma, que ahora comienzan a "redescubrir" al individuo. Algunos dicen que la terapia familiar no funciona, que no tiene futuro. El mismo Minuchin en su último artículo de Networker habla de que la terapia familiar ha crecido mucho, pero que no ha tenido éxito en producir efectos. Existe esta sensación de crisis y algunos dicen que estas investigaciones de los teóricos forma parte de esta crisis.

A. C.: Y tú no piensas esto...

G. C.: No. Pienso que la terapia familiar es el único modo de ver cómo funcionan los sistemas humanos. La familia es uno de los sistemas naturales más frecuentes, digamos, que se puede examinar para estudiar los sistemas. Si no hemos tenido éxito en influenciar los sistemas más amplios, esto depende de nosotros que no hemos encontrado las palabras justas, las teorías justas. O sea, para mí esta búsqueda de teorización es muy positiva, aún porque como veíamos antes, la terapia familiar no es una religión, donde hay una escuela fija, donde hay un padre, Freud, al cual todos tienen que referirse. La terapia familiar es abierta, es un movimiento con posibilidades muy vastas.

A. C.: A veces pienso que no se ha tenido éxito en influir sistemas más amplios por intereses creados.

G. C.: Así es.

A. C.: ... lo que no quiere decir que una política sanitaria no deba basarse en el sistema familiar más que en el individuo. Este es un gran problema en todas partes. Aquí hace años que estamos tratando de hacerlo pero no es fácil, ya que a veces la política sanitaria depende de grupos burocráticos...

G. C.: Una organización vasta no puede hacer otra cosa que pensar de un modo lineal. Es difícil que una organización, un sistema fuerte y potente pueda ser circular. Es casi una contradicción. Cuando se organiza un sistema sanitario, no se puede hacer otra cosa que hacerlo de una forma tradicional, lineal, con explicaciones no circulares. Minuchin hablaba en

GIANFRANCO CECCHIN - ALFREDO CANEVARO

este artículo de que la terapia familiar no había sido exitosa en cambiar los grandes sistemas.

A. C.: ¿Tú no crees eso, no?

G. C.: No. Puede ser que aún no haya tenido efecto, pero de ninguna manera es para descartarla por ineficaz.

A. C.: ... Porque no hay que alejarse nunca del hecho clínico como referencia de base.

G. C.: Así es.

A. C.: Sería un error si entráramos en una fase de esperanza frustrada, de desilusión. Personalmente creo que el hecho clínico es irrefutable.

G. C.: Estoy completamente convencido de esto. Sin embargo no encuentro raro que las instituciones permanezcan lineales, tradicionales, porque para sobrevivir deben tener estas reglas.

A. C.: ¿Tú crees que el futuro de la terapia familiar irá hacia una retracción o hacia un desarrollo mayor?

G. C.: No, por ejemplo, con el training que hacemos en Milán, nosotros enseñamos a los alumnos a pensar de una manera sistémica, aunque trabajan luego en instituciones tradicionales, la institución puede ser lineal, pero el individuo no. Pueden tener un pensamiento sistémico y esto es una paradoja de la cual se pueden extraer efectos positivos. Mantener la institución como es pero utilizarla de un modo clínico y útil. Lo que tratamos de enseñar a los alumnos es no de "vender" la terapia familiar como la única terapia, sino enseñar a pensar de manera sistémica, diversa, aún aceptando las instituciones dentro de las que están. Se puede tener pensamientos sistémicos aún haciendo terapia individual o utilizando la internación de modo clínicamente válido. O sea, la terapia familiar no es idéntica a terapia sistémica.

A. C.: ¿O sea que tú piensas que la terapia sistémica tendrá un desarrollo mayor que la terapia familiar?

G. C.: Así es. La terapia familiar no es necesariamente la única intervención, aún porque el establishment no la acepta como una forma general de terapia. La terapia familiar es una de las tantas formas de terapia.

A. C.: ¿Tú crees que esto tenga que ver con la noción de familia, en el sentido sociocultural?

G. C.: Sí, porque la familia es la estructura de base social, pero no necesariamente es la causa de los problemas. Cuando uno se enfrenta con un problema tiene que ver cuál es el sistema en torno a dicho problema que le da sentido. A veces es la familia, a veces la escuela, o el trabajo y también la política social y no siempre la familia.

A. C.: Entiendo, pero ¿no piensas que la estructura íntima del individuo está formada por un entrelazamiento relacional significativo a partir de la familia?

G. C.: Sí. Uno nace en una familia, pero también se pone en contacto con otros sistemas desde el inicio de su vida.

A. C.: Lógico, pero como contexto inteligible para entender los problemas. O sea, dependiendo de las experiencias adquiridas dentro del contexto familiar, ¿no piensas que éste sea significativo al reproducir conductas patológicas en otros sistemas?

G. C.: Estudiando el sistema familiar se llegan a captar ciertos problemas que se pueden reproducir en otros sistemas. Estos patterns aprendidos de 0 a 6 años, según el psicoanálisis quedan fijos y se reproducen por la transferencia en otros sistemas humanos. La persona está determinada históricamente. En cambio para la teoría sistémica, el sistema en el que uno vive es siempre algo nuevo y no una repetición del pasado, salvo en aquellos sistemas rígidos que permanecen "congelados" sin cambios y sólo repitiendo. Es interesante comentar aquí la aplicación de las teorías de Maturana. Él dice que la organización de un sistema es constante, nosotros la creamos, pero la estructura está en continuo cambio. El determinismo de Maturana no es histórico sino estructural. Es la estructura la que determina lo que sucede dentro de un sistema. Lo que yo veo depende de mi estructura que está en continuo cambio. Otra cosa muy importante que he captado de Maturana es que ningún sistema puede determinar a otro sistema, sólo perturbarlo. Esto es muy importante en la terapia, porque nosotros no podemos empujar a una familia a ver las cosas como las

vemos nosotros. Podemos sólo crear perturbaciones que la estructura interna de la familia, su organización interna que nosotros no llegamos jamás a conocer completamente, es la que determina cómo usará las intervenciones. Eso va perfectamente de acuerdo con el abordaje a la familia de la escuela milanesa. Nosotros ideamos las intervenciones, accionamos y luego esperamos a ver qué sucede, sin influenciar jamás a la familia en una dirección determinada.

A. C.: Antes de pasar a hablar sobre el training, te querría hacer una última pregunta. ¿Cómo entienden ustedes la influencia de la familia de origen tanto sea en la patología actual como en la terapia?

G. C.: Esto es muy interesante. La familia de origen representa un poco la historia de la familia ¿no? Una familia nueva, se va desprendiendo de la de origen. Si no tiene éxito, como en las familias rígidas, queda ligada a la vieja familia, y el sistema significativo es la vieja familia, y entonces hay que llevarla a terapia.

A. C.: ¿Y la influencia actual de la familia de origen, aún cuando sea oculta?

G. C.: Cuando un sistema está mal, y no puede organizarse en un sistema normal, sale a menudo a relucir la historia. Por ejemplo, estoy triste porque mi madre... siempre me trató mal, etc., o mi padre... aún cuando no se vean los parientes se traen los viejos fantasmas.

A. C.: ¿No piensas que a veces los individuos no pueden desarrollarse, o las parejas consolidarse porque todavía no ha habido una confirmación desde las familias de origen, y entonces la influencia es actual?

G. C.: Claro, la mayor parte de los problemas vienen de ahí, porque un niño se confunde cuando su padre todavía no terminó de ser hijo o su madre de ser hija. Nosotros vemos muy frecuentemente con las familias, que existen los llamados "matrimonios escondidos". Tratamos de investigar a través del paciente cuál es el vínculo más importante. Por ejemplo, ¿cuando estás mal "en quién piensas"? , "¿a quién llamas? ". O ¿si su madre ahora muriera, su matrimonio mejoraría o empeoraría?

raría? Se descubren cosas fascinantes, como por ejemplo que una mujer se casa, no realmente enamorada de su marido, sino de la madre de su marido, buscando una madre para sí.

A. C.: En Estados Unidos trabajan menos con las familias de origen ¿no? Quizás a causa de la distancia y de la movilidad geográfica.

G. C.: Sí, pero los problemas son los mismos. Allá trabajan menos porque la tendencia es a trabajar con el método estructural. Tienden a reconstruir la familia actual y a desprenderse de los viejos fantasmas empujándola en una dirección de autonomía e independencia. La diferencia con nuestra terapia paradójica es que nosotros aceptamos esos vínculos y tratamos de llevarlos a un límite absurdo para que cambien solos.

A. C.: ¿Y los americanos pueden entender esto?

G. C.: Les cuesta mucho porque la idea de ellos es de hacer, construir, hacer las cosas justas, ayudar a las personas a ser autónomas.

A. C.: Es la tradición anglosajona del mito de la individualidad.

G. C.: Esa es una idea cultural que los terapeutas repiten con una visión moral, falta de neutralidad. Con este mito de la autonomía, ellos tienden a ver la influencia de la familia extensa, como una falta de autonomía, y no siempre es así. En los sistemas latinos, en Italia, en Argentina, es más fácil ver la influencia de las familias de origen y no siempre es patológico. Son las familias "Enmeshed".

A. C.: ¿Y cómo hacen para que los alumnos entiendan esto en el training?

G. C.: Primero, les decimos a los alumnos que no pretendemos que ellos devengan necesariamente terapeutas familiares sino que aprendan a pensar sistémicamente para poder aplicarlo en su campo de trabajo. Cuando vemos un problema les preguntamos cuál es el contexto significativo que vuelve comprensible este problema. Tratamos de ampliar el contexto del paciente a sus padres, hermanos, etc. A veces descubrimos que no son los pacientes, sino la escuela. Entonces los alumnos aprenden a distinguir cuál de esos contextos es más importante

para la terapia, o la familia nuclear o la extensa o el contexto social. No partimos de prejuicios.

A. C.: ¿Cuánto tiempo lleva el training?

G. C.: Son tres años. Son 16 ó 17 jornadas por año. Nos vemos cada 15 días y 5 horas por vez. Vemos familias en vivo, hacemos video-tape o familias simuladas y discusiones teóricas o grupos de lectura. Otra cosa que decimos es que la nuestra es una escuela ortodoxa, en cierto sentido rígida. Nosotros le mostramos lo que nosotros hacemos. Si quieren aprender otras escuelas tienen que ir a aprenderlas con otros porque nosotros no las sabemos.

A. C.: ¿Cuáles son los problemas más importantes que encuentras en los alumnos?

G. C.: Es muy difícil que actúen espontáneamente, pues siempre tratan de imitar a los maestros. Es esta paradoja de "sé espontáneo". No lo pueden ser. También les hacemos tener sesiones sin supervisión y después vemos los tapes. Los discursos que hacemos sobre las intervenciones son más bien de tipo intelectual y ellos encuentran más problemas en la relación analógica.

En el primer año hacemos sólo teoría y video-tapes. En el segundo ven familias y en el tercero son ellos quienes conducen la sesión. Tenemos el problema de que no tienen la posibilidad de ver muchas familias.

A. C.: ¿Qué encuentras de semejante o diverso con el training en otras partes del mundo?

G. C.: Que son más eclécticos. Ahora sí, ven más familias, tienen más práctica clínica, pero menos cuidado del detalle como hacemos nosotros que a veces nos ponemos muy obsesivos.

A. C.: En Estados Unidos ustedes son muy requeridos.

G. C.: Sí, y también en Europa. Probablemente porque existe esa idea de que nosotros hacemos una cosa no mezclada con otras y que tratamos de seguir rigidamente a Bateson. Adenás hacemos casi un ritual con eso de la pre-sesión, el trabajo con el equipo y las intervenciones.

Ahora dividimos el grupo en dos subsistemas. Uno se

encarga de la sesión y el otro observa y comenta. Es un ejercicio muy interesante. Trabajamos con esto de los varios niveles de Bateson. El nivel de la familia, de la terapia, el nivel del observador. Cada nivel tiene una formación diversa del otro y el alumno aprende que lo que piensa y hace depende de la posición que tenga en el sistema. Cambia de posición y cambia de idea y esto se ve bien en las simuladas. Otro mensaje que damos es que en sus puestos de trabajo jamás se pongan en posición simétrica o sea, decir: "Ahora nosotros sabemos cómo se hace terapia de familia", sino meterse en una posición complementaria. "Estoy estudiando y experimentando algo diverso en Milán, pero no trataré por el momento de aplicarlo acá porque no sé si vale o no vale".

A. C.: El conocimiento previo que ellos tienen, ¿cuál es?

G. C.: Muchos vienen del psicoanálisis en su mayoría, aunque también psiquiatras organicistas.

A. C.: ¿Y encuentran dificultad de comprensión en estos alumnos?

G. C.: No, porque las ideas sistémicas son sólo ideas, que conexas con otras, se vuelven diversas.

A. C.: Yo encuentro aquí que la influencia del psicoanálisis individual durante el training es a veces uno de los problemas "ocultos" más importantes como resistencia al cambio.

G. C.: Eso lo he visto más en Alemania e Inglaterra que en Italia y esa doble lealtad los confunde. Ultimamente aprendimos a tratar mejor ese problema. No atacamos jamás al psicoanálisis, sino que les decimos que el psicoanálisis tiene un número de hipótesis muy útiles. Lo importante es no creer en estas hipótesis. Más bien utilizarlas como instrumento para pensar.

A. C.: Bien Gianfranco, te agradezco mucho tu gentileza y creo que nuestros lectores sabrán reconocerla.



CENTRO DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA MEDICO
PSICOLOGICA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DRA. TELMA RECA

Directora: Dra. Evelina S. de Costa

Diagnóstico y Tratamiento Psi-
coterapéutico y Psicopedagógico

- * Individual
- * Grupal
- * Familiar
- * Asistencia Integral de Niños
Atípicos

Capacitación

Cursos de Especialización para
Médicos - Psicólogos - Psicope-
dagogos. Seminarios breves. Ini-
ciación y Abordaje al Enfoque
Genético - Dinámico - Profundo

11 de Septiembre 986/88 - (1426) Capital Federal

Tel. 772-1166 - 773-8152

CENTRO DE ESTUDIO DE TERAPIA FAMILIAR C.E.TE.FA. (Rosario)

CICLO 85

— Taller de Profundización en teoría y técnica sistémica.

3 días de trabajo intensivo con: Fidel y Elena Lebensohn.

Los inscriptos tendrán oportunidad de realizar trabajo clínico (observación de familia en vivo y trabajo teórico) (reflexión epistemológica). 8 a 10 de Octubre.

— Jornadas de Actualización.

A. Actualización en transacciones psicóticas y psicopáticas. Coord.: F. Lebensohn. Docentes: Psic. E. Lebensohn, Psic. E. Ragaglia, Dr. Mario Sánchez. 11 y 12 de Octubre.

B. Familia con niños. Coord.: F. y E. Lebensohn. 25 y 26 de Octubre.

— Residencia en Terapia Familiar Sistémica. (9 meses de duración; cupo: 8 inscriptos)

Dirigido a terapeutas que tengan experiencia. Dos reuniones mensuales de 4 horas en donde los residentes tendrán la oportunidad de tratar a familias que C.E.TE.FA. proveerá. Supervisores: Psic. E. Lebensohn y Dr. F. Lebensohn.

Inscripción e Informes: Tucumán 1060, P.B. "A". Tel. 67038

INFORMACIONES

Los días 30, 31 de mayo y 1, 2 de junio de 1985, se realizó en San Juan, el Segundo Congreso y Tercer Encuentro Nacional de Terapia Sistémica, organizado por la Sociedad de Terapia Sistémica de esa provincia. El mismo se lo denominó "Salud y Terapia Sistémica", y su lema fue: "La salud es responsabilidad de todos".

El propósito de este evento fue lograr la participación activa de la mayor cantidad de profesionales de Argentina y Chile. Esta participación comenzó con la elaboración del programa científico, el que se concretó a partir de una encuesta que se envió a las diferentes asociaciones y/o sociedades de Terapia Sistémica.

Las actividades científicas se dividieron en actividades plenarios y optativas. Las primeras incluían Mesas Redondas y Mesas de Trabajos Libres y las segundas Talleres de encuentro experiencial en Terapia Sistémica y Grupos de discusión.

Los temas de las Mesas Redondas fueron: "La familia como unidad de abordaje", "Los fracasos terapéuticos como elementos de aprendizaje", "Drogadicción y Familia", "Medicina y Terapia Familiar", "Familias con pacientes psicosomáticos", "Salud, Familia y Política Sanitaria".

Las mismas permitieron una integración de conceptualizaciones teóricas a la vez que experienciales; enriquecidas con los aportes de los disertantes y de los asistentes al Congreso. Fue muy relevante la presencia de médicos que trabajan en Medicina Familiar, como así también el enfoque planteado sobre la necesidad de incursionar en la "Salud" más que en la enfermedad, coincidente con el Tema del Congreso.

Por otro lado el ver que tanto terapeutas como médicos

INFORMACIONES

tomaron la familia como unidad de abordaje, quedó demostrado el importante impacto que el enfoque familiar tiene en las diversas teorías y en los diferentes campos del quehacer de los profesionales de la salud.

En los Talleres de Encuentro Experiencial, se abarcaron cuatro modelos: MRI, Whitaker, Andolfi y Estructural. Se realizó la presentación de cada uno en forma separada, dando lineamientos teóricos, complementando esto con video-tapes.

En las conclusiones de los mismos se comentó acerca de la dificultad que se enfrenta en la formación de terapeutas y el entrenamiento en cada uno de los modelos, destacándose que no obstante existir algunas carencias para llevar a cabo esto en el interior, la propia experiencia de grupos realizados hasta el momento en muchas provincias, es sumamente enriquecedora para el crecimiento de la Terapia Sistémica.

Los grupos de discusión giraron alrededor de diferentes temas donde se pudieron intercambiar experiencias concretas de cada lugar, sirviendo de verdaderos lugares de encuentro, en donde todos pudieron participar activamente. Con esto se cumplió uno de los objetivos primordiales del Congreso: analizar e intercambiar situaciones particulares de cada región.

En cuanto a los Trabajos Libres es de destacar que se presentaron varios, lo que refleja el gran desarrollo de la Terapia Sistémica en nuestro país como así también en Chile, a la vez que el nivel de los mismos nos da la pauta de la seriedad con que muchos terapeutas están trabajando e investigando.

Es importante recalcar que el hecho que este Congreso se realizara en el interior, en una provincia como San Juan, por disposición de la Federación Argentina de Terapia Sistémica, permitió al igual que en Mendoza y Santa Fe, demostrar una vez más la capacidad organizativa de las asociaciones del interior.

Para San Juan no fue fácil, el momento económico no era el mejor. Carl Whitaker estaba en la Argentina. Buenos Aires se inundó.

Pero se logró y en este Congreso se subió un nuevo escalón y crecimos. Los terapeutas sistémicos así lo hicimos posible.

– OBITUARIO –

RUTH BELLOTINI
(2-7-1937 – 16-8-1984)

En su doble condición de psicóloga y de médica, se destacó por su interés consecuente y seguimiento esforzado de sus pacientes, así como por la generosidad en compartir sus experiencias y real sentido de compañerismo con los distintos colegas con quienes convivió en la tarea terapéutica.

Colaboró desde sus inicios en la tarea asistencial de pacientes graves de la Clínica de J. García Badaracco, realizando trabajos junto a éste y a Noemí Jubert en el seguimiento del proceso terapéutico de pacientes psicóticos, organizando además el 1er. Simposio interno sobre terapias realizado en la Clínica. Se interesó además particularmente en la Psicoterapia de niños y en Psicodiagnósticos, formando parte del Departamento de Orientación Vocacional de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, junto a Irene Orlando y otros; del Gabinete del Colegio Pestalozzi, junto a Elías Widuscirsky, y realizando selección de alumnos y orientación a padres en el colegio Piaget.

Desarrolló un interés definido por intentar capitalizar aportes conceptuales de distintas escuelas de Psicoterapia, así como de considerar con igual respeto las muchas veces opuestas ópticas científicas acerca del cuerpo, la mente y la conducta. Junto a J. Granel y otros, realizó una serie de trabajos teóricos sobre coordinación de estas tres áreas (1969 - 1975); concentrándose también en el enfoque psicológico del tratamiento de la diabetes infantil y de afecciones neurológicas infantiles, siendo muy estimada su sensatez de criterio en grupos de trabajo que integró con Silvia Wasertreguer y otros; y con J. Castaño, respectivamente. Presentó trabajos sobre diabetes en la

OBITUARIO

Conferencia Argentina de Salud Mental y en las Jornadas Rioplatenses de Diabetes (1968).

Miembro activo de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar desde su formación, se caracterizó como una terapeuta familiar con participación contenedora de situaciones familiares graves, tanto de familias de pacientes psicóticos, como de familias de suicidas, accidentados y pacientes oncológicos. Realizó numerosas experiencias exitosas de coterapia, destacándose su funcionamiento en un rol complementario junto a A. Canevaro, R. Marcer, R. Gaspari, O. Czertok, J. E. Correa.

Desde 1980, y en un equipo de trabajo con R. Marcer, R. Gaspari y N. Jubert, se dedicó a ensayar líneas de integración teórica y técnica de recursos provenientes de distintas escuelas de Terapia Familiar.

El aporte al campo profesional de Ruth Bellotini es el de una iniciadora de movimientos y tareas integradoras, más que el de un constructor o continuador de obra. En este sentido pudo conectarse y conectar entre sí a profesionales de distintas escuelas y disciplinas, y constituirse en un buen ejemplo de la interdisciplinaridad en la formación y actividad profesional con que debe estar dotado un terapeuta familiar.

TERAPIA FAMILIAR realiza este póstumo homenaje a quien fue un gran ser humano y una querida y recordada amiga.

Dr. J. Correa

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

La Revista de Terapia Familiar publica dos números por año, es multidisciplinaria en el área de la familia con especial énfasis en la salud mental. Tiene como objetivo incrementar el conocimiento profesional de la problemática de la familia para mejorar la calidad de ayuda que la familia requiere.

Los trabajos son seleccionados sobre las bases de objetivos, claridad y contribución al área de la familia.

Artículos

— Los originales, por triplicado, deberán ser enviados al Director de la Revista, Dr. Alfredo Canevaro, Echeverría 1945, P. Baja, 1428 Capital Federal, República Argentina.

— La responsabilidad del contenido de los trabajos es del autor.

— No se paga honorarios por los trabajos aceptados.

— El editor se reserva el derecho de rechazar trabajos, devolverlos al autor para alguna modificación de forma o de someterlos a corrección de estilo.

— Los trabajos deben estar escritos a máquina y a doble espacio. Se debe presentar original y dos copias, también deben incluir un resumen lo más conciso posible, así como su traducción en inglés para su envío a revistas internacionales. Las tablas y gráficos que acompañen el trabajo deben ser claros a fin de permitir la máxima calidad de la reproducción fotomecánica.

— Incluir nombre completo del (los) autor (es), título profesional, dirección e Institución a la que pertenece.

— Bibliografía: Las referencias bibliográficas deben ceñirse a

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

las normas internacionales: 1 - Ordenadas alfabéticamente y numeradas correlativamente según su orden de aparición. 2 - Nombre completo del autor o de todos los autores, en caso de ser varios. 3 - Título completo del trabajo citado. 4 - Nombre abreviado de la Revista según Index Medicus (si el tema es médico). Número de Volumen o Volúmenes; referencia de primera y última página (en este orden), ciudad, editorial, año de publicación.

Ejemplos:

ASHBY, W. R. Introducción a la Cibernética (1956), Bs. Aires, Ed. Paidós, 1972

o

RUDRAUF, J., Ensayos sobre la dialéctica de los niveles de comunicación en la intervención terapéutica, TERAPIA FAMILIAR 1980, Vol. IV, No. 7/8, págs. 87-98, Buenos Aires, Argentina.

— Los autores de los trabajos publicados recibirán un ejemplar de la Revista.

— Los artículos deberán ser inéditos en lengua española.

SECRETARIA E INFORMES
de la Revista TERAPIA FAMILIAR
Marcelo T. de Alvear 2387
1122 - Capital Federal
Teléfono 83-6168

Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Carlos E. Sluzki, *Palo Alto, CA*

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, *CHRM., Rochester, N.Y.*, Edgar H. Auerswald, *Maui, Hawaii*, Michael Goldstein, *Los Angeles, Calif.*, Reuben Hill, *Minneapolis, Minn.*, Arthur G. Rosenthal, *Cambridge, Mass.*, Robert Ryder, *Storrs, CT*, Margaret T. Singer, *Berkeley, Calif.*, M. Duncan Stanton, *Philadelphia, Pa.*, Carl Whitaker, *Madison, Wis.*

FAMILY PROCESS, in continuous publication since 1962, is the definitive journal in the field of family psychotherapy. Original articles report on theory and practice of family treatment, research and training. In addition, regular departments of FAMILY PROCESS are devoted to reviews of books and audiovisual materials.

Among the many contributors in recent years have been *James Framo, Mara Selvini-Palazzoli, Paul Dell, Carl Whitaker, Bradford Keeney, Cloe Madanes, and M. Duncan Stanton.*

FAMILY PROCESS

149 East 78th Street
New York, N.Y. 10021

Gentlemen:

DATE _____

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS (U.S. funds drawn on a U.S. bank)

INDIVIDUAL SUBSCRIBERS
(paid by personal check)

☐ \$24.00 per year United States

☐ \$27.00 per year Canada &
Latin America

☐ \$30.00 per year All other countries

INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

☐ \$35.00 U.S.

☐ \$38.00 Canada &
Latin America

☐ \$42.00 All other countries

NAME _____

ADDRESS _____

CITY _____

STATE/COUNTRY _____

ZIP _____

ALL SUBSCRIPTIONS ARE ENTERED ON A CALENDAR YEAR BASIS

FICHA DE SUSCRIPCION

Sres. de Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección

Código Postal Localidad

Profesión

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Ediciones Terapia Familiar, No a la orden, por Australes doce.

C.C. No 94 - Sucursal 28 - Bs. As. - Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL **Argentina, 12 Australes**
Exterior u\$s 26.--

MAS GASTOS DE ENVIO

Este libro se terminó de imprimir en los
Talleres EDIGRAF S.A. Delgado 834,
Buenos Aires, República Argentina,
en el mes de agosto de 1985.